apm

2025

Rahmencurriculum

Professionalität und Kompetenz für die Pflege von Morgen.

Für

- Katarina -

- Henry -

- Roshni -

- Pavel -

- Samantha -

- Merve -

- Giuseppa -

#pflegevonmorgen

Inhalt

1 Prolog ... 3
2 apm-Rahmencurriculum ... 3
3 Theoretischer Begründungsrahmen zum Rahmencurriculum ... 4
4 Methodisches Vorgehen in der curricularen Entwicklung ... 5
5 Pflegedidaktische, berufswissenschaftliche und pflegetheoretische Grundlagen ... 7
6 Konstruktionsprinzipien ... 8
6.1 Situationsorientierung unter Integration der Prinzipien der Persönlichkeits-bzw. Subjektorientierung und Wissenschaftsorientierung ... 9
6.2 Kompetenzorientierung ... 11
6.2.1 Kompetenzverständnis ... 11
6.2.2 Berufliche Handlungskompetenz ... 12
6.3 Entwicklungslogik ... 13
6.4 Kompetenzentwicklung ... 13
6.5 Spiralförmigkeit ... 17
6.6 Verzahnung der theoretischen und praktischen Ausbildung ... 18
7 Formale Gestaltung des Rahmencurriculum ... 19
7.1 Lernfelder ... 19
7.2 Modulbeschreibungen: Inhalte/Situationsmerkmale/Inhaltliche Ausrichtung ... 100
8 Literaturverzeichnis ... 108
9 Anlagen ... 109
9.1 Abgleich curriculare Einheiten (CE) nach Rahmenlehrplan der Fachkommission §53PflBG und Lernfelder im Curriculum ... 109
9.2 Abgleich Lernfelder und Kompetenzbereiche I-V nach Anlage 6 PflAPrV im 1. und 2. AD 110
9.3 Abgleich Lernfelder und Kompetenzbereiche I-V nach Anlage 6 PflAPrV im 3. AD ... 113
9.4 Exemplarische Darstellung der spiralförmigen curricularen Konstruktion ... 116

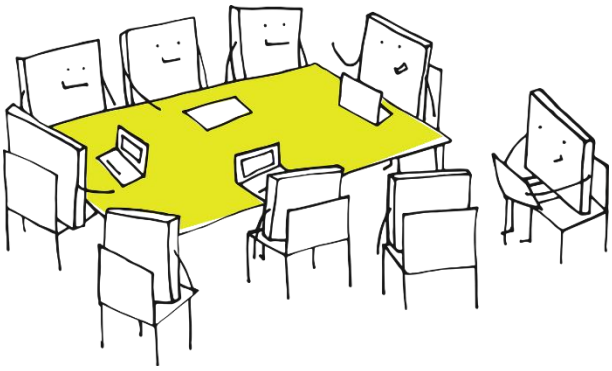
1 Prolog

Jeder Mensch hat das Recht auf eine fachgerechte und von qualifizierten Pflegefachpersonen ausgeführte Versorgung, unabhängig der Ursachen, die den Pflegebedarf herbeigeführt haben. Professionelle Pflege findet in verschiedenen ambulanten wie stationären Akut- und Langzeitpflegeeinrichtungen für Menschen aller Altersstufen und aus allen gesellschaftlichen und sozioökonomischen Kontexten statt. Pflegerisches Handeln ist dabei stets frei von Benachteiligung, Diskriminierung oder Bevormundung. Pflege orientiert sich am Subjekt – die individuellen Bedarfe jeder zu pflegenden Person sind maßgeblich für die Gestaltung professioneller Pflegeprozesse. Die Förderung von Gesundheit, der Erhalt von Selbstbestimmung und Autonomie, die Unterstützung im konstruktiven Umgang mit gesundheitlichen und sozialen Herausforderungen – all das ist Pflege. Dieses komplexe Berufsfeld bedingt hohe Kompetenzen in verschiedenen Bereichen und zusätzlich die Fähigkeit all diese situativ, individuell und zielgerichtet einsetzen zu können.

Eine qualitativ hochwertige theoretische und praktische Pflegefachausbildung ist daher von größter Bedeutung für den Erhalt und die Förderung gesamtgesellschaftlicher Gesundheit, Lebensqualität und Würde.

2 apm-Rahmencurriculum

Das vorliegende Rahmencurriculum zeichnet sich durch einen hohen Konkretisierungsgrad aus und bietet eine handhabbare, praxisnahe und wissenschaftlich basierte Grundlage für die Umsetzung der kompetenzorientierten Ausbildung zur Pflegefachperson. Es wird dabei sowohl eine bundesweit vergleichbare Ausbildungsqualität gewährleistet als auch Raum geschaffen, schulinterne Schwerpunkte zu setzen.



Das Rahmencurriculum ist dabei als ein Konzept zur Erstellung von Lehrplänen zu verstehen, das sich ständig weiterentwickelt. Die Inhalte der Ausbildung wurden direkt aus dem Berufsfeld der professionellen Pflege abgeleitet, basierend auf pflege- und bezugswissenschaftlichen Erkenntnissen. Aus diesen Inhalten wurden berufstypische Situationen identifiziert, die im Curriculum in konkrete Lernsituationen übersetzt werden. Es entstehen so Anlässe zum Lernen, die sich an der Pflegepraxis orientieren, dabei aber stets pflegewissenschaftlich aufbereitet und pflegedidaktisch sinnvoll konzipiert sind. Der situationsorientierte Ansatz zeigt die Inhalte der Ausbildung an wichtigen Beispielen und ermöglicht im exemplarischen Lernen die Entwicklung fachbezogener und persönlicher Kompetenzen. Auszubildenden erlernen im theoretischen Rahmen Regeln, Lösungsansätze

und Strategien, die sie an jedem Einsatzort und bei Menschen aller Altersgruppen anwenden können.

Die Entwicklung von Kompetenzen in der Ausbildung basiert vorrangig auf den Ansätzen der Subjektorientierung und Handlungsorientierung. Da sich Kompetenz zwangsläufig nur in der Performanz zeigt, trägt der handlungsorientierte Ansatz dem Anspruch einer kompetenzorientierten Ausbildung Rechnung. Die Auszubildenden werden am Lernort Schule in verschiedene, konkrete Situationen versetzt, die verstanden, analysiert, beurteilt, reflektiert und schließlich aktiv gestaltet werden sollen. Dazu ist die Orientierung am Subjekt unbedingt notwendig.

Kompetenz ist an das jeweilige Subjekt gebunden. Pflegekompetenz lässt sich also nur über Pflegefachpersonen in die Versorgungskontexte bringen. Und so wie sich professionelle Pflege nur an den Bedarfen des Subjektes orientieren kann, muss sich auch Bildung im Subjekt orientieren, um einen bedarfsgerechten und wirkungsvollen Bildungsprozess gestalten zu können. Das Rahmencurriculum bezieht sich daher in den ersten zwei Ausbildungsdritteln sehr stark auf Lernsituationen, die der Arbeits- und Lebensrealität der Auszubildenden entsprechen. Im dritten Ausbildungsdrittel werden dann Situationen kreiert, die teilweise weit außerhalb der Erlebens der meisten der Auszubildenden liegen. Hier sollen bisher erworbene Kompetenzen in komplexen Situationen erprobt und weiterentwickelt werden.

Unabdingbar zur Kompetenzentwicklung sind dabei Räume für Reflexion und Feedback. Erst in der Reflexion des eigenen Lernprozesses, der eigenen Entwicklung und eigener Potenziale kann sich Kompetenz bewusst entwickeln und damit in das konkrete Pflegehandeln übergehen.

3 Theoretischer Begründungsrahmen zum Rahmencurriculum

Die generalistische Ausbildung zur Pflegefachperson vereinte die bisherigen Ausbildungen der Gesundheits- und Krankenpflege, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie der Altenpflege in einem gemeinsamen Berufsabschluss. Ziel ist es, Pflegefachpersonen zu befähigen, Menschen aller Altersgruppen in unterschiedlichen Versorgungsbereichen professionell zu pflegen, zu begleiten und zu unterstützen.

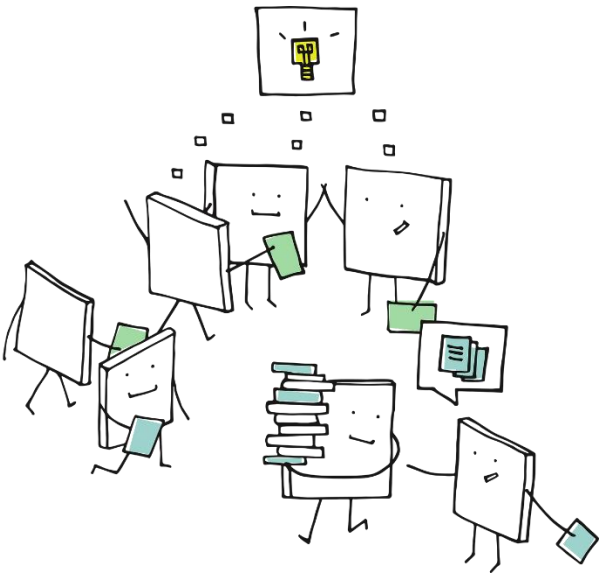
Das Ausbildungsziel nach § 5 PflBG beschreibt genau, was Pflegefachpersonen dementsprechend umsetzen sollen. Die Auszubildenden sollen lernen, Menschen aller Altersgruppen in verschiedenen Bereichen der Pflege prozessorientiert zu pflegen, zu begleiten und zu versorgen (§ 5 Abs. 1 PflBG). § 5 Abs. 2 PflBG nennt die Dimensionen der Maßnahmen professioneller Pflege in unterschiedlichen Bereichen der Gesundheitsversorgung. § 5 Absatz 3 des Pflegeberufegesetzes beschreibt genau, welche pflegerischen Aufgaben Auszubildende am Ende der Ausbildung sicher umsetzen sollen. Außerdem sollen die Auszubildenden während der Ausbildung ein professionelles und ethisch begründetes Pflegeverständnis sowie ein klares berufliches Selbstbild entwickeln und festigen (§5 Abs. 4 PflBG).

Die Vorbehaltsaufgaben definieren einen klar abgegrenzten Verantwortungsbereich, in dem Pflegefachpersonen eigenständig handeln dürfen. Sie beziehen sich im Wesentlichen auf den Pflegeprozess und sichern dessen Qualität und Fachlichkeit. Die Vorbehaltsaufgaben basieren auf dem Pflegeprozess. Nach ausführlichen Diskussionen von Pflegewissenschaftler:innen und Jurist:innen sind sich die Expert:innen heute einig, dass die Pflegeplanung in den Vorbehaltsaufgaben inbegriffen ist. Die Durchführung der Pflege gehört aus fachlicher Sicht dagegen nicht dazu, so hat es auch der Gesetzgeber festgelegt. Diese Aufgaben können an Pflegeassistenzberufe übertragen werden. So ist weiterhin eine sinnvolle Arbeitsteilung möglich, die auf den Qualifikationen der Beteiligten basiert. Denn nicht alle Pflegesituationen benötigen die Kompetenz einer ausgebildeten Pflegefachperson. Pflegeassistenzpersonen dürfen deshalb weiterhin viele Aufgaben übernehmen, aber immer unter der Anleitung und Verantwortung von Pflegefachpersonen.

4 Methodisches Vorgehen in der curricularen Entwicklung

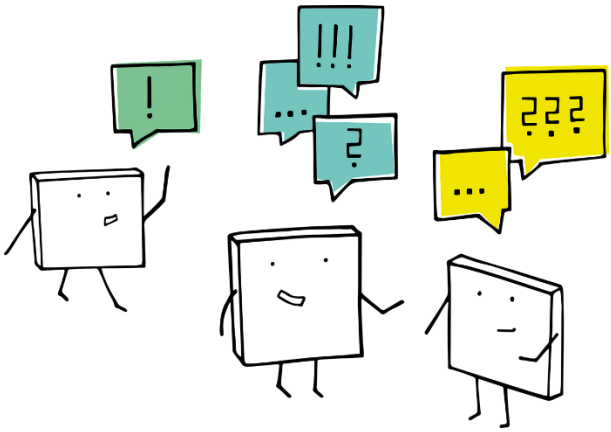
Aufgrund der Anzahl an Pflegeschulen war es möglich, insgesamt fünf Vertreter:innen der apm-Pflegeschulen in den Entwicklungsprozess einzubeziehen. Zu diesem Zweck wurde eine Arbeitsgruppe (AG Curriculum) gebildet, die sich in mehreren, teils einwöchigen Workshops zusammenfand. Darüber hinaus arbeiteten die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe in zusätzlichen Terminen ohne Moderation an der Überarbeitung und inhaltlichen Ergänzung der vorgeschlagenen Lernfelder sowie berufstypischen Situationen. Diese überarbeiteten Vorschläge wurden in den folgenden Workshopterminen in der moderierten Gesamtgruppe diskutiert und konsensual abgestimmt.

Die Entwicklung des Rahmenlehrplans orientierte sich dabei an den vier Phasen der Curriculumentwicklung nach Knigge-Demal (2001, in Anlehnung an Siebert 1974). In der ersten Phase wurde ein Begründungsrahmen formuliert sowie übergeordnete Bildungsziele festgelegt. Dazu zählte auch die Definition von Leit- und Grobzielen, die als Grundlage für die gesamte Planung dienten. Hierbei wurden insbesondere die Rahmenpläne der Fachkommission sowie die curricularen Einheiten dieser Pläne berücksichtigt. Die zweite Phase umfasste eine differenzierte Analyse, die mehrere Dimensionen einbezog. Einerseits wurden relevante Handlungsfelder untersucht, andererseits die Lernvoraussetzungen der Zielgruppe analysiert. Ergänzend flossen Erkenntnisse aus den zugrunde liegenden wissenschaftlichen Disziplinen ein.



Zur Erfassung und Berücksichtigung der Anforderungen der Berufswirklichkeit, wurden Literaturrecherchen eingebracht. Es wurde gezielt

Fachliteratur ausgewertet, um aktuelle Entwicklungen im Pflegeberuf zu berücksichtigen. Dazu gehörten u.a. Themen wie die Aufgabenfelder der Pflegefachpersonen, insbesondere wurden §4 und §5 PflBG berücksichtigt bzw. analysiert, Veränderungen im Qualifikationssystem, steigende Versorgungsanforderungen durch steigende Pflegebedürftigkeit in allen Altersstufen, Pflegeklassifikationen, die zunehmende Digitalisierung und Technisierung in der Pflege, der Pflegebedürftigkeitsbegriff sowie Aspekte von Diversity. Die Critical-Incidents-Methode fand ebenso bei der Entwicklung der Module der Lernfelder, Anwendung. Auszubildende, Praxisanleiter:innen und Pflegefachpersonen wurden befragt, ob sie sich an Situationen in einem bestimmten Handlungsfeld erinnern, die sie besonders positiv oder negativ geprägt haben. Die Analyse solcher „kritischen Ereignisse“ ermöglichte es, berufstypische Situationen zu identifizieren. Lehrkräfte, die aktiv am Entwicklungsprozess beteiligt waren, haben außerdem aktuelle inhaltliche Schwerpunkte aus den Pflegeeinrichtungen eingebracht.



Die Pflegefachausbildung muss sich am aktuellen pflegewissenschaftlichen Erkenntnisstand orientieren. Für das apm-Rahmencurriculum wurden daher wissenschaftlich fundierte Kenntnisse recherchiert und unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt. Dazu zählen Erkenntnisse zur Lösung pflegerischer und gesundheitlicher Probleme, zur Interpretation und Verständigung sowie zur Reflexion von Widersprüchen und Spannungsfeldern. Professionelle Pflege wird dabei als interpersonaler Beziehungs- und Problemlösungsprozess verstanden, der gegenseitige Anerkennung respektiert und fördert. Pflegefachpersonen tragen die Verantwortung, Bedingungen für diese wechselseitige Anerkennung zu sichern und dabei Risiken wie Misshandlung, Entrechtung oder Entwürdigung zu reflektieren und ihnen entgegenzuwirken. Neben rationalem Handeln spielen auch körperlich-leibliche und intuitive Prozesse eine zentrale Rolle. Die Ausbildung soll Auszubildende befähigen, unterschiedliche Wissensformen zu verknüpfen, Situationen aus der Praxis angemessen zu beurteilen und diese Urteile methodisch zu überprüfen.

In der dritten Phase erfolgte die eigentliche Curriculumentwicklung. Dabei wurden unter anderem Lernfelder, berufstypische Situationen, Lernziele und Kompetenzen festgelegt sowie begründete, aufeinander aufbauende Lernsituationen strukturiert geplant.

Die vierte Phase beinhaltete schließlich die Implementierung des Curriculums, welche im Reallabor-Format entwickelt und durchgeführt wurde. Im Vorfeld der Implementierung wurde ein pädagogisches Kompetenzteam formiert, das aus mindestens einer Vertreterin oder einem Vertreter jeder apm-Pflegeschule besteht. Diese Personen übernehmen an ihren jeweiligen Schulen zentrale Aufgaben im Bereich der Curriculumentwicklung und kollegialen Beratung innerhalb der

Lehrkörper. Einige der kontinuierlich mitarbeitenden Mitglieder der Curriculum-AG fungierten zusätzlich als Multiplikator:innen, um die curricularen Überarbeitungen in den Schulen zu implementieren.

Vier Modellstandorte dienten im Rahmen der Modellphase ab April 2025 der Erprobung revidierter curricularer Strukturen unter realen Bedingungen. Regelmäßige Evaluationen (sowohl summativ als auch formativ) lieferten Erkenntnisse zu weiteren Unterstützungsbedarfen, Potenzialen zur weiteren Überarbeitung und Stärken der curricularen Struktur. In zwei weiteren Kohorten erfolgt die Implementierung an weiteren Schulen. Jede Kohorte wird zentral evaluiert. Daraus resultierende Befunde dienen jeweils der Überarbeitung sowohl des Implementierungsprozesses als auch der Ausgestaltung des jeweiligen schulinternen Lehrplans.

Es wird eine kontinuierliche Überarbeitung des Rahmencurriculums angestrebt, welches aktuellen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen gerecht wird und die Lebens- und Arbeitsrealität der Auszubildenden weiterhin plausibel abbildet. Dieser zugrunde liegen kollegiale und kollaborative Ansätze innehrlab der gesamten apm, die Synergieeffekte ermöglichen sollen und durch die hohe Kompetenz des Lehrkörpers zu einer belastbaren und multiperspektivisch entwickelten curricularen Konstruktion führen.

5 Pflegedidaktische, berufswissenschaftliche und pflegetheoretische Grundlagen

Die vorliegende curriculare Konstruktion orientiert sich an den Ausbildungszielen und versteht Kompetenzen als dynamische Konstrukte, die gezielt auf die Anforderungen der beruflichen Praxis und die Ausbildungsziele abgestimmt sind.

Die Projektgruppe entschied sich bewusst dafür, auf eine eigenständige Ausformulierung eines pflegewissenschaftlichen sowie pädagogisch-didaktischen Begründungsrahmens zu verzichten. Dieser Entschluss basiert auf der inhaltlichen Übereinstimmung mit den Ausführungen der Fachkommission nach § 53 PflBG, insbesondere in Bezug auf das Pflege- und Berufsverständnis, die didaktisch-pädagogischen Grundsätze, die Pflegeprozessverantwortung sowie die Entwicklungslogik und Konstruktionsprinzipien. Eine plakative Wiederholung oder 1:1-Übernahme dieser Konzepte in das schulinterne apm-Rahmencurriculum wurde bewusst vermieden. Stattdessen liegt der Fokus darauf, die curricularen Inhalte praxisnah und kompetenzorientiert zu gestalten, sodass sie sich konsequent an den Anforderungen des Pflegeberufs sowie den individuellen Lernprozessen der Auszubildenden ausrichten.

Bei den pflegedidaktischen Überlegungen stehen drei zentrale Ziel- bzw. Bildungsdimensionen im Mittelpunkt:

1. die Fähigkeit, pflegerische und gesundheitsbezogene Problemlagen wissenschaftlich fundiert zu erklären und instrumentell zu lösen,

2. die Fähigkeit zum Selbst- und Fremdverstehen sowie zur kommunikativen Verständigung und
3. die Fähigkeit zur kritischen Reflexion durch Denken in Widersprüchen.

Im Rahmen der Pflegefachausbildung sollen Berufslernende nicht nur fachliches Wissen in diesen Dimensionen erwerben, sondern auch dazu befähigt werden, die jeweils passenden Erkenntnismethoden anzuwenden. Für die Gestaltung von Lernsituationen bedeutet das, dass diese gezielt so ausgewählt und aufbereitet werden müssen, dass sie die Aneignung dieser Bildungsdimensionen unterstützen. Gleichzeitig sind Unterrichtsmethoden einzusetzen, die geeignet sind, spezifische Erkenntnisse zu ermöglichen. Dabei ist ein enger Zusammenhang zwischen Erkenntnisinteresse und den eingesetzten Methoden sicherzustellen.

Grundlegend für das apm-Rahmencurriculum ist die Subjektorientierung. Lernen wird dabei als ein selbstgesteuerter Prozess verstanden, der weniger durch reine Belehrung als vielmehr durch Anknüpfen an bestehendes Vorwissen angeregt wird. Ziel ist es, die Berufslernenden zu motivieren, ihr Vorverständnis aktiv zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Denn Kompetenzentwicklung ist immer an das jeweilige Individuum gebunden. Lernprozesse orientieren sich an persönlichen Voraussetzungen, Wahrnehmungen, Erfahrungen und biografischen Prägungen der Auszubildenden. Eine subjektorientierte Didaktik nimmt die Lernenden als aktive Subjekte ernst und fördert Eigenverantwortung sowie Selbststeuerung. In der Rolle der Lernprozessbegleitung obliegt es den jeweiligen Lehrkräften durch pädagogische Diagnostik, individuelle Förderung und Gestaltung von Lernangeboten die Bildungsprozesse der Berufslernenden möglichst konstruktiv und im individuell definierten Bildungserfolg mündend zu gestalten.

6 Konstruktionsprinzipien

Ziel der Ausbildung ist der Erwerb und die Entwicklung von beruflicher Handlungskompetenz nach dem PflBG und der PflAPrV. Die Kompetenzen der Anlagen 1 und 2 PflAPrV sind „anforderungsorientiert formuliert und deutlich auf komplexe Pflege- und Berufssituationen ausgerichtet (Beyer et al., 2024). Wir fassen die Kompetenzen als an die Ausbildungsziele angepasste Konstrukte auf. Die Rahmenpläne der Fachkommission gemäß § 53 PflBG definieren Kompetenz als die Fähigkeit und Bereitschaft, in komplexen Pflege- und Berufssituationen professionell zu handeln und sich kontinuierlich persönlich sowie fachlich weiterzuentwickeln. Grundlage ist dabei ein dispositionales Kompetenzverständnis: Kompetenzen gelten als individuelle Dispositionen – also als Voraussetzungen für Handeln –, die in selbstorganisierten und subjektbezogenen Bildungsprozessen erworben oder erweitert werden (Erpenbeck %& von Rosenstiel, 2003). Sie sind personengebunden, konkretisieren sich in den Anforderungen beruflicher Pflegepraxis und entwickeln sich im beruflichen Handlungsfeld stetig weiter (Bundesinstitut für Berufsbildung, 2020).

Das apm-Rahmencurriculum umfasst 17 Lernfelder, die in verschiedene Module unterteilt sind und den jeweiligen Ausbildungsabschnitten zugeordnet werden. Diese Module enthalten

Angaben zu Kompetenzen und Zielen, Situationsmerkmalen sowie Vorschläge für konkrete Lernsituationen.

Aus den Zieldimensionen des § 5 PflBG und § 2 PflAPrV leiten sich folgende Prinzipien für die Erstellung eines schulinternen Curriculums ab:

- Kompetenzorientierung,
- Lebenslanges Lernen (dazu gehören Lernfähigkeiten, Wissen weiterzugeben und sich ständig weiterzuentwickeln)
- Verbindung von Theorie und Praxis
- Situatives Lernen in verschiedenen Bereichen der Pflege
- Pflege von Menschen jeden Alters
- typische Pflegeaufgaben, zum Beispiel die Verantwortung für den Pflegeprozess (vorbehaltene Aufgaben)
- selbstständiges und vollständiges Handeln im Rahmen professioneller Pflege, die auf Prozessen basiert
- Bezug zur Wissenschaft
- professionelles und ethisch verantwortliches Verständnis von Pflege

6.1 Situationsorientierung unter Integration der Prinzipien der Persönlichkeits-bzw. Subjektorientierung und Wissenschaftsorientierung

Das Ziel des Rahmencurriculums ist der Aufbau anwendungsbezogenen Wissens und beruflicher Handlungskompetenz. Grundlage bildet das Prinzip der Situations- und Handlungsorientierung. Berufstypische Situationen stehen dabei im Mittelpunkt der Lernsituationen und werden mit pflegewissenschaftlichem sowie interdisziplinärem Wissen bearbeitet. Die Struktur des Curriculums orientiert sich auf Makroebene konsequent am Situationsprinzip. Berufliche Situationen werden dazu anhand von Merkmalen wie Handlungsanlässen, pflegerischen Handlungsmustern, Settings und relevanten Kontextbedingungen beschrieben.

Im Sinne der generalistischen und kompetenzorientierten Ausbildung sollen Kompetenzen exemplarisch an bestimmten Lebensphasen oder Versorgungsbereichen entwickelt und anschließend auf andere Kontexte übertragen werden. Dafür werden im Unterricht gezielt Transferkompetenzen gefördert. Zudem werden im Curriculum die Situationstypen nach Kirkevold (2002) einbezogen, die unterschiedlichen Anforderungen an das pflegerische Handeln stellen. Konkret bedeutet dies, dass akute Situationen, die schnelles und koordiniertes Eingreifen erfordern, problematische Situationen, nicht-problematische Situationen, welche stabilen und standardisierten Abläufen folgen sowie problemidentifizierende Situationen die berufstypischen Situationen der Module kennzeichnen.

Auch Pflegeklassifikationssysteme wurden in der Situationsorientierung berücksichtigt, um die berufstypischen Situationen zu erfassen. Das European Nursing care Pathways (ENP) ist ein anerkanntes Pflegeklassifikationssystem, das seit seiner Einführung im Jahr 1989 kontinuierlich weiterentwickelt wird. Es dient der Standardisierung pflegerischer Dokumentation und Kommunikation und stellt eine sektorenübergreifende, professionelle Fachsprache für Pflegefachpersonen bereit. Ein wesentliches Merkmal von ENP ist die konkrete und spezifische Beschreibung pflegerischer Situationen. Diese finden sich in der sogenannten ENP-Praxisleitlinie, die pflegerelevante Diagnosen, Ziele und Maßnahmen klar strukturiert abbildet (Wieteck, 2023). Dadurch wird eine einheitliche und nachvollziehbare Pflegeplanung ermöglicht, unabhängig von Einrichtung oder Versorgungsbereich.

Auch die weiteren curricularen Prinzipien, Persönlichkeits- bzw. Subjektorientierung und Wissenschaftsorientierung, werden innerhalb der Module umgesetzt. Das Persönlichkeitsprinzip zeigt sich darin, dass Auszubildende angeregt werden, ihre eigenen Erfahrungen, Werte und Entscheidungen kritisch zu reflektieren und ihre Selbstlernkompetenz weiterzuentwickeln.

Kompetenz ist untrennbar mit dem Individuum verbunden, sie entsteht, entwickelt sich und manifestiert sich im subjektiven Erleben und Handeln der einzelnen Auszubildenden. In diesem Sinne ist Kompetenz stets individuell zu verstehen und lässt sich nicht losgelöst vom jeweiligen Subjekt betrachten (Olbrich, 2023). Jede:r Auszubildende bringt eigene Erfahrungen, Werthaltungen, Motivationen sowie biografisch geprägte Sichtweisen mit, die den Lernprozess wesentlich beeinflussen.

Die subjektive Realität der Auszubildenden, also ihre persönlichen Voraussetzungen, Wahrnehmungen und Bedeutungszuschreibungen, bilden die zentrale Ausgangslage für didaktisches Handeln. Lernprozesse können daher nicht einfach „von außen“ gesteuert oder standardisiert werden, sondern müssen die Individualität der Auszubildenden ernst nehmen und darauf aufbauen. Dies erfordert eine Lernumgebung, die Selbststeuerung, Eigenverantwortung und persönliche Entwicklung fördert. Im Kontext der Kompetenzentwicklung verliert der soziale Vergleich, etwa durch normierende Beurteilungen, an Bedeutung: nicht der Vergleich mit anderen, sondern der individuelle Lernfortschritt und die subjektive Auseinandersetzung mit Anforderungen stehen im Vordergrund. Statt Defizite zu markieren, sollen viel mehr Potenziale erkannt und individuelle Lernwege unterstützt werden. Eine subjektorientierte Didaktik nimmt die Auszubildenden somit als aktive, selbstgestaltende Subjekte ernst und schafft die Voraussetzungen für nachhaltiges, persönlich bedeutsames Lernen.

Die Wissenschaftsorientierung spiegelt sich vor allem in der Auswahl aktueller pflegewissenschaftlicher Inhalte wider, wie etwa Expertenstandards, Pflegediagnosen oder Theorien. Zusätzlich werden ergänzende Wissensgrundlagen aufgeführt, um den Auszubildenden ein Orientierungswissen zu vermitteln, das hilft, situativ erarbeitetes Wissen in fachsystematische Zusammenhänge einzuordnen.

6.2 Kompetenzorientierung

Das Prinzip der Situationsorientierung fördert den Erwerb umfassender beruflicher Handlungskompetenz. Die in den Lernfeldern angestrebten Kompetenzen gemäß den Anlagen 1 und 2 der PflAPrV werden zu Beginn jedes Moduls, teilweise operationalisiert, beschrieben und mit den spezifischen Situationsmerkmalen des Moduls verknüpft. Diese einleitende Kompetenzbeschreibung soll den Lehrkräften einen schnellen und übersichtlichen Einblick geben, welche Kompetenzen in der jeweiligen berufstypischen Situation vermittelt werden sollen. Eine tabellarische Zusammenfassung der Kompetenzübersichten zu allen Lernfeldern findet sich in den Anlagen.

Neben den Kompetenzen, die langfristige Wirkungen des Lernens abbilden, werden im Rahmencurriculum Lernziele beschrieben. Die Lernziele benennen das unmittelbar nach einem Modul erwartete Lernergebnis. In ihnen sind methodische und inhaltliche Aspekte verschränkt, sie sollen den Lehrkräften, Anhaltspunkte zur Gestaltung der Lernsituation geben.
Die Lernzieltaxonomie nach Anderson und Krathwohl (2001) dient der systematischen Beschreibung der Kompetenzentwicklungsstufen.

6.2.1 Kompetenzverständnis

Das Rahmencurriculum basiert auf einem „dispositionalen Kompetenzverständnis“ (Saul & Jürgensen, 2021, S. 34). Kompetenzen sind demnach immer an Personen gebunden. Sie zeigen sich in den Anforderungen des Berufsalltags und entwickeln sich durch praktische Erfahrungen weiter. Voraussetzungen für berufliches Handeln entstehen, wenn Auszubildende bestimmte Aufgaben selbst ausführen. Dabei entsteht neues Entwicklungspotenzial.

Diese inneren Voraussetzungen, also die Kompetenzen, kann die Lehrkraft nicht direkt beobachten. Sie können im Handeln der Auszubildenden sichtbar werden. Durch eine genaue Analyse dieser Handlungen können Lehrkräfte Rückschlüsse auf die Kompetenzen der Auszubildenden ziehen. Das heißt: Nicht nur die Handlung selbst ist wichtig, sondern vor allem deren Reflexion und Begründung. Zum Beispiel können Auszubildende in Gesprächen erklären, warum sie wie gehandelt haben und Angaben zu alternativen Handlungsmöglichkeiten machen. Besonders in der Pflegepraxis lassen sich pflegerische Handlungen gut beobachten und später in Reflexionsgesprächen analysieren. Wenn Auszubildende immer wieder mit neuen Situationen umgehen und diese reflektieren, entwickeln sie ihre Kompetenzen weiter. So entsteht ein wachsendes Wissen darüber, wie in verschiedenen Situationen gehandelt werden kann.

Am Lernort Schule werden Übungen in simulativen Lernsituationen durchgeführt. Dabei können Auszubildende Pflegehandlungen üben, ausprobieren und vorbereiten. Im theoretischen und praktischen Unterricht zeigt sich durch den Wissenstransfer, welche neuen Inhalte und Kompetenzen die Auszubildenden erworben haben. In der Praxisbegleitung beobachten die Lehrkräfte die Auszubildenden bei Pflegehandlungen. Danach findet ein Reflexionsgespräch statt, in dem die Handlung gemeinsam ausgewertet wird. So können Lehrkräfte auch beurteilen, wie gut die Auszubildenden ihr theoretisches Wissen auf echte Pflegesituationen übertragen können.

6.2.2 Berufliche Handlungskompetenz

Wenn Auszubildende in der Pflege mehr Verantwortung übernehmen, entwickeln sie Schritt für Schritt ihr „Veränderungspotenzial“. Dieses entsteht, wenn sie in echten Pflege- und Berufssituationen handeln dürfen. Damit Veränderungen möglich sind, müssen sie zuerst verstehen, wie sie bisher gehandelt haben. Durch Introvision, Reflexion und Kommunikation über ihr eigenes Handeln bewerten Auszubildende ihre Arbeit und überlegen, wie sie sich in den Pflegealltag einbringen können. Dabei erkennen sie auch ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten. Sie entwickeln ein Gefühl der Zugehörigkeit, können sich mit dem Beruf identifizieren und erleben Gemeinschaft mit anderen.

Der Aufbau von reflexiver Handlungsfähigkeit ist im Curriculum in allen Lernfeldern hinterlegt. Lehrkräfte unterstützen den Prozess durch Aufzeigen von Reflexionsmöglichkeiten und Anleitung innerhalb reflexiver Prozesse.

6.3 Entwicklungslogik im rechtlichen Kontext

Die Module sind jeweils einem der drei Ausbildungsdrittel zugeordnet und in einem Verlaufsplan angeordnet. Ein Austausch zwischen den Ausbildungsdritteln ist nicht vorgesehen, da die Module inhaltlich und im Anforderungsniveau aufeinander aufbauen. Zudem orientieren sie sich an den rechtlichen Grundlagen (Anlagen 1 und 2 PflAPrV). In Anlage 1 PflAPrV sind die zum Zeitpunkt der Zwischenprüfung nachzuweisenden Kompetenzen angegeben und in Anlage 2 PflAPrV die Kompetenzen für die staatliche Prüfung. Zusammengefasst: Anlage 1 PflAPrV bildet das Kompetenzniveau für die Zwischenprüfung § 7 PflAPrV nach § 6 Abs. 5 PflBG ab und Anlage 2 PflAPrV bildet das Kompetenzniveau für die staatliche Prüfung nach § 9 PflAPrV zur Pflegefachperson Anlagen 3 und 4 bilden das Kompetenzniveau für die staatliche Prüfung nach §§ 26, 27 PflAPrV zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder zum Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger ab bzw. das Kompetenzniveau für die staatliche Prüfung nach §§ 28, 29 PflAPrV zur Altenpflegerin oder zum Altenpfleger ab.

Die Lernfelder erstrecken sich über die drei Jahre der Ausbildung. Dabei werden Themen im Ausbildungsverlauf mehrfach auf ansteigendem Niveau angeboten. Die Lernfelder teilen sich in die ersten beiden Ausbildungsdrittel bis zur Zwischenprüfung und in das dritte Ausbildungsdrittel für die staatliche Prüfung auf. Entlang dieser Entwicklungslogik ist das Curriculum spiralförmig und fächerintegrativ gestaltet worden.

6.4 Kompetenzentwicklung

Um die Kompetenzen der Auszubildenden Schritt für Schritt zu entwickeln, steigt der Schwierigkeitsgrad der Module systematisch an. Grundlage dafür ist das Kompetenzmodell nach Olbrich, das unterschiedliche, hierarchisch angelegte Stufen beschreibt. Von regelgeleitetem über situativ-beurteilendes bis hin zu reflektierendem und aktiv-ethischem Handeln baut sich Kompetenz beruflich Pflegender dementsprechend auf. Pflegekompetenz wird hier als die Fähigkeit verstanden, zunehmend mehr Kontextfaktoren in die Urteilsbildung einzubeziehen und situationsgerecht zu handeln. Auch die soziale Kompetenz soll im Verlauf der Ausbildung wachsen, indem Auszubildende komplexere Perspektiven und Rollen übernehmen.

Abbildung 1: Kompetenzentwicklungsmodell nach Olbrich

*„**Regelgeleitetes Handeln** basiert auf Fachwissen und der praktischen Anwendung gelernter Methoden. Es vollzieht sich nach den geltenden Normen, Standards und allgemeiner wie spezieller Grundsätze. Kennzeichnend ist ein routinemäßiges Handeln, das in der Regel nicht reflektiert wird, jedoch entlastend für die Pflegenden wirkt und effektives Pflegehandeln ermöglicht.*

***Situativ-beurteilendes Handeln** basiert auf einer umfassenden Wahrnehmungs- und Beurteilungskompetenz, die die individuelle und einzigartige Lebenssituation der Patient:innen berücksichtigt und die wesentlichen Aspekte einer Situation erfasst und Prioritäten setzen kann. Dieses situativ-beurteilende Handeln zeigt sich in der Pflegeplanung und in der Gestaltung des Pflegeprozesses.*

***Reflektierendes Handeln** schließt nicht nur die Reflexion der Situation, sondern auch die Selbstreflexion der Pflegenden mit ein. Die Pflegeperson bringt persönliche Anteilnahme in das Pflegegeschehen hinein und versetzt sich in die Gefühlslage der zu pflegenden Menschen. Dies erfordert neben einer hohen Fähigkeit zur Empathie auch kommunikative Kompetenzen.*

Aktiv-ethisches Handeln *gründet auf der Ichstärke und Wertorientierung der Pflegenden, die sich empathisch, kreativ und engagiert für eine gute Pflege und das Wohl der Patient:innen insbesondere in ethischen Konfliktsituationen einsetzen.*" (Laußer, 2023).

Dabei ist anzumerken, dass die Kompetenzentwicklungsstufe des aktiv-ethischen-Handelns nach Abschluss der Ausbildung, also im Verlauf der beruflichen Tätigkeit als Pflegefachperson erworben werden soll. Im Zuge lebenslangen Lernens soll auf die, innerhalb der Ausbildung ausgeprägten Kompetenzen weiter aufgebaut werden.

Das bedeutet, dass die Lernsituationen im Unterricht im Laufe der Ausbildung anspruchsvoller werden. Die Fachkommission nach §53 PflBG fordert, dass die Curricula spiralförmig aufgebaut sind. Die Kriterien der Fachkommission(Pflegebedürftigkeit der Menschen nimmt zu; die Situationen, in denen gehandelt werden muss, werden vielfältiger; die beteiligten Personen erleben dabei Situationen, die z. B. Unsicherheit, Abhängigkeit oder schwierige Entscheidungen mit sich bringen können; neue Handlungsmöglichkeiten; usw.) wurden für das vorliegende Curriculum übernommen und in sechs Perspektiven konkretisiert bzw. erweitert (siehe Abb. 2):

1. Perspektive der Auszubildenden mit Fokus auf das eigene Erleben,
2. Perspektive der Pflegenden mit Fokus auf pflegerische Maßnahmen bei Menschen in stabilen Pflegesituationen,
3. Perspektive der Pflegenden mit Fokus auf pflegerische Maßnahmen bei Menschen in instabilen Pflegesituationen,
4. Perspektive der Pflegenden mit Fokus auf das intra- und interprofessionelle Team,
5. Perspektive der Pflegenden mit Fokus auf Bezugspersonen und
6. Perspektive der Pflegenden mit Fokus auf herausfordernde Situationen.

Ein Großteil der Module beginnt mit einer Lernsituation, die explizit die Perspektive der Auszubildenden in den Blick nehmen. Daran schließen sich eine oder mehrere Module aus der Perspektive der Pflegenden an, wobei der Fokus auf stabile und instabile Situationen gelegt wird. Danach folgen Module, die das intra- und/oder interprofessionelle Team in den Blick nehmen.

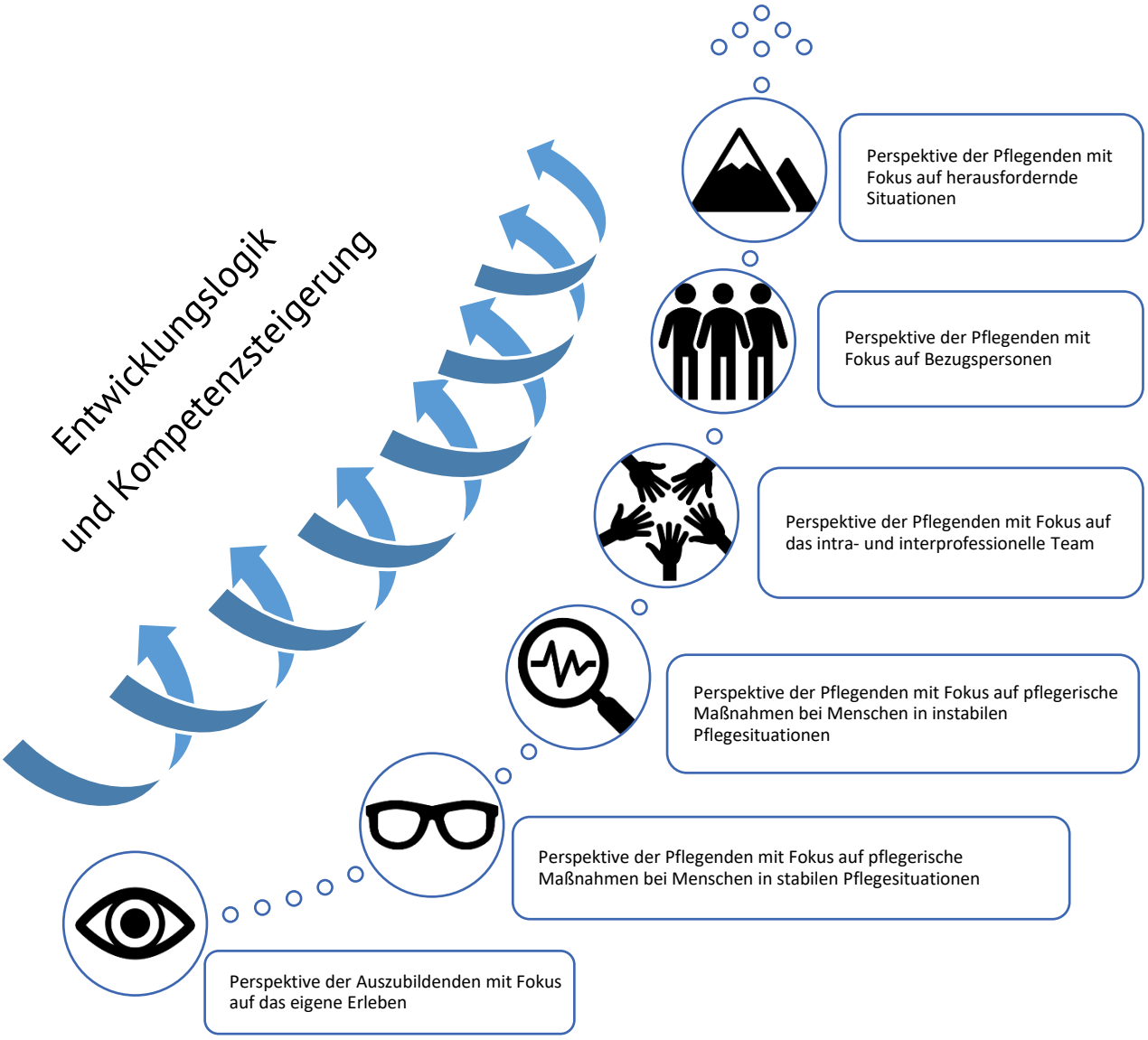


Abbildung 2 Kriterien zur Komplexitätssteigerung im Curriculum (eigene Darstellung)

Anschließend wird in anderen Modulen der Fokus auf die Bezugspersonen gelegt. Den Abschluss bilden Module, bei der herausfordernde Situationen im Mittelpunkt stehen. Es gilt zu berücksichtigen, dass die Reihenfolge „Fokus Bezugspersonen“ und „Fokus herausfordernde Situationen“ flexibel gehalten wurde. Dies geschah, um zu vermeiden, dass die Auszubildenden in einem Theorieblock nur mit Modulen konfrontiert werden, die alle auf „herausfordernde Situationen“ fokussiert sind. So werden in einigen Modulen erst herausfordernde Situationen in den Blick genommen, ehe dann die Bezugspersonen fokussiert werden.

6.5 Spiralförmigkeit

Die spiralförmige Struktur der kompetenzorientierten generalistischen Ausbildung zur Pflegefachperson stellt ein zentrales Prinzip zur nachhaltigen Entwicklung beruflicher Handlungskompetenz dar. Inhalte und Themen werden dabei nicht einmalig, sondern wiederholt aufgegriffen - jeweils auf einem höheren Komplexitätsniveau und in erweiterten Zusammenhängen (siehe Abb. 2). Durch diese progressive Vertiefung können die Auszubildenden bereits erworbene Kenntnisse festigen, mit neuen Inhalten verknüpfen und in zunehmend anspruchsvolleren Situationen anwenden.

Im Curriculum zeigt sich dies unter anderem durch fächerintegrative Unterrichtseinheiten, in denen Wissen aus verschiedenen Disziplinen verknüpft wird, um ein umfassenderes Verständnis pflegerischer Zusammenhänge zu ermöglichen. Gleichzeitig steigt mit dem Fortschreiten der Ausbildung der Komplexitätsgrad der Handlungs- und Lernsituationen. Die Zahl der beteiligten Personen nimmt zu, ebenso die Anzahl der relevanten Pflegediagnosen und die Vielfalt der zu berücksichtigenden Perspektiven und Haltungen. Auch der Umgang mit zunehmend divergierenden Haltungen sowie Einstellungen und Werten jenseits der mehrheitsgesellschaftlichen Vorstellung kennzeichnen den zunehmenden Grad an Komplexität der Lernsituationen.

Die Konfrontation mit Krisen- und Ausnahmesituationen wird im Verlauf der Ausbildung systematisch eingebunden. Diese stellen besondere Herausforderungen dar, die ein hohes Maß an Flexibilität, Reflexionsfähigkeit und ethischem Urteilsvermögen erfordern. Die spiralförmige Didaktik bietet hier den notwendigen Rahmen, um solche Anforderungen schrittweise bewältigen zu lernen und die (berufliche) Handlungskompetenz kontinuierlich weiterzuentwickeln. Exemplarische Darstellungen zur spiralförmigen Konstruktion der Module finden sich im Anhang (9.4).

6.6 Verzahnung der theoretischen und praktischen Ausbildung

Der theoretische und praktische Unterricht wechselt sich gezielt mit der praktischen Ausbildung ab (§ 1 Abs. 3 PflAPrV). Dieses Wechselspiel hat zum Ziel, dass die Auszubildenden den im Unterricht aufbereiteten Stoff mit den praktischen Erfahrungen verbinden und weiterentwickeln können. Fachwissen, Erkenntnisse über eigene Wahrnehmungen und Fähigkeiten sowie die angebahnten bzw. weiterentwickelten Kompetenzen sollen in die Pflegepraxis übertragen werden. Dort entsteht durch Anwendung, Übung und Transfer die performative und wirkungsvolle Umsetzung der erworbenen Handlungskompetenz. Nach der Rückkehr in die Pflegeschule werden diese neuen Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen gemeinsam mit den Auszubildenden thematisiert und auf mögliche Handlungsmöglichkeiten geprüft. Durch Kontextualisierung und Abgleich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen erfolgt wiederrum die Strukturierung des praktisch Gelernten und dient der Vorbereitung der nächsten Praxisphase. Durch diesen fortlaufenden Transfer- und Reflexionsprozess aus Theorie und Praxis entwickeln die Auszubildenden ein tieferes Verständnis für berufliche Situationen, erweitern ihre Fähigkeiten, steigern ihre Handlungssicherheit und ihre Begründungsfähigkeit.

Weitere Verzahnungen im Zuge der Lernortkooperation sind von der jeweiligen Schule unbedingt anzustreben, um den Auszubildenden eine konsistente Lernprozessgestaltung zu ermöglichen.

7 Formale Gestaltung des Rahmencurriculum

7.1 Lernfelder

Die 17 Lernfelder (LF) bilden die Bausteine im schulinternen Curriculum und setzen die curricularen Einheiten (CE) des Rahmenlehrplan (RLP) der Fachkommission nach §53 Absatz 1 und 2 des Pflegeberufegesetzes (PflBG) um.

	CE – curriculare Einheit nach Rahmenlehrplan										
Lernfelder	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
LF 01	40										
LF 02	20								60 20		
LF 03			40	20 20							
LF 04			40				40				
LF 05					40 20						
LF 06	10							20	30		
LF 07				40 20							
LF 08					40	60 60					
LF 09									60 30		
LF 10					120 120					20 10	
LF 11							80 40			20 10	
LF 12										20 10	
LF 13				20 40				60 20			
LF 14		180								20	
LF 15											80 80
LF 16								70 20		20 20	
LF 17								30 30		20 10	
Summe 1/ 2. AD (Anlage 1 PflAPrV)	70 /70	180/180	80/80	80/80	200/200	60/60	80/80	160/160	150/150	120/120	80/80
Summe 3. AD (Anlage 2 PflAPrV)				80/80	140/140	60/60	80/80	90/90	50/50	60/60	80/80
Gesamtstunden / Vorgaben nach Rahmenlehrplan	70/70	180/180	80/80	160/160	340/340	120/120	160/160	250/250	200/200	180/180	160/160

Abbildung 3 Zuordnung der LF zu den CE-Lernfelder gemäß den curricularen Einheiten in den Rahmenplänen der Fachkommission §53 PflBG (Anl.1)

Übersicht Lernfelder

LF	Titel	Kurztitel	UE	UE
			1./2. AD	3.AD
01	Die Ausbildung zur Pflegefachperson erfolgreich starten	Ausbildungsstart	40	
02	Den eigenen Lernprozess wahrnehmen, steuern und gestalten	Lernprozess	80	20
03	Die eigene Gesundheit schützen und fördern	Eigene Gesundheit	60	20
04	Ein eigenes Berufsverständnis entwickeln	Berufsverständnis	40	40
05	In verschiedenen Systemen zielgerichtet handeln können	Pflegesysteme	40	20
06	Digitale Arbeits- und Lebenswelten teilen und gestalten	Digitalisierung	40	20
07	Biopsychosoziale Gesundheit erhalten und fördern	Prävention	40	20
08	Sicherheit herstellen und vermitteln	Sicherheit	100	60
09	Gesell., kulturelle u. sexuelle Vielfalt als Chance für bedarfsgerechte prof. Pflege anerkennen	Diversity	60	30

10	Menschen aller Altersstufen mit akuten Gesundheitsproblemen kurativ unterstützen	Kuration	140	130
11	Disability: Behinderung als soziales Konstrukt verstehen und Barrieren abbauen	Disability	100	50
12	Menschen in der Schwangerschaft und nach der Geburt unterstützen	Schwangerschaft	20	10
13	Menschen aller Altersstufen mit chronischen Erkrankungen in der Entwicklung einer individuellen Gesundheitskompetenz unterstützen	Empowerment	80	60
14	Menschen aller Altersstufen mit Selbstpflegedefizit im Alltag und der autonomen Lebensführung unterstützen	Selbstpflegedefizit	200	---
15	Menschen aller Altersstufen mit psychischen Erkrankung bei der Beziehungsgestaltung und sozialen Teilhabe unterstützen	Psychische Gesundheit	80	80
16	Menschen aller Altersstufen in Krisen und akuten Belastungssituationen begleiten	Krisen	90	40
17	Menschen aller Altersstufen mit lebenslimitierenden Erkrankungen palliativ unterstützen	Palliativ Care	50	40

Gemäß § 51 Abs. 2 PflAPrV sind die Lernfelder für den theoretischen und praktischen Unterricht kompetenzorientiert und fächerintegrativ konzipiert. Neben Zielen und Inhalten beinhalten sie Anregungen für die weitere Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen. Insgesamt liegen siebzehn Lernfelder vor.

Im Folgenden werden die 17 Lernfelder detailliert dargestellt. Dabei werden ihre Intention und Relevanz erläutert, die Bildungsziele der einzelnen Module für die verschiedenen Ausbildungsdrittel beschrieben, die Gesamtanzahl der Unterrichtseinheiten (UE) und die vorgesehene Unterrichtswoche (UW) dargestellt. Beim Erstellen des Verlaufsplans für die jeweilige Pflegeschule dienen die Angaben der vorgesehen UW für das jeweilige Modul als Richtwert. Die Module sind

gemäß den Konstruktionsprinzipien zu planen. Ergänzend dazu enthält die Darstellung einen didaktischen Kommentar. Zudem werden die Module mit Titel und Lernziel sowie den zugehörigen Unterrichtseinheiten (UE) aufgeführt.

Bei den Lernfeldern handelt es sich um Handlungsfelder Auszubildender und beruflich Pflegender, die in umfangreichen Berufsfeld- und Literaturanalysen erhoben und beschrieben wurden. Für die Lernfeldkonstruktion war stets das pflegerische Handeln und die Pflegewissenschaft leitend (nicht wie im PflBG/PflAPrV von 2004 die Bezugswissenschaften, wie beispielsweise die Medizin im Fokus). Als zentrale strukturgebende Elemente in der Lernfeldfeldkonstruktion fungieren die im Folgenden aufgeführten pflegerischen Kernaufgaben und pflegerelevanten Prinzipien.

- Pflegeprozess gestalten
- berufspolitisch, ethisch, gesellschaftspolitisch, kultursensibel, pflegeforschend, prophylaktisch, qualitätssichernd, Setting-spezifisch handeln, sowie Pflege- und bezugswissenschaftliche Konzepte gestalten

Die Lernfelder erstrecken sich auf die drei Ausbildungsdrittel und beinhalten mehrere berufstypische Situationen bzw. Lernsituationen, die den Schwerpunkt des Lernfeldes in ansteigender Komplexität aufgreifen.

Die Lehr-Lern-Arrangements sind so gestaltet, dass sie den Kompetenzerwerb der in den Anlagen 1 und 2 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe (PflAPrV) angestrebten Kompetenzen ermöglichen. Die folgende Abbildung stellt die 17 Lernfelder des apm-Curriculum dar. Die dargestellten Unterrichtseinheiten (UE) und Unterrichtswochen (UW) sind schulstandortintern sowie in Abhängigkeit vom jeweiligen Ausbildungsbeginn anzupassen.

LF 01	**Die Ausbildung zur Pflegefachperson erfolgreich starten**	**40 UE**	
	Intention und Relevanz Lernfeld 01 umfasst mit fünf Modulen den Zeitraum des Ausbildungsstarts bis zum Ende der sechsmonatigen Probezeit. Es umfasst Module, die im Schwerpunkt der Anbahnung von Reflexionsvermögen und Rollenfindung dienen. Zudem sollen Schnittstellen zum Lernort Praxis beleuchtet werden und Raum geboten werden, einen möglichen „Praxisschock“ zu thematisieren.		
	Bildungsziele 1./2. AD Die Auszubildenden reflektieren ihre Rolle als Lernende sowie mögliche selbst- und fremdbestimmte Momente in der Ausbildung und sind für Mitbestimmungsmöglichkeiten sensibilisiert. Sie finden Ressourcen im sozialen Kontext der Lernorte und erleben die Pflegeschule als sichere Lernumgebung. Sie nähern sich einem beruflichen Selbstverständnis professioneller Pflege an, dass sich an den zu pflegenden Menschen und ihren Bezugspersonen orientiert. Sie reflektieren widersprüchliche Anforderungen, die sie im Spannungsfeld von Fürsorge für den zu pflegenden Menschen und standardisierten Vorgaben erleben.		
	Didaktischer Kommentar Im Lernfeld 01 eignen sich methodische Ansätze, die der subjektive Lebensrealität der Auszubildenden sowie deren individuellen Einstellungen zum Pflegeberuf Raum geben. Das Reflexionsvermögen der Auszubildenden bildet die Grundlage zur Kompetenzentwicklung und soll von Beginn an gefördert werden. Zudem soll eine authentische Beziehung zwischen Lernenden und Lehrkräften angebahnt werden. Eine wertschätzende Haltung gegenüber vielfältigen Motivationen für den Beruf und die Deklaration der Pflegeschule als sichere Umgebung für Lernprozess und Erfahrungsaustausch ist maßgeblich für eine vertrauensvolle Lernatmosphäre und der Umsetzung sozialer und behavioraler Lernstrategien.		
Modul	**Modultitel**	**UE**	**UW**
01-A	**Ankommen in der Pflegefachausbildung**	10	1-2
	Die Auszubildenden kennen den Lernort Pflegeschule und gestalten aktiv eine konstruktive Lernatmosphäre im sozialen Gruppengefüge.		

01-B	**Pflege als Beruf erfassen**	7	2-3
	Die Auszubildenden verstehen die Unterschiede zwischen professioneller und Laienpflege. Erfassen die Aufgaben und Handlungsfelder der professionellen Pflege.		
01-C	**Was mich als Auszubildende:r in meinem Betrieb erwartet**	6	8
	Die Auszubildenden lernen unterschiedliche Rollenerwartungen an Auszubildende am Lernort Praxis kennen.		
01-D	**Aus dem ersten Einsatz lernen**	11	9-10
	Die Auszubildenden reflektieren sowohl Rollenerwartungen, mit denen sie im Orientierungseinsatz konfrontiert wurden als auch eigene Erwartungen an den Lernort Praxis.		
01-E	**Ziele für die weitere Ausbildung formulieren**	6	15
	Die Auszubildenden formulieren Ziele für die weitere Entwicklung im Ausbildungsprozess.		

Kompetenzen 1./2. AD (Anlage 1 PflAPrV)

KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**
h					**A**	**d**		**b**	**E**				**a**	**h**	

Bezug RLP: CE 01

	Den eigenen Lernprozess wahrnehmen, verstehen und gestalten	**100 UE**
LF 02	**Intention und Relevanz** Lernfeld 02 umfasst mit fünfzehn Modulen den gesamten Zeitraum der Ausbildung und dient der kontinuierlichen Reflexion und Steuerung des eigenen Lernprozesses. Die Module umfassen verschiedene kompetenzorientierte Schwerpunkte, um diese als Lern- und Entwicklungsbereich in der Pflegefachausbildung zu verdeutlichen. Zusätzlich findet im Rahmen der Ausbildung eine Persönlichkeitsentwicklung statt, deren Reflexion für jede:n Auszubildende:n hinsichtlich verschiedener Kompetenzen ermöglicht werden soll. Dabei werden sowohl die Entwicklung fachlicher als auch sozialer und Selbstkompetenzen gefördert.	
	Bildungsziele 1./2. AD Die Auszubildenden reflektieren ihre Rolle als Lernende sowie mögliche selbst- und fremdbestimmte Momente in der Ausbildung und sind für Mitbestimmungsmöglichkeiten sensibilisiert. Sie finden Ressourcen im sozialen Kontext der Lernorte und erleben die Pflegeschule als sichere Lernumgebung. Die Auszubildenden reflektieren die eigene Bildungsbiografie und leiten Ressourcen für eigenen Lernprozess ab. Dabei erfahren sie die Vielfalt von Biografien am Beispiel von Bildungswegen. Sie setzen sich mit vorgeprägten Menschenbildern auseinander.	
	Didaktischer Kommentar Maßgeblich für die Wahrnehmung des eigenen Lernprozesses sind sowohl die Auseinandersetzung mit der eigenen Bildungs- und Lernbiografie sowie regelmäßiges Feedback und Raum für Selbstreflexion. Die eigene Kompetenzentwicklung soll dabei als ein Prozess verstanden werden, der nie im sozialen Vergleich, sondern ausschließlich intraindividuell beurteilt werden kann. Individuelle Handlungsmuster und Routinen sollen hinterfragt und neugestaltet werden dürfen. Dabei sind methodische Ansätze zu wählen, die genug Raum für die Entwicklung individueller Strategien und Erprobung verschiedener Lerntechniken geben. Ziel ist immer die Selbststeuerung des eigenen Lernprozesses. Die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen ist dabei als Kernkompetenz der Pflegefachperson aufzubauen.	

	Achtung: *Bildungsbiografien beinhalten häufig Gewalterfahrungen, manchmal Traumata und können verschiedene Emotionsräume (Angst, Hilflosigkeit, ausgeliefert-sein, Panik, Scham, Schuld etc.) öffnen! Ein sensibler und kompetenter Umgang seitens der Lehrkraft ist hier unbedingt notwendig.* ***Hinweis:*** *das Vorhandensein sog. „Lerntypen" wurde wissenschaftlich mehrmals widerlegt – eine Testung und Ausrichtung auf bestimmte Lerntypen ist nicht hilfreich. Vielmehr sollten die Vielfalt der Wahrnehmungskanäle und Verarbeitungs- und Deutungsprozesse betont werden.*		
Modul	**Modultitel**	**UE**	**UW**
02-A	**Die eigene Bildungsbiografie reflektieren**	8	1-2
	Die Auszubildenden nehmen ihre eigene Bildungsbiografie als Weg zur individuellen Kompetenz wahr und beurteilen diese hinsichtlich der Anforderungen in der Pflegefachausbildung.		
02-B	**Ethisches Handeln als Kernkompetenz der professionellen Pflege verstehen**	8	3-4
	Die Auszubildenden verstehen, dass pflegerisches Handeln anhand ethischer Prinzipien reflektiert und begründet wird.		
02-C	**Theorie-Praxis-Transfer verstehen und gestalten**	4	8
	Die Auszubildenden erfassen Lern- und Arbeitssaufgaben als wichtiges Instrument zur Erprobung/Umsetzung theoretisch gelernter Inhalte und Fertigkeiten am Lernort Praxis. Können die geforderten Formalia umsetzen.		
02-D	**Die eigene Lernwelt selbstfürsorglich gestalten**	8	11
	Die Auszubildenden wenden Wissen und Erkenntnisse zu Selbstfürsorge und Lernen an, um die eigene Lernumgebung gesundheitsförderlich zu gestalten.		
02-E	**Digitale Informationstechnologien nutzen**	4	12
	Die Auszubildenden bewerten unterschiedliche digitale Applikationen in Hinblick auf Nutzbarkeit und Anwender:innenfreundlichkeit für die Pflegefachausbildung.		
02-F	**Selbstgesteuertes Lernen**	8	17-18
	Die Auszubildenden entwickeln die bisherigen Strategien und Erkenntnisse weiter, um den eigenen Lernprozess in Eigeninitiave steuern zu können.		

02-G	**Pflegewissenschaft als Basis evidenzbasierten Pflegehandelns begreifen**	8	22-23
	Die Auszubildenden begreifen den Forschungsprozess als Lernmoment für die eigene berufliche Entwicklung ("forschendes Lernen").		
02-H	**Pflegemanagement als Basis qualitätsorientierter Pflege verstehen**	8	27-28
	Die Auszubildenden entwickeln exemplarisch Instrumente zur Qualitätserfassung oder -sicherung (z.B: Dienstplan, Befragungen, Checklisten, etc.)		
02-I	**Ethisches Handeln als Kernkompetenz der professionellen Pflege umsetzen**	8	31
	Die Auszubildenden nutzen Grundrechte, Ethikkodizes und individuelle Gewohnheiten als Begründungsrahmen für ethisches Pflegehandeln.		
02-J	**Autonomie als konkurrierendes Prinzip erkennen und verhandeln**	12	35-37
	Die Auszubildenden identifizieren Ursachen für Autonomie als konkurrierendes Prinzip im Pflegeprozess und entwickeln Beurteilungskriterien für die Unterstützung einer selbstbestimmten Lebensgestaltung in verschiedenen Versorgungskontexten.		
02-K	**Reflexion Zwischenprüfung: Status quo und Ziele für die weitere Ausbildung erfassen**	4	42
	Die Auszubildenden beurteilen ihren bisherigen Kompetenzerwerb in Abgleich zu den Anforderungen für die Zwischenprüfung und formulieren persönliche Ziele für den weiteren Lernprozess.		

Kompetenzen 1./2. AD (Anlage 1 PflAPrV)															
KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**
								a, b	**d**					**c**	**a, c**

Bezug RLP: CE 01, CE 09			
LF 02	**Bildungsziele 3. AD** Die Auszubildenden nehmen zunehmend häufig die Rolle der Lehrenden ein. Sie reflektieren den eigenen Kompetenzerwerb und schätzen eigene Potenziale ein.		
Modul	**Modultitel**	**UE**	**UW**
02-K	**Reflexion Zwischenprüfung: Status quo und Ziele für die weitere Ausbildung erfassen**	4	43
	Die Auszubildenden beurteilen ihren bisherigen Kompetenzerwerb in Abgleich zu den Anforderungen für die Zwischenprüfung und formulieren persönliche Ziele für den weiteren Lernprozess.		
02-L	**Rolle als anleitende Fachkraft annehmen**	4	49
	Die Auszubildenden reflektieren die Rolle als Lehrende aus der Anleitungssituation hinsichtlich ihrer persönlichen Entwicklung und des eigenen Kompetenzerwerbs.		
02-M	**Vorbereitung praktische Abschlussprüfung**	4	56
	Die Auszubildenden ermitteln ihren eigenen Kompetenzerwerb in Hinblick auf die Anforderungen der praktischen Abschlussprüfung. Können die Prüfungsvorbereitung gestalten.		

02-N	**Vorbereitung schriftliche Abschlussprüfung**	4	59
	Die Auszubildenden ermitteln ihren eigenen Kompetenzerwerb in Hinblick auf die Anforderungen der schriftlichen Abschlussprüfung. Kennen hilfreiche Strategien zur Bewältigung prüfungsbezogener Anforderungen.		
02-O	**Vorbereitung mündliche Abschlussprüfung**	4	61
	Die Auszubildenden ermitteln ihren eigenen Kompetenzerwerb in Hinblick auf die Anforderungen der mündlichen Abschlussprüfung. Kennen hilfreiche Strategien zur Bewältigung prüfungsbezogener Anforderungen.		

Kompetenzen 3. AD (Anlage 2 PflAPrV)

KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**
									b, d			**c**		**c**	**a**

Bezug RLP: CE 09

LF 03	**Die eigene Gesundheit schützen und fördern**	**80 UE**
	Intention und Relevanz Lernfeld 03 gibt mit acht Modulen über den gesamten Ausbildungsverlauf hinweg Impulse zur Gesunderhaltung und -förderung von Pflegepersonen. Beruflich Pflegende unterliegen besonderen Risiken für die eigene biopsychosoziale Gesundheit. Ein selbstbewusster und konstruktiver Umgang mit berufsbezogenen Belastungen ist daher unbedingt notwendig. Der Schwerpunkt wird dabei auf die Betrachtung eigener Emotionen und den lösungsorientierten Umgang mit berufsbedingten Herausforderungen gelegt.	
	Bildungsziele 1./2. AD Die Auszubildenden sind für ihre Selbstsorge und die Fürsorge für andere Menschen sensibilisiert. Sie reflektieren innere Widersprüche zwischen dem Anspruch, helfen zu wollen, und dem Erleben von Ekel, Scham, Ungeduld, Abwehr, Grenzüberschreitung und Hilflosigkeit. Die Auszubildenden reflektieren mit Blick auf die gewonnenen Erfahrungen das Spannungsfeld zwischen idealen Ansprüchen an Pflege und der Wirklichkeit ihrer Handlungsmöglichkeiten einschließlich persönlicher und institutioneller Begrenzungen. In der Kommunikation mit zu pflegenden Menschen und ihren Bezugspersonen nehmen sie die unterschiedlichen Interessen wahr und wirken an Aushandlungsprozessen mit, in denen sie sich positionieren und in der argumentativen Rede einüben können.	
	Didaktischer Kommentar Das Begreifen von Spannungsfeldern benötigt die Wahrnehmung verschiedener Perspektiven. Die damit verbundenen Fähigkeiten zur Empathie und Abstraktion sollte im Fokus pädagogischer Anstrengungen liegen. Dabei sollte die subjektive Realität der Auszubildenden die Grundlage zur Auseinandersetzung bieten. Im Verlauf der Ausbildung wird so im Sinne eines steigenden Komplexitätsgrades die Kompetenz zur Wahrnehmung und Verhandlung divergierender Deutungs- und Handlungsmuster entwickelt.	

Modul	Modultitel	UE	UW
03-A	**Eigene Emotionen wahrnehmen und ausdrücken können**	8	5-6
	Wahrnehmung und Ausdruck von Emotionen als wichtige Basis für Gesunderhaltung verstehen.		
03-B	**Möglichkeiten der persönlichen Gesunderhaltung kennenlernen und anwenden**	8	9-10
	Die Auszubildenden erproben Möglichkeiten zur persönlichen Gesunderhaltung und -förderung.		
03-C	**Nähe und Distanz professionell gestalten**	12	16-20
	Die Auszubildenden sind sich ihrer beruflichen Rolle und damit verknüpften Anforderungen bewusst und fühlen sich in der Lage, Pflegebeziehungen professionell zu gestalten .		
03-D	**Gesunderhaltung und Arbeitsbedingungen von Pflegekräften in der historischen Berufsentwicklung betrachten**	12	24-26
	Die Auszubildenden identifizieren wichtige Entwicklungen in den Bereichen Arbeitsschutz und Gesunderhaltung für den Pflegeberuf und leiten Handlungsbedarfe für das eigene beruflich Umfeld ab.		
03-E	**Kollegiale Beratung als Instrument der persönlichen Gesunderhaltung wahrnehmen**	8	32-33
	Die Auszubildenden erproben kollegiale Beratung als Möglichkeit der persönlichen Gesunderhaltung und Entwicklung als beruflich Pflegende.		
03-F	**Ansätze für Gesundheitsforschung im Bereich beruflich Pflegender formulieren**	12	38-40
	Die Ausbildenden leiten aus ihrem beruflichen Umfeld relevante Forschungsthemen zur Gesunderhaltung von beruflichen Pflegenden ab.		

Kompetenzen 1./2. AD (Anlage 1 PflAPrV)															
KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**
						a, b, d			**b**					**b**	**a-e**
Bezug RLP: CE 03, CE 04															

LF 03	**Bildungsziele 3. AD** Die Auszubildenden reflektieren Widersprüche zwischen der Fürsorge für zu pflegende Menschen und gesundheitsbezogener Selbstbestimmung. Sie kennen Möglichkeiten zur Bewältigung von Konflikten sowie Über- und Unterforderung, die daraus entstehen können.		
Modul	**Modultitel**	**UE**	**UW**
03-G	**Konflikte wahrnehmen und bewältigen**	12	44-46
	Die Auszubildenden identifizieren potenziell herausfordernde Situationen in Arbeitsteams und kennen verschiedene Strategien zur Bewältigung bzw. Konfliktlösung.		
03-H	**Über-/Unterforderung und andere berufliche Belastungen managen**	8	52-53
	Die Auszubildenden reflektieren aktuelle Belastungen durch die berufliche Tätigkeit und entwerfen eine persönliche Strategie zum Umgang mit beruflichen Belastungen.		

Kompetenzen 3. AD (Anlage 2 PflAPrV)															
KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV. 1**	**KS IV. 2**	**KS V. 1**	**KS V. 2**
									f		**c**		**e**		**b,c**
Bezug RLP: CE 04															

LF 04	**Ein eigenes Berufsverständnis entwickeln**	**80 UE**
	Intention und Relevanz Lernfeld 04 widmet sich mit insgesamt neun Modulen verteilt über den gesamten Ausbildungsverlauf der Entwicklung eines professionellen Berufsverständnisses auf Basis des Ausbildungsziels und vorbehaltener Tätigkeiten nach PflBG. Dabei werden die Module an berufstypische Situationen anderer Lernfelder gekoppelt, um Raum für Reflexion und Diskurse auf der beruflichen Ebene zu geben. Grundlegende Prinzipien (Wissenschaft, Ethik, Ökonomie) und ausgesuchte Handlungsfelder (Beratung, Prävention, Rehabilitation) des Pflegeberufes werden aufgegriffen und für die Auszubildenden im Kontext beruflichen Handelns veranschaulicht. Zentral wird die Kompetenz des Begründens pflegerischen Handelns mit entsprechendem Begründungswissen verfolgt. Dies soll nicht nur der Entwicklung eines professionellen Berufsverständnisses dienen, sondern insbesondere der Herstellung eines individuellen Selbstbewusstseins, welches die Grundlage für proaktives und zukunftsorientiertes berufliches Handeln bildet.	
	Bildungsziele 1./2. AD Die Auszubildenden loten ihre beruflichen Handlungsspielräume aus und begründen ihre Entscheidungen. Sie reflektieren innere Widersprüche zwischen dem Anspruch, helfen zu wollen, und dem Erleben von Ekel, Scham, Ungeduld, Abwehr, Grenzüberschreitung und Hilflosigkeit. Die Auszubildenden reflektieren mit Blick auf die gewonnenen Erfahrungen das Spannungsfeld zwischen idealen Ansprüchen an Pflege und der Wirklichkeit ihrer Handlungsmöglichkeiten einschließlich persönlicher und institutioneller Begrenzungen.	
	Didaktischer Kommentar Auszubildende sollen im Rahmen der theoretischen Ausbildung zur Reflexion der beruflichen Rahmenbedingungen angeregt werden. Die Betrachtung von vielfältigen Handlungsoptionen in verschiedenen Situationen soll die Neugier auf Begründungswissen fördern. Eine authentische Auseinandersetzung mit aktuellen beruflichen Herausforderungen und der Entwicklung von kreativen Lösungen sollte die Basis didaktischer Konzeptionen darstellen. Zentrale Werte und Prinzipien sollten dabei von der Lehrkraft jederzeit selbstbewusst vertreten und umgesetzt werden. Im Sinne experience-geleiteter Lernprozesse erfahren die Auszubildenden somit, wie die Umsetzung dieser zuweilen abstrakten Begriffe in der beruflichen Praxis gelingen kann.	

Modul	Modultitel	UE	UW
04-A	**Anforderungen und Ziele der generalistischen Pflegefachausbildung kennenlernen**	8	1-2
	Die Auszubilden erfassen berufliche Handlungsfelder, Ausbildungsziele bzw. Kompetenzbereiche und Lernfelder, um Kompetenzerwerb anzubahnen und zentrale Werte für pflegeberufliches Handeln zu entwickeln.		
04-B	**Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten**	8	13-14
	Die Auszubildenden können personen- und situationsgerecht kommunizieren und sind sensibel für Beratungsbedarfe von Menschen im akut-stationären Versorgungskontext.		
04-C	**Pflege als Beruf und Dienstleistung verstehen**	4	21
	Die Auszubildenden arbeiten mit Institutionen und Netzwerken im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention zusammen und identifizieren Bedarfe an Pflege- und Unterstützungsleistungen in Gegenwart und Zukunft.		
04-D	**Pflegeprozesse steuern, lenken, evaluieren**	12	29-34
	Die Auszubildenden reflektieren die berufliche Praxis im Hinblick auf gesundheitsfördernde und präventive Maßnahmen im Kontext mit dem Pflegeprozess insbesondere §4 PflBG.		
04-E	**Pflegerisches Handeln wissenschaftlich begründen können**	8	41-42
	Die Auszubildenden erklären ADHS und erklären die psych. Erkrankungen die häufig zusätzlich zu ADHS diagnostiziert werden. Erheben Pflegediagnosen, Ursachen der Probleme, nennen die Kennzeichen und mögliche Ressourcen eines zu pflegenden Menschen. Stellen Bewältigungsstrategien dar. Stärken Selbstwert und Selbstbewusstsein.		

Kompetenzen 1./2. AD (Anlage 1 PflAPrV)															
KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV. 1**	**KS IV. 2**	**KS V.1**	**KS V.2**
h						**b-e, g**			**b**						**d**
Bezug RLP: CE 03															

LF 04	**Bildungsziele 3. AD** Die Auszubildenden können selbstbewusst den pflegerischen Beitrag zur Wiederherstellung von Gesundheit oder zur Erlangung von Lebensqualität, Autonomie und Selbstständigkeit im interprofessionellen Team ausweisen und positionieren sich dazu. Sie reflektieren widersprüchliche Anforderungen, die sich aus dem Wunsch der zu pflegenden Menschen nach Normalität und ein Leben mit bedingter Gesundheit ergeben und nehmen zu dem gesellschaftlichen Phänomen der Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung Stellung. Für die rehabilitative Pflege reflektieren sie erschwerende institutionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen für ein Leben in bedingter Gesundheit und nehmen zu sozialrechtlichen Normen im Hinblick auf ethische und wirtschaftliche Maßstäbe Stellung. Sie reflektieren pflegeberufspolitische Interessenvertretungen im Kontext divergierender Interessen in der Gesundheitspolitik.		
Modul	**Modultitel**	**UE**	**UW**
04-F	**Pflegerisches Handeln sozialrechtlich begründen können**	12	47-48
	Die Auszubildenden entwerfen eigenverantwortlich ein Konzept zum rehabilitativen Pflegehandeln und setzen dieses in einem Feldversuch um. Berücksichtigen dabei sozialrechtliche Leistungsansprüche und qualitätsorientierte Pflegeprozessgestaltung.		

04-G	**Gesundheitsförderliche Faktoren mitgestalten**	12	50-51
	Die Auszubildenden entwickeln kreative und evidenzbasierte Ansätze für gesundheitsförderliche Bedingungen am Arbeitsplatz.		
04-H	**Advocacy als Ausdruck berufsethischen Pflegehandelns**	8	54-55
	Die Auszubildenden reflektieren ihre Einstellung gegenüber Menschen mit psych. Erkrankungen und Behinderungen. Balancieren professionell Nähe und Distanz. Engagieren sich gegen Stigmatisierung um Vorurteile und Diskriminierung abzubauen.		
04-I	**Beruflich Pflegende als Akteur: innen des gesellschaftlichen Wandels kennenlernen**	8	61-62
	Die Ausbildenden identifizieren den Widerspruch zwischen präventiven und gesundheitsfördernden Maßnahmen im Berufsalltag und bewerten die gesundheitsfördernden Handlungsalternativen in Bezug auf Praxistauglichkeit		

Kompetenzen 3. AD (Anlage 2 PflAPrV)

KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**
	d,f										**b,c, f**	**a**	**b, d**	**a**	**d, e,g**

Bezug RLP: CE 07

LF 05	**In verschiedenen Systemen zielgerichtet handeln können**	**60 UE**
	Intention und Relevanz Die sieben Module im Lernfeld 05 nehmen die Umsetzung der vorbehaltenen Tätigkeiten in verschiedenen Versorgungskontexten und Pflegesystemen in den Blick. Hierbei soll der Vielfalt der Arbeitskontexte im Rahmen der generalistischen Pflegeausbildung Rechnung getragen werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf die Schnittstellen verschiedener Systeme und deren Bedeutung für die Pflegeprozessgestaltung gelegt. Im Verlauf der Ausbildung werden verschiedene Aspekte von Pflegequalität aufgegriffen und exemplarisch in ihrer Umsetzung thematisiert.	
	Bildungsziele 1./2. AD Die Auszubildenden kennen und verstehen Schwerpunkte der Pflegeprozessgestaltung in verschiedene Versorgungskontexten und -systemen. Sie reflektieren den Widerspruch zwischen dem unmittelbaren Erleben von medizinischen und pflegerischen Phänomenen und dem oftmals objektivierenden Umgang damit im medizinischen Kontext. Sie erkennen, dass Effizienzoptimierungen etwa durch standardisierte Handlungsabläufe mit Verlusten bei Individualisierungs- bzw. Personalisierungsmöglichkeiten einhergehen. Sie entwickeln ein Verständnis für Pflegequalität und reflektieren Routinen im Hinblick auf ihre wissenschaftliche Grundlage.	
	Didaktischer Kommentar Die Module 05-B bis 05-D behandeln fortlaufend denselben Fall. Hier sollen bisherige Erkenntnisse und Lernergebnisse fortlaufend genutzt und erweitert werden, um die Prozessorientierung auch in der Unterrichtsgestaltung erfahrbar zu machen. Die Wahlmodule eignen sich für eine Anpassung der Unterrichtsgestaltung an die Voraussetzungen bzw. Interessen der Lernendengruppe. Alternativ können die vorliegenden Handlungssituationen der Wahlmodule auch zur Binnendifferenzierung oder im Rahmen Problemorientierten Lernens eingesetzt werden. Die Module im 3. AD können in Kooperation mit dem Lernort Praxis real umgesetzt werden oder im Rahmen der fallorientierten Unterrichtsgestaltung exemplarisch erarbeitet werden.	

Modul	Modultitel	UE	UW
05-A	**Verschiedene Pflegesysteme und -modelle kennenlernen**	8	10-11
	Die Auszubildenden kennen verschiedene Pflegemodelle und können Pflegesysteme bzw. Versorgungskontexte voneinander unterscheiden.		
05-B	**Pflegeprozesse im ambulanten Setting steuern**	8	17-18
	Die Auszubildenden nehmen die Möglichkeiten der lebensweltorientierten Pflegeprozessgestaltung im ambulanten Versorgungskontext wahr und können diese umsetzen.		
05-C	**Pflegeprozesse in der stationären Akutpflege steuern**	8	25-26
	Die Auszubildenden können Pflegebedarfe im akut-stationären Versorgungskontext feststellen und verstehen Besonderheiten der kurzzeitigen Pflegeprozessgestaltung.		
05-D	**Pflegeprozesse in der stationären Langzeitpflege steuern**	8	31-32
	Die Auszubildenden können verschiedene Berufsgruppen und digitale Hilfen in den Pflegeprozess der stationären Langzeitpflege einbeziehen und entsprechend der Pflegebedarfe steuern.		
05-E-W1	**Pflegequalität in der ambulanten Langzeitpflege herstellen, prüfen und sichern**	8	36-37
	Die Auszubildenden verstehen den Pflegeprozess als Möglichkeit der Wirksamkeitsmessung und identifizieren mögliche Kriterien zur Erhebung der Pflegequalität.		
05-E-W2	**Pflegequalität in der stationären Langzeitpflege herstellen, prüfen und sichern**		
	Die Auszubildenden verstehen den Pflegeprozess als Möglichkeit der Wirksamkeitsmessung und identifizieren mögliche Kriterien zur Erhebung der Pflegequalität.		
05-E-W3	**Pflegequalität in der akut-stationären Pflege herstellen, prüfen und sichern**		
	Die Auszubildenden verstehen den Pflegeprozess als Möglichkeit der Wirksamkeitsmessung und identifizieren mögliche Kriterien zur Erhebung der Pflegequalität.		

Kompetenzen 1./2. AD (Anlage 1 PflAPrV)															
KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**
a-i						**d, e**					**d,f**				
Bezug RLP: CE 05															

LF 05	**Bildungsziele 3. AD** Die Auszubildenden entwickeln ein vertieftes Verständnis für Pflegequalität und deren systemische Einflussfaktoren. Sie finden Ansatzpunkte und Chancen im beruflichen Handeln zur Chancengerechtigkeit beizutragen. Dabei können sie auch partizipative Konzepte umsetzen und realisieren somit eine bedarfsgerechte und qualitätsorientierte Pflegeprozessgestaltung. **Didaktischer Kommentar** Im Rahmen der Verfügungsstunden Modul 05-F aufgreifen und unter Kompetenzschwerpunkten aus dem 3. AD nach Bedingungsanalyse bedarfsgerecht vertiefen.		
Modul	**Modultitel**	**UE**	**UW**
05-F	**Ökonomische und Ökologische Prinzipien als Qualitätskriterien verstehen und Wege finden, diese zu gewährleisten**	8	43-44
	Die Auszubildenden bewerten die Umsetzung ökonomischer und ökologischer Prinzipien anhand passender Qualitätssicherungsinstrumente.		
05-G	**Ein einrichtungsbezogenes Konzept erarbeiten, um die Pflegequalität evidenzbasiert zu steigern**	12	52-58
	Die Auszubildenden entwickeln konkrete Konzepte zur Qualitätssteigerung durch Anwendung evidenzbasierter Forschungsergebnisse, Leitlinien und Standards.		

Kompetenzen 3. AD (Anlage 2 PflAPrV)

KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**
												a, b, d,	**a, e**	**c**	

Bezug RLP: CE 05

	Digitale Arbeits- und Lebenswelten teilen und gestalten	**60 UE**
	Intention und Relevanz Lernfeld 06 bündelt verschiedene Aspekte von Digitalisierung, Technisierung und social media. Dabei sollen digitale Lern- und Erfahrungsräume als aktiv gestaltbar wahrgenommen werden. Medienkompetenz und kritisches Denken im Umgang mit digitaler Information und Kommunikation sind grundlegenden Fähigkeiten, die im Rahmen dieses Lernfeldes gefördert werden sollen. Hierbei stehen sowohl die Auszubildenden selbst als auch zu pflegende Menschen und Institutionen im Fokus der Unterrichtsgestaltung. In insgesamt acht Modulen werden verschiedene berufstypische Situationen bearbeitet, die verschiedene Handlungsanlässe bieten, bedarfsgerechte digitale und technische Lösungen zu finden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei in der digitalen bzw. technischen Unterstützung von Menschen mit Behinderung – hier sollen Möglichkeiten des Barriereabbaus durch Digitalisierung und technische Innovation besondere Aufmerksamkeit erhalten.	
LF 06	**Bildungsziele 1./2. AD** Die Auszubildenden reflektieren ihre Rolle als Lernende im digitalen Raum und können diesen konstruktiv zur Kompetenzentwicklung nutzen. Sie setzen sich mit ihrer eigenen digitalen Präsenz und Kompetenz auseinander und nehmen diese als Entwicklungsfeld und Gestaltungsspielraum wahr. Die Auszubildenden reflektieren den Widerspruch zwischen Nah-Sein in der Pflegebeziehung und Fremdheitserleben in der Konfrontation mit Lebensentwürfen und Lebenswelten anderer Menschen. Sie finden Möglichkeiten zur Unterstützung von zu pflegenden Menschen in der Nutzung digitaler Angebote.	
	Didaktischer Kommentar Digitale und technische Angebote sollen in diesem Lernfeld als hilfreich und gestaltbar erlebt werden. Dahingehend ist Raum für Recherche, Ausprobieren und Beurteilen von verschiedenen Anwendungen und Angeboten einzuplanen. Die Lehrkraft sollte dem Prozess der fallbasierten Lösungsfindung ergebnissoffen gegenüberstehen und Digitalisierung grundsätzlich als Chance verstehen und vermitteln können. Aufgrund der sich kontinuierlich wandelnden digitalen Welt, sind fortlaufende Recherchen und Information auch für die Lehrkraft von großer Bedeutung.	

	Es soll betont werden, dass insbesondere Lernfeld 06 sich dazu eignet, Lernende in die Rolle der Lehrenden zu bringen: die Erfahrung und Expertise von Lernenden in Bereichen wie social networking, content creating und applicationsgestützte Dienstleistungen sollten als wertvolle Ressourcen für die Ausgestaltung der theoretischen Ausbildung betrachtet und genutzt werden. Methoden, die peergestützte Formate umfassen, können gute Effekte für weniger technisch affin bzw. digital interessierte Lernende haben.		
Modul	**Modultitel**	**UE**	**UW**
06-A	**Als Auszubildende:r einen verantwortungsbewussten Umgang mit Medien im digitalen Raum erlernen**	8	4-7
	Die Auszubildenden verstehen in ihrer Rolle als Auszubildende die besondere Verantwortung und kennen die gesetzlichen Vorgaben. Schützen die Privatsphäre und Würde der zu pflegenden Menschen sowie derer Bezugspersonen und bewegen sich professionell in der digitalen Welt.		
06-B	**Bei der Nutzung Applicationsgestützter Therapieformen unterstützen und anleiten**	8	12
	Die Auszubildenden unterstützen Menschen im Umgang mit digitalen gesundheitsbezogenen Applicationen.		
06-C	**Technische Innovationen im Bereich der häuslichen Krankenpflege kennen und anwenden**	4	15
	Die Auszubildenden kennen technische Möglichkeiten, um pflegebedürftige Personen zu unterstützen und können diese auch anwenden.		
06-D	**Menschen mit Beeinträchtigung der Bewegung bei der Suche nach Begleitung für die Freizeitgestaltung unterstützen**	4	24
	Die Auszubildenden kennen digitale oder technische Hilfen, um Menschen mit körperlichen Einschränkungen die Teilhabe am sozialen Leben zu ermöglichen.		
06-E	**Applicationsgestützte Hilfen im Alltag anwenden**	8	29
	Die Auszubildenden kennen digitale Hilfsmittel und setzen diese ein um es Menschen mit körperlichen Einschränkungen zu ermöglicht am sozialen Leben teilzuhaben.		

06 -F	**Informationsgespräche zur Nutzung gesundheitsbezogener Applicationen durchführen**	8	28-39
	Die Auszubildenden nutzen Wissen zum Umfeld der zu pflegenden Menschen um individuelle Unterstützungsmöglichkeiten anbieten zu können.		

Kompetenzen 1./2. AD (Anlage 1 PflAPrV)															
KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**
g, i				**a-c**	**a, d**	**e**							**d**		**f, g**
Bezug RLP: CE 01, CE 09															

LF 06	**Bildungsziele 3. AD** Die Auszubildenden nehmen die Gesellschaft und die Institutionen als Rahmung für die Gestaltung des Pflegeprozesses wahr.		
Modul	**Modultitel**	**UE**	**UW**
06-G	**Beratung zu technischen und digitalen Hilfen vermitteln**	8	49
	Die Auszubildenden erkennen die Notwendigkeit von digitalen Skills und kennen Anspruch und Fördermöglichkeiten für Menschen mit Einschränkungen. Weiter wenden sie dies an, um Menschen aller Altersstufen in der Alltagsbewältigung zu unterstützen.		
06-H	**Menschen bedarfsgerecht im digitalen Raum unterstützen (Praxisprojekt)**	12	52-55
	Die Auszubildenden agieren sicher im Umgang mit neuen digitalen Pflegedokumentations- bzw. Assistenzsystemen. Verfügen über die Fähigkeit, evidenzbasierte Anleitungen in der Nutzung von digitalen Assistenzsystemen zu geben.		

Kompetenzen 3. AD (Anlage 2 PflAPrV)															
KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**

b, f, g, i	**a, b**						**c**					**b, d**			
Bezug RLP: CE 08															

LF 07	**Biopsychosoziale Gesundheit erhalten und fördern**	**60 UE**	
	Intention und Relevanz Lernfeld 07 widmet sich in neun Modulen dem Thema Gesundheitsförderung als zentralem Handlungsfeld beruflich Pflegender. Dabei werden verschiedene Dimensionen von Gesundheit und deren Entstehung bzw. Förderung beleuchtet. Lernfeld 07 knüpft dabei an Lernfeld 03 an und soll die Erfahrungswelt der Lernenden auf die der zu Pflegenden übertragbar machen. Zentrales Instrument bildet auch hier die Pflegeprozesssteuerung in verschiedenen Versorgungskontexten. Grundlegende Annahme ist das salutogenetische Pflegehandeln als Merkmal professioneller Pflege, die sich sowohl an der Umsetzung individueller gesundheitlicher Ziele als auch an der gesellschaftlichen Relevanz von Gesundheit orientiert.		
	Bildungsziele 1./2. AD Die Auszubildenden reflektieren Widersprüche zwischen der Fürsorge für zu pflegende Menschen und gesundheitsbezogener Selbstbestimmung, z. B. Widersprüche zwischen Pflege- und Therapieempfehlungen und biografisch/sozialisatorisch bedingten Gewohnheiten und Bewältigungsstrategien. Sie erkennen Gesundheit als subjektives Konstrukt an, welches nur durch menschzentriertes Pflegehandeln unterstützt werden kann.		
	Didaktischer Kommentar Gesundheit als subjektives Konstrukt soll im Rahmen des theoretischen Unterrichtes als gestaltbar erlebt werden. Dazu eignen sich Methoden, die vor allem personenzentrierte und kreative Ansätze verfolgen. Dabei soll Raum gegeben werden, Spannungsfelder wahrzunehmen und zu ergründen. Im 3. AD soll zusätzlich wissenschaftliches Begründungswissen einbezogen und in tragfähige Konzepte umgesetzt werden. Die Entwicklung von salutogenetischen Ansätzen für verschiedene Kontexte kann dabei auch an den Lernort Praxis gekoppelt werden		
Modul	**Modultitel**	**UE**	**UW**
07-A	**Gesundheitsförderung und Prävention als Anspruch und Ziel des Pflegeberufs erfassen**	8	3-4
	Die Auszubildenden kennen adäquate Möglichkeiten um das Risiko einer Mangelernährung zu identifizieren und Maßnahmen zur Sicherstellung der Ernährung.		
07-B	**Pflegediagnosen im Pflegeprozess mit dem Fokus von Gesundheitsförderung und Prävention formulieren**	8	13-14

	Die Auszubildenden identifizieren Wissensdefizite bei zu pflegenden Menschen und können adäquate Interventionen einleiten.		
07-C	**Die Ottawa-Charta in der Gesundheitsförderung berücksichtigen**	4	16
	Die Auszubildenden können Maßnahmen der Gesundheitsförderung mit den Inhalten der Ottawa-Charta begründen.		
07-D	**Gesundheitsförderung zum Ziel machen**	8	23
	Die Auszubildenden können den Pflegebedarf eines Menschen erfassen und den zu pflegenden Menschen beraten.		
07-E	**Salutogenese eines Menschen in der Rehabilitation fördern**	8	33
	Die Auszubildenden stellen Gesundheitsförderung in der ambulanten Pflege dar, leiten weitere gesundheitsfördernde Maßnahmen ab und begründen diese.		
07-F	**Gesundheitsförderung und Prävention im pflegerischen Handeln gestalten**	4	40
	Die Auszubildenden unterstützen bei Verhaltensänderungen. Sie tarieren dabei Selbstbestimmungsrecht und Fürsorgepflicht.		

Kompetenzen 1./2. AD (Anlage 1 PflAPrV)

KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**
a-i	**a-g**				**a, d**	**d**	**a-c**		**c**				**b, c, e**	**b, c**	

Bezug RLP: CE 04

LF 07	**Bildungsziele 3. AD** Die Auszubildenden nehmen ihre Rolle in der Erhaltung und Förderung von Gesundheit auch auf institutioneller und gesellschaftlicher Ebene wahr und richten ihr Pflegehandeln nach salutogenetischen Grundsätzen aus.		
Modul	**Modultitel**	**UE**	**UW**
07-G	**Gesundheitsförderung auf verschiedenen Ebenen umsetzen**	8	46
	Die Auszubildenden fassen Aufgaben, Organisationsstrukturen und Erkenntnisse zusammen. Decken Grenzen und Grauzonen, aber auch mögliche Handlungsspielräume gesundheitsförderlicher und präventiver Maßnahmen in den verschiedenen Versorgungsbereichen auf.		
07-H	**Empowerment und Partizipation im pflegerischen Handeln umsetzen**	8	53
	Die Auszubildenden betrachten Gesundheitsförderung und präventives Handeln im Pflegeprozess aus Perspektive der gesundheitsbezogenen Herausforderungen in der Gesellschaft und den Gesundheitsrisiken bei zu pflegenden Menschen.		
07-I	**Herausforderungen an eine prozessorientierte Pflege in der ambulanten Pflege professionell begegnen**	4	54
	Die Auszubildenden beurteilen die Zieleformulierung für die ambulanten Pflege vor dem Hintergrund des Präventionsgesetzes und daraus resultierenden Leistungsansprüchen.		

Kompetenzen 3. AD (Anlage 2 PflAPrV)

KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**
b, c, e, f, i	**b,e,f**				**a**								**b, c**		**a, e, f**

Bezug RLP: CE 04

LF 08	**Sicherheit herstellen und vermitteln**	**160 UE**
	Intention und Relevanz Angst, Hilflosigkeit und Unsicherheit sind starke emotionale Motivatoren, denen Lernenden in der eigenen Erfahrungswelt genauso begegnen wie im Kontext der Pflegeausbildung. Lernfeld 08 bietet daher als eigenen Lern- und Entwicklungsfeld Raum zur Auseinandersetzung mit dem Thema Sicherheit auf verschiedenen Ebenen und in diversen Kontexten: von Arbeitsschutz über Hygiene und Gewaltprävention bis hin zur traumasensiblen Pflege und Disaster Nursing. Dabei soll das Herstellen und Vermitteln von Sicherheit als zentrales Handlungsfeld beruflich Pflegender entwickelt werden.	
	Bildungsziele 1./2. AD Die Auszubildenden nehmen den Verantwortungsbereich der Gewährleistung von Sicherheit für zu pflegende Menschen wahr und finden Ansatzpunkte, diese im Pflegehandeln umzusetzen. Sie machen sich dabei eigene innere Konflikte wie auch mögliche innere Konflikte der zu pflegenden Menschen bewusst, die aus dem Bewusstsein des mit medizinischen Interventionen verbundenen Risikos und daraus resultierender Angst entstehen. Die Auszubildenden machen sich bewusst, dass Notfallsituationen und Interventionen mit Folgen für das Leben von Betroffenen verbunden sein können, die dem Willen der betreffenden Person widersprechen können. Sie reflektieren den Widerspruch zwischen dem unmittelbaren Erleben von leiblichen Phänomenen und dem oftmals objektivierenden Umgang damit im medizinischen Kontext. Sie reflektieren Routinen im Hinblick auf ihre wissenschaftliche Grundlage und die Bedeutung von Unsicherheit und Risiko für das persönliche und gemeinschaftliche Leben unter den Bedingungen des globalen gesellschaftlichen Wandels.	
	Didaktischer Kommentar Neben der inhaltlichen Thematisierung von Sicherheitsaspekten und rechtlichen Anforderungen soll hier die Entwicklung von Handlungssicherheit im Fokus stehen. Es eignen sich dazu Rollenspiele, Trainings und Skills-Lab-Einheiten zu verschiedenen Modulen. Die Möglichkeit im geschützten Raum zu trainieren bildet die Basis für performative Kompetenz. Dabei sollen die Szenarien zu Beginn der Ausbildung nahe an der Realität der Lernenden gestaltet werden, etwa durch Bearbeitung konkreter Erlebnisse aus der praktischen Ausbildung. Im 3. AD sollen die Lernenden mit Situationen und Thematiken konfrontiert werden, die auch als „worst-case-Szenarien“ verstanden werden können. Dabei soll die bisher entwickelte Kompetenz auf komplexe und herausfordernde Situationen angewandt werden. Fachstellen und Organisationen wie THW, Feuerwehr, Polizei, Präventionsbeauftragte oder Beratungsstellen können einbezogen werden, um den jeweiligen Kontext der Pflegeschule bzw. der praktischen Lernorte herauszuarbeiten.	

	Achtung: *Die Auseinandersetzung mit Themen wie Gewalt, Missbrauch oder Katastrophen kann bei bestehendem Trauma oder aktueller Belastung triggernd wirken. Die Lehrkraft muss unbedingt sensibel für die Erfahrungen und das Sicherheitserleben der Lernenden sein. Triggerwarnungen müssen vor Beginn entsprechender Unterrichtseinheiten klar und ggf. wiederholend gegeben werden. Lernende müssen das Unterrichtsgeschehen bei Bedarf verlassen dürfen und sollten einen sicheren Raum zum Zurückziehen bzw. Ansprechpersonen haben. Zudem sollten im Bedarfsfall (auf Wunsch der betreffenden Person) entsprechende Beratungs- und Unterstützungsangebote gegeben werden. Dazu ist die Vernetzung der Pflegeschule mit entsprechenden Fachstellen sinnvoll.*		
Modul	**Modultitel**	**UE**	**UW**
08-A	**Ein Bewusstsein für Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz entwickeln**	8	5
	Die Auszubildenden kennen Maßnahmen um Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz zu gewähren. Sind sich der Bedeutung von Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Arbeitsschutz bewusst.		
08-B	**Die Sicherheit von zu pflegenden Menschen in den Fokus nehmen**	12	6-10
	Die Auszubildenden kennen verschiedene Aspekte der Patientensicherheit. Verstehen die Gewährleistung der Patientensicherheit als eine pflegerische Kernaufgabe.		
08-C	**Gewalt in der Pflege erkennen und Möglichkeiten kennenlernen, dieser professionell zu begegnen**	12	11-12
	Die Auszubildenden erkennen Anzeichen möglicher Gewaltausübung. Reflektiern Maßnahmen um den verschiedenen Formen von Gewalt professionell zu begegnen. Entwickeln eine professionelle Haltung im Umgang mit Gewaltphänomenen.		
08-D	**Menschen mit Demenz Orientierung und Sicherheit bieten**	8	19
	Die Auszubildenden vermitteln Menschen, die in Ihrer Selbstbestimmung eingeschränkt sind, Orientierung und Sicherheit.		
08-E	**Menschen mit Angst vor bevorstehenden medizinischen Maßnahmen wertschätzend und professionell begegnen**	6	20
	Die Auszubildenden nehmen diagnostische und Therapeutische Maßnahmen als potentielle Bedrohung für Menschen wahr. Begegnen diesen mittels einer personenzentrierten Haltung.		

	Wirken an diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen unter Berücksichtigung rechtlicher Rahmenbedingung mit.		
08-F	**Menschen mit Angst in der Durchführung des Alltags unterstützen**	8	27
	Die Auszubildenden nutzen ausgewählte Assesmentverfahren um pflegerische Maßnahmen ableiten und begründen zu können.		
08-G	**Arzneimittelsicherheit als Verantwortungsbereich wahrnehmen und herstellen**	14	28-30
	Die Auszubildenden entwickeln ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer verantwortungsbewussten Umsetzung der Arzneimittelsicherheit und den damit verbundenen gesetzlichen Rahmenbedingungen.		
08-H	**Bei der Evakuierung von stationären Pflegeeinrichtungen mitwirken**	8	34
	Die Auszubildenden können im Falle einer notwendigen Evakuierung entsprechende Maßnahmen einleiten, um sowohl die Sicherheit der zu pflegenden Menschen als auch die eigene Sicherheit zu gewährleisten.		
08-I	**Hygieneanforderungen beachten und Grundregeln der Infektionsprävention in der klinischen Pflege umsetzen**	8	35
	Die Auszubildenden nutzen ihr Wissen zu den Grundlagen der Infektionsprävention und leiten entsprechend ärztlicher Anordnung bedarfsgerechte Maßnahmen in der Therapie chronischer Wunden ein.		
08-J	**Bei der Umsetzung sicherer medizinischer Maßnahmen mitwirken (Safe surgery)**	8	41
	Die Auszubildenden können präoperative Maßnahmen nach ärztlicher Anordnung fachgerecht durchführen und handeln nach geltenden Standards. Instrumente der Qualitätssicherung und Patientensicherheit werden dabei berücksichtigt.		
08-K	**Vitale Bedrohungen erkennen und adäquate Maßnahmen einleiten**	8	42
	Die Auszubildenden schätzen die vitale Bedrohung situationsgerecht ein und leiten Sofortmaßnahmen ein.		

Kompetenzen 1./2. AD (Anlage 1 PflAPrV)															
KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**
c, d, e, f, i	**f, g**		**a-c**			**b-e**		**c**			**a-e**	**a, b**			**b, c**
Bezug RLP: CE 05, CE 06															

LF 08	**Bildungsziele 3. AD** Die Auszubildenden setzen sich mit der gesellschaftlichen, ethischen und rechtlichen Debatte zur Organspende auseinander und finden hierzu eine eigene Haltung. Sie finden Ansätze zur Herstellung von Sicherheit und Risikominimierung in verschiedenen Versorgungskontexten. **Didaktischer Kommentar** Im Rahmen der Verfügungsstunden Modul 08-L im 3. AD wieder aufgreifen und in Bezug auf Kompetenzen aus dem 3.AD thematisieren.		
Modul	**Modultitel**	**UE**	**UW**
08-L	**Sich mit verschiedenen Interessenlagen zum Thema Organspende auseinandersetzen**	16	44-45
	Die Auszubildenden entwickeln eine differenzierte Haltung zum Thema Organspende und reflektieren eigene Wertvorstellungen im Kontext der Berufsausübung. Setzen sich mit der der gesellschaftlichen, ethischen und rechtlichen Debatte zur Organspende auseinander und finden zwischen Selbstbestimmung und Gemeinwohlinteressen bzw. Solidarität hierzu eine eigene Haltung.		
08-M	**Disaster Nursing als berufliches Handlungsfeld anerkennen und mitgestalten**	16	48-50
	Die Auszubildenden können in Katastrophensituationen zielgerichtet agieren und zur Herstellung von Sicherheit beitragen.		

08-N	**Kinder nach Gewalt- und Missbrauchserfahrungen begleiten**	12	51-53
	Die Auszubildenden kennen Maßnahmen zur Herstellung von Sicherheit und Schutz. Können eigene Überforderung wahrnehmen und Unterstützung einfordern.		
08-O	**Pflegeprozesse in verschiedenen Kontexten traumasensibel gestalten**	16	54-57
	Die Auszubildenden gestalten verantwortlich traumasensible Pflegeprozesse und leiten Hilfskräfte sowie Kolleg:innen bedarfsgerecht an.		

Kompetenzen 3. AD (Anlage 2 PflAPrV)

KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV. 1**	**KS IV. 2**	**KS V.1**	**KS V.2**
d			**a-c**		**a**	**b, c**		**b, c**		**b**					**b, c**

Bezug RLP: CE 06

LF 09	**Gesellschaftliche, kulturelle und sexuelle Vielfalt als Chance für bedarfsgerechte professionelle Pflege anerkennen**	**90 UE**
	Intention und Relevanz In insgesamt 10 Modulen werden über den gesamten Ausbildungsverlauf hinweg verschiedene Lebensentwürfe, kulturelle Bedarfe und gesellschaftliche Kontexte beleuchtet. Es soll zu einer offenen Auseinandersetzung mit vorherrschenden Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierungsdimensionen angeregt werden. Hierbei steht die Entwicklung einer diversitätssensiblen Haltung als Grundlage für menschzentrierte und transkategoriale Pflege im Mittelpunkt.	
	Bildungsziele 1./2. AD Die Auszubildenden reflektieren den Widerspruch zwischen Nah-Sein in der Pflegebeziehung und Fremdheitserleben in der Konfrontation mit Lebensentwürfen und Lebenswelten anderer Menschen. Sie setzen sich mit vorgeprägten Menschen- und Familienbildern sowie mit sogenannten „Normalbiografien“ und Stereotypen auseinander.	
	Didaktischer Kommentar Berufliche Pflege und Diskriminierung sind unvereinbar. Dabei ist für die Lernenden die Entwicklung einer professionellen beruflichen Rolle und die eventuelle Distanzierung von persönlichen Haltungen von zentraler Bedeutung. Das Erleben eines möglichst diskriminierungsfreien Umfeldes ermöglicht es den Lernenden, dies in das eigene Pflegehandeln einfließen zu lassen. Der Lernort Pflegeschule und der Lehrkörper sollten daher offen reflektieren, inwieweit die Lernenden diskriminierenden Strukturen ausgeliefert sind und diese offen und konstruktiv bearbeiten. Eine klare Haltung gegen Diskriminierung und für gesellschaftliche Vielfalt als Normalität ist unbedingt notwendig, um authentische Lernprozesse anzuregen. Dies bedeutet u.U. auch die aktive Abkehr von cis-heteronormativen Haltungen und/oder positivem Rassismus. Es sind grundsätzlich Methoden zu wählen, die sowohl diskursive Auseinandersetzungen als auch Selbstreflexion ermöglichen und die subjektive Lebens- und Arbeitsrealität der Lernenden berücksichtigt. Aktuelles Zeitgeschehen sowie spezifische Kontexte der Lernorte sollten ergänzend einbezogen werden. Modul 09-H wird in UW 57-58 fortgeführt um mit Kompetenzen der Anl. 2 bearbeitet zu werden.	

	Achtung: *Die Thematisierung von Diskriminierungserfahrungen kann bei bestehendem Trauma oder aktueller Belastung triggernd wirken. Die Lehrkraft muss unbedingt sensibel für die Erfahrungen und das Sicherheitserleben der Lernenden sein. Triggerwarnungen müssen vor Beginn entsprechender Unterrichtseinheiten klar und ggf. wiederholend gegeben werden. Lernende müssen das Unterrichtsgeschehen bei Bedarf verlassen dürfen und sollten einen sicheren Raum zum Zurückziehen bzw. Ansprechpersonen haben. Zudem sollten im Bedarfsfall (auf Wunsch der betreffenden Person) entsprechende Beratungs- und Unterstützungsangebote gegeben werden. Dazu ist die Vernetzung der Pflegeschule mit entsprechenden Fachstellen sinnvoll.*

Modul	Modultitel	UE	UW
09-A	**Ein Bewusstsein für kulturelle Vielfalt entwickeln**	4	7
	Die Auszubildenden entwickeln ein erstes pflegerisches Verständnis für die Bedeutung von kultureller Vielfalt im Rahmen der Pflegeprozessgestaltung.		
09-B	**Diskriminierungserfahrungen am Arbeitsplatz reflektieren**	8	13-14
	Die Auszubildenden reflektieren eigene bzw. beobachtete Diskriminierungserfahrung welche Sie im Rahmen des Kollegiums bzw. durch zu pflegende Menschen erfahren haben. Gehen im Team professionell mit Diskriminierungserfahrungen um.		
09-C	**Ein Grundverständnis für sexuelle Diversität entwickeln**	12	16-21
	Die Auszubildenden erkennen Diversität von geschlechtlichen Identitäten und sexuellen Orientierungen als Normalität an und können sensibel kommunizieren.		
09-D	**Menschen bei ihrer Religions- und Glaubensausübung unterstützen**	12	22-24
	Die Auszubildenden integrieren verschiedene Glaubens- und Religionsausübungen in die Pflegeprozessgestaltung.		
09-E	**Regenbogenfamilien bei der Lebensgestaltung unterstützen**	8	32
	Die Auszubildenden setzen sich mit gesellschaftlichen Veränderungen von Familiensystemen auseinander. Beziehen ihr Wissen über unterschiedliche Familiensysteme in die Pflegeprozessgestaltung mit ein.		
09-F	**Kulturelle Gewohnheiten bei Menschen mit eingeschränkter Selbstbestimmung ermöglichen**	8	37-38
	Die Auszubildenden nutzen ihr Wissen über die Bedeutung von kulturellen Gewohnheiten im Rahmen der Pflegeprozessgestaltung bei Menschen mit eingeschränkter Selbstbestimmung.		

Kompetenzen 1./2. AD (Anlage 1 PflAPrV)															
KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**
g				**a-d**	**a, d**	**b, e**			**c, e**		**a**				**f**
Bezug RLP: CE 09															

LF 09	**Bildungsziele 3. AD** Die Auszubildenden entdecken das Spannungsverhältnis zwischen Erwartungen der Bevölkerung an das Gesundheits- und Sozialsystem bei Eintritt von Pflegebedürftigkeit und den gesellschaftlichen Erwartungen an die eigene/familiale Pflegebereitschaft. Sie entwickeln gender- und kultursensible Ansätze für die Pflegeprozessgestaltung auch bei divergierenden Haltungen. Sie entwickeln ein Bewusstsein für wissenschaftlich Ungeklärtes und mögliche ethische Dilemmata im Kontext einer vielfältigen Gesellschaft und Globalisierungsprozessen.		
Modul	**Modultitel**	**UE**	**UW**
09-G	**Chancen für kultursensible Pflege im herausfordernden familiären Kontext gestalten**	8	40
	Die Auszubildenden reflektieren Möglichkeiten im Umgang mit herausfordernden Situationen im familiären Kontext. Nehmen Familiensysteme als Ressource wahr. Setzen sich für die Belange einzelnen Familienmitgliedern ein.		
09-H	**Perspektiven gender- und diversitätssensibler Medizin und Pflege erkennen**	14	47-49
	Die Auszubildenden begründen das eigene pflegerische Handeln im Kontext medizinischer Diagnostik und Therapie anhand gendermedizinischer und pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse.		
09-I	**Ethische Entscheidungsfindung bei Menschen mit radikalen Lebensentwürfen**	8	56
	Die Auszubildenden entwickeln eine professionelle Haltung gegenüber Menschen mit divergierenden Sichtweisen. Integrieren konkurrierende ethische Prinzipien in den Prozess der Entscheidungsfindung.		
09-J	**Kultursensible Pflege verantwortlich und umfassend gestalten (Prüfungsvorbereitung)**	8	61
	Die Auszubildenden gestalten den Pflegeprozess von Menschen mit Kommunikationsbarrieren und stimmen die Pflegeprozessgestaltung in qualifikationsheterogenen Pflegeteams ab.		

Kompetenzen 3. AD (Anlage 2 PflAPrV)															
KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**
g, i				**a-d**	**d, e**	**b, e**		**b**	**a, c, e**		**a**				
Bezug RLP: CE 09															

LF 10	**Menschen aller Altersstufen mit akuten Gesundheitsproblemen kurativ unterstützen**	**270 UE**
	Intention und Relevanz Als zeitlich umfangreichtes Lernfeld behandelt Lernfeld 10 mit insgesamt 20 Modulen die Handlungsfelder beruflich Pflegender in kurativen Prozessen. Die Unterstützung von Menschen bei der Bewältigung akuter Gesundheitsprobleme und daraus resultierender Pflegebedarfe steht im Zentrum der curricularen Konstruktion. Dabei sollen sowohl die Pflegeprozesssteuerung in unterschiedlichen Versorgungskontexten als auch die Rolle beruflich Pflegender im interprofessionellen Team als zentrale Kompetenzen entwickelt werden. Kuratives Pflegehandeln ist dabei nicht auf den Bereich klinischer Pflege begrenzt, sondern soll auch als wiederkehrendes Handlungsfeld in dauerhaften Pflegesituationen verstanden werden. Akute Gesundheitsprobleme sollen in ihrer jeweiligen Bedeutungsdimension verstanden und bearbeitet werden. Dabei werden durch Verknüpfungen der Module Relationen zu den Bereichen präventiver und rehabilitativer pflege hergestellt. Von zunehmender Bedeutung werden im Verlauf der Ausbildung die jeweiligen sozialen Bezugssysteme von erkrankten und/oder zu pflegenden Menschen und deren Einfluss auf die Gestaltung kurativer Pflegeprozesse.	
	Bildungsziele 1./2. AD Die Auszubildenden machen sich eigene innere Konflikte wie auch mögliche innere Konflikte der zu pflegenden Menschen bewusst, die aus dem Bewusstsein des mit kurativen Interventionen verbundenen Risikos und daraus resultierender Angst entstehen. Sie reflektieren den Widerspruch zwischen dem unmittelbaren Erleben von leiblichen Phänomenen und dem oftmals objektivierenden Umgang damit im medizinischen Kontext. Sie erkennen Diskrepanzen zwischen dem Recht auf Selbstbestimmung und klinischer Praxis, auch in der Behandlung und Pflege von Kindern und Jugendlichen. Sie reflektieren Routinen im Hinblick auf ihre wissenschaftliche und ethische Grundlage.	
	Didaktischer Kommentar Die inhaltlich zu behandelnden Erkrankungen sind als exemplarische Anlässe zur Entstehung spezifischer Pflegephänomene zu verstehen. Die Lehrkraft sollte die Pflegdiagnose(n) als primären Handlungsanlass beruflich Pflegender priorisieren. Die medizinische Diagnose dient dabei der Begründung der Pflegediagnose und sollte nicht zentrales Thema zur Entwicklung von Pflegeprozessen sein. Hier ist	

	ggf. eine Reflexion der eigenen beruflichen Bildung bzw. Sozialisation hilfreich, um sich von einer arztzentrierten beruflichen Rolle distanzieren zu können. Ein Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich des Erwerbs sämtlicher fachspezifischer Pflegetechniken bzw. möglicher ärztlich delegierter Tätigkeiten kann nicht erhoben werden. Dennoch sollten Interessen und Praxiserfahrungen von Lernenden aufgegriffen und beispielsweise zur Binnendifferenzierung oder für Exkurse genutzt werden können. Die Wahlmodule T-W-1 bis T-W-4 im dritten AD können als Basis für Problemorientiertes Lernen, zur Binnendifferenzierung oder zur Spezialisierung genutzt werden. Die Entscheidung trifft die Lehrkraft im Rahmen der Bedingungsanalyse für die jeweilige Lernendengruppe. Fachpraktischer Unterricht und Skills-Lab-Szenarien bieten den Lernenden geschützte Räume zur Erprobung von Pflegetechniken und Gesprächssituationen.		
Modul	**Modultitel**	**UE**	**UW**
10-A	**Menschen mit Pflegebedarf bei Beeinträchtigungen des Stütz- und Bewegungsapparates kurativ unterstützen**	8	5-6
	Die Auszubildenden nehmen Sturzangst wahr und identifizieren in Interaktion mit den Bezugspersonen potenzielle Ressourcen zur Förderung der Mobilität. Können Schmerzen einschätzen.		
10-B	**Menschen mit Beeinträchtigung der Atmung kurativ unterstützen**	8	7-8
	Die Auszubildenden kennen Grundlagen der Infektionsprävention und deren Anwendungsgebiete. Können entsprechend relevante pflegebezogene Daten erheben.		
10-C	**Anatomische und physiologische Zusammenhänge des Urogenitaltraktes verstehen**	8	10
	Die Auszubildenden kennen anatomische Strukturen und physiologische Grundlagen harnableitender Organe sowie inneren und äußeren Aufbau der Geschlechtsorgane.		
10-D	**Menschen mit beeinträchtigten Ausscheidungsvorgängen kurativ unterstützen**	8	13
	Die Auszubildenden erkennen die Bedeutung von Ausscheidungsprozessen für den zu pflegenden Menschen. Können fachgerecht Urinableitungen durchführen.		

10-E	**Menschen mit dem Risiko einer Lungenembolie kurativ unterstützen**	16	14-15
	Die Auszubildenden nehmen die subjektive Belastung von Menschen mit Erkrankungen des Kreislauf- und Gefäßsystems wahr. Entwickeln bedarfsgerechte Pflegeziele und evaluieren diese. Wirken nach ärztlicher Anordnung bei Diagnostik und Therapie mit.		
10-F	**Menschen mit Gesundheitsproblemen bei Verdauungsvorgängen kurativ unterstützen**	16	18-21
	Die Auszubildenden verstehen die Bedeutung der Nahrungsaufnahme auf biofunktionaler und sozialer Ebene. Kennen ernährungsphysiologische Grundlagen und können Menschen hinsichtlich gesundheitsfördernder Maßnahmen informieren. Können sowohl den Ernährungszustand als auch das Risiko einer Mangel- bzw. Unterernährung von Menschen aller Altersstufen einschätzen.		
10-G	**Menschen mit Pflegebedarf aufgrund von Infektionen kurativ unterstützen**	16	25-26
	Die Auszubildenden erkennen Infektionserkrankungen und können Grundregeln der Infektionsprävention für Wohneinrichtungen anwenden. Kennen Pflichten zur Dokumentation und Informationsweitergabe.		
10-H	**Menschen nach operativen Eingriffen, dem Risiko von Komplikationen und mit akuten Schmerzen betreuen**	16	30-33
	Die Auszubildenden erkennen frühzeitig häufige Komplikationen nach operativen Eingriffen. Orientieren sich an Evidenzbasierten Leitlinien und Standards. Können sich notwendiges Wissen aneignen und ihr Handeln begründen.		
10-I	**Menschen nach vaginalen, abdominalen oder laparoskopischen Eingriffen kurativ unterstützen**	8	34
	Die Auszubildenden erkennen und bewerten Pflegephänomene nach medizinischen Eingriffen unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Besonderheiten. Kennen Aspekte genderspensibler Pflege und können diese in die Gestaltung des Pflegeprozesses einbringen.		

10-J	**Menschen mit riskantem Sexualverhalten gesundheitsfördernd informieren**	8	35
	Die Auszubildenden kennen mögliche Folgen riskanten Sexualverhaltens und können Menschen dementsprechend informieren. Können die Kommunikation bedarfsgerecht und professionell gestalten.		
10-K	**Menschen mit eingeschränkten Sinnesfunktionen kurativ unterstützen**	16	36-37
	Die Auszubildenden können Menschen mit Sinnesbehinderungen unter Berücksichtigung ihrer individuellen Situation ganzheitlich pflegen und betreuen. Verständigungsprobleme werden erkannt und durch geeignete Maßnahmen überbrückt.		
10-L	**Menschen bei beeinträchtigter Stoffwechsellage kurativ unterstützen**	12	40-41
	Die Auszubildenden können Pflegebedarfe bei Stoffwechselerkrankungen einschätzen, evidenzbasierte Pflegekonzepte didaktisch aufbereiten und vermitteln und das Pflegehandeln unter Berücksichtigung von Genderaspekten reflektieren.		

Kompetenzen 1./2. AD (Anlage 1 PflAPrV)

KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV. 2**	**KS V.1**	**KS V.2**
a-i	**a-c, f, g**			**a**	**d**	**a, b, d, e**	**b**			**a-d**	**d**	**a, b**	**e**	**a-c**	

Bezug RLP: CE 05, CE 10

LF 10	**Bildungsziel 3. AD** Die Auszubildenden finden bedarfsgerechte Unterstützungsmöglichkeiten in der Versorgung von Menschen mit komplexen gesundheitlichen Problemlagen und können diese auf Basis vorhandener Evidenzen begründen. Sie gehen wertschätzend mit Bezugspersonen und deren Expertise in der Betreuung von zu pflegenden oder erkrankten Menschen um und gestalten entsprechende von Informations- und Beratungsgespräche. In Bezug auf die Zusammenarbeit mit Ärzt:innen erarbeiten die Auszubildenden den Widerspruch, dass die Berufsgruppen gleichwertig und gleichberechtigt zusammenarbeiten sollen und dass sie gleichzeitig auch in Konkurrenz und in einem hierarchischen Verhältnis zueinanderstehen. Sie erkennen damit verbundenen Rollenkonflikte und entwickeln eine ethisch reflektierte Position. Die Auszubildenden finden Ansatzpunkte und Chancen der beruflichen Pflege, zur gesundheitlichen Chancengerechtigkeit beizutragen.		
Modul	**Modultitel**	**UE**	**UW**
10-M	**Menschen und ihre Bezugssysteme nach viszeralchirurgischen Eingriffen kurativ unterstützen**	22	43-44
	Die Auszubildenden können Menschen mit Enterostoma ganzheitlich unter Einbindung der Bezugspersonen unterstützen, auftretende Pflegephänomene und Komplikationen fachgerecht erkennen und behandeln. Reflektieren die Versorgung kontinuierlich auf Basis evidenzbasierter Erkenntnisse.		
10-N	**Gesundheitliche Folgen von Gewalt und Machtmissbrauch erkennen**	10	45
	Die Auszubildenden nehmen Aspekte von Machtmissbrauch in der Betreuung von Menschen aller Altersstufen wahr und finden Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Nutzen digitale pflegediagnostische Instrumente zur Gestaltung eines personenzentrierten Pflegeprozesses.		
10-O	**Menschen mit akut neurologischem Defizit in ihrer Autonomie unterstützen**	14	46-49
	Die Auszubildenden können Pflegeprozesse unter Einbezug von Bezugspersonen auf den individuellen Entwicklungsstand anpassen. Finden dabei Ansatzpunkte für gemeinsame Entscheidungsprozesse. Agieren selbstsicher im interprofessionellen Team, um die Qualität der Versorgung kontinuierlich zu verbessern.		

10-P	**Das Selbstkonzept von Menschen in onkologischer Diagnostik und Therapie stärken**	25	50-51
	Die Auszubildenden beraten Menschen in emotional herausfordernden Situationen im Umgang mit therapeutischen und krankheitsbedingten Herausforderungen und setzen evidenzbasierte Maßnahmen zur Stärkung ihres Selbstkonzept-/bild ein.		
10-Q	**Menschen mit thermisch oder chemisch bedingten Gewebeschädigungen kurativ unterstützen**	18	52-55
	Die Auszubildenden wenden neuste wissenschaftliche Erkenntnisse an um Vorgaben der Qualitätssicherung, im Bereich der Versorgung von Personen mit Gewebeschädigungen einzuhalten. Planen die Pflege des Menschen eigenverantwortlich und berücksichtigen dabei die Lebenssituation der Betroffenen.		
10-R	**Menschen mit veränderter Ausscheidung bei intensivmedizinischer Diagnostik und Therapie begleiten**	10	56
	Die Auszubildenden können Menschen bedarfsgerecht bei invasiven diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen begleiten und für deren Sicherheit sorgen.		
10-S	**Menschen mit eingeschränkter Kommunikation und Atmung bei Diagnostik und Therapie unterstützen**	21	57-58
	Die Auszubildenden können Menschen mit Dysphagie fachgerecht, ganzheitlich und unter Einbindung aller Beteiligten versorgen sowie die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen organisieren. Reflektieren, wie sie zur kontinuierlichen Verbesserung des Versorgungsprozesses beitragen können.		
10-T-W1	**Pflegeprozesse in der onkologischen Pflege gestalten**	10	59
10-T-W2			
10-T-W3			
10-T-W4			
	Die Auszubildenden können Grundlagen der onkologischen Pflege in verschiedenen Versorgungskontexten anwenden und sind in der Lage, den Pflegeprozess professionell, interdisziplinär und unter Berücksichtigung aktueller Leitlinien und Qualitätsstandards zu gestalten und kontinuierlich weiterzuentwickeln.		

Kompetenzen 3. AD (Anlage 2 PflAPrV)															
KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**
a-i	**a, b, e**	**c**			**e**	**d, g**	**a-d**	**b**	**b, c**	**a-f**	**a, e, f**	**b, d**	**a**	**a-c**	**e**
Bezug RLP: CE 05, CE 10															

	Disability: Behinderung als soziales Konstrukt verstehen und Barrieren abbauen	**150 UE**
	Intention und Relevanz Vierzehn Module thematisieren über den gesamten Ausbildungsverlauf hinweg verschiedene Beeinträchtigungen sozialer und kultureller Teilhabe. Dabei wird die Beeinträchtigung selbst nie als Diagnose oder Defizit eines Individuums verstanden, sondern stets als soziales Konstrukt. Im Sinne menschzentrierter und gleichberechtigter rehabilitativer Pflege steht hier der Abbau verschiedener Barrieren und bedarfsgerechte Unterstützung im Mittelpunkt pflegerischen Handelns. Die Erlebniswelt und Autonomie der zu pflegenden Menschen spielt dabei eine zentrale Rolle. Im dritten Ausbildungsdrittel werden zwei Praxisprojekte angeregt, die in Verbindung mit den Lernfeldern vier und sechs zu einem umfassenden Erleben rehabilitativer Pflege und Chancen digitaler und technischer Hilfen beitragen sollen.	
LF 11	**Bildungsziel 1./2. AD** Die Auszubildenden können selbstbewusst den pflegerischen Beitrag zur Wiederherstellung von Gesundheit oder zur Erlangung von Lebensqualität, Autonomie und Selbstständigkeit im interprofessionellen Team ausweisen und positionieren sich dazu. Sie reflektieren widersprüchliche Anforderungen, die sich aus dem Wunsch der zu pflegenden Menschen nach Normalität und gesellschaftlichen Barrieren ergeben. Sie kennen Ansätze zur Entstigmatisierung von Menschen mit beeinträchtigter Teilhabe.	
	Didaktischer Kommentar Das simulative Erleben verschiedener Beeinträchtigungen kann zu einem vertieften Verständnis für eingeschränkte soziale Teilhabe führen. Dazu eignen sich verschiedene praktische Übungen und Selbsterfahrungseinheiten. Zudem sollte die Lebensrealität von Menschen mit Behinderung – insbesondere bei kognitiven Beeinträchtigungen – wertschätzende Beachtung finden. Die Zusammenarbeit mit Fach- und Beratungsstellen (Träger der Eingliederungshilfe, Selbsthilfeorganisationen, Elternverbände etc.) kann den theoretischen Unterricht sinnvoll und praxisnah ergänzen. Modul 11-K wird im 3. AD in UW 53-54 weitergeführt um Kompetenzen des 3. AD anzubahnen.	

Modul	Modultitel	UE	UW
11-A	**Menschen mit geringem Sehvermögen in die Wohngruppe aufnehmen**	8	3-4
	Die Auszubildenden können pflegebezogene Daten erheben. Kennen Möglichkeiten der Pflegeanamnese und Informationssammlung.		
11-B	**Bezugspersonen als Ressource im Umgang von Kindern mit forderndem Verhalten erkennen**	8	16
	Die Auszubildenden nutzen das Umfeld des zu pflegenden Menschen um Ressourcen zu erkennen und zu aktivieren bzw. zu fördern.		
11-C	**Menschen mit Muskeldystrophien bei der Erhaltung der Alltagskompetenz unterstützen**	8	17
	Die Auszubildenden nutzen die Ressourcen des zu Pflegenden und des Umfeldes der zu pflegenden Person um Alltagskompetenzen zu Erhalten bzw. Wiederzuerlangen.		
11-D	**Menschen mit Arm- oder Beinprothese bei der Alltagsbewältigung unterstützen**	8	20
	Die Auszubildenden unterstützen den zu pflegenden Menschen in der Organisation von Terminen und ermöglichen eine selbstbestimmte Lebensführung.		
11-E	**Den Pflegeprozess bei Jugendlichen mit angeborener Behinderung planen**	8	22
	Die Auszubildenden wenden Assessmentverfahren an, um den Pflegeprozess für Menschen mit körperlichen Einschränkungen zu planen und nach hygienischen Richtlinien durchzuführen.		
11-F	**Kinder mit angeborener Behinderung informieren, schulen und anleiten**	8	23
	Die Auszubildenden wenden didaktische Methoden an, um die Organisation und Durchführung des Pflegeprozesses sicherzustellen.		
11-G	**Jugendliche mit kognitiver Beeinträchtigung bei der Bewältigung akuter Gesundheitsprobleme unterstützen**	16	27
	Die Auszubildenden nutzen eigenes Wissen und fordern kollegiale Unterstützung ein, um Menschen mit kognitiven Einschränkungen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen.		

11-H	**Verschiedene Hilfsmittel kennenlernen und erproben**	8	29
	Die Auszubildenden kennen die Funktion von verschiedenen Hilfsmitteln und können fachfremde Pflegepersonen in den Umgang, nach neustem Stand der Wissenschaft, einweisen.		
11-I	**Sekundär- bzw. Tertiärpräventive Pflegeprozesse bei Menschen mit erworbener Behinderung gestalten**	8	32
	Die Auszubildenden kennen präventive Maßnahmen und wenden diese in akuten und dauerhaften Pfllegesituationen ein.		
11-J	**Kinder mit Beeinträchtigung in der Wahrnehmung in der Alltagsbewältigung unterstützen**	20	38-39
	Die Auszubildenden nutzen wissenschaftlich fundiertes Wissen um Menschen mit Einschränkungen der Sinnesorgane eine Partizipation am Alltagsleben zu ermöglichen.		

Kompetenzen 1./2. AD (Anlage 1 PflAPrV)

KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**
b-e	**a-c**			**a**	**a-e**	**a-b**	**a-b**	**b**	**a-b**	**a-b**	**a-d, f**	**b**		**a-c**	

Bezug RLP: CE 07, CE 11

LF 11	**Bildungsziel 3. AD** Für die rehabilitative Pflege in verschiedenen Handlungskontexten reflektieren die Auszubildenden erschwerende institutionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Sie nehmen zu sozialrechtlichen Normen im Hinblick auf ethische und wirtschaftliche Maßstäbe Stellung und reflektieren pflegeberufspolitische Interessenvertretungen im Kontext divergierender Interessen in der Gesundheitspolitik. Die Auszubildenden nutzen aktiv Handlungsspielräume zur Gestaltung rehabilitativer und empowernder Pflegeprozesse und tragen zum Abbau von Barrieren auf verschiedenen Ebenen bei.

Modul	Modultitel	UE	UW
11-K	**Praxisprojekt rehabilitative Pflege**	19	47-48
	Die Auszubildenden entwerfen eigenverantwortlich ein Konzept zum rehabilitativen Pflegehandeln und setzen dieses in einem Feldversuch um. Berücksichtigen dabei sozialrechtliche Leistungsansprüche und qualitätsorientierte Pflegeprozessgestaltung.		
11-L	**Praxisprojekt digitale Lebens- und Arbeitswelten**	16	53-54
	Die Auszubildenden erkennen den Bedarf an digitalen Assistenzsystemen und entwickeln ein eigenes Konzept zu einem digitalen Assistenz- bzw. Unterstützungssystem.		
11-M	**Menschen mit angeborener kognitiver Beeinträchtigung beim Einzug in eine WG unterstützen (Prüfungsvorbereitung)**	8	58
	Die Auszubildenden erkennen Kommunikationsbarrieren und nutzen Ressourcen des zu Pflegenden und die Angehörigen, um den Pflegeprozess individuell an die Fähigkeiten und Bedürfnisse des zu pflegenden Menschen anzupassen.		
11-N	**Pflegeprozesssteuerung von Jugendlichen mit angeborener Körperbehinderung in der Langzeitpflege (Prüfungsvorbereitung)**	7	59
	Die Auszubildenden können ganzheitlich den Pflegebedarf von Menschen in allen Altersstugen ermitteln und eigenständig den Pflegeprozess, unter Einbeziehung von digitalen Assistenz- und Dokumentationssystemen planen, durchführen und evaluieren.		

Kompetenzen 3. AD (Anlage 2 PflAPrV)

KB I						KB II			KB III			KB IV		KB V	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV. 1**	**KS IV. 2**	**KS V. 1**	**KS V. 2**
a-i	**a-f**	**c**		**a, b**	**b-d**	**c, e, g**	**a, c, d**	**A**		**f**	**a-f**	**a, b, d**	**b, d**		

Bezug RLP: CE 07, CE 11

LF 12	**Menschen in der Schwangerschaft und nach der Geburt unterstützen**	**30 UE**	
	Intention und Relevanz Insgesamt drei Module widmen sich der besonderen Lebensphase rund um Schwangerschaft und Geburt. Dabei werden zunächst unproblematische Verläufe thematisiert. Die erworbenen Kompetenzen sollen im dritten Ausbildungsdrittel angewandt werden, um Ansätze für die Unterstützung von Familien mit frühgeborenen Kindern zu finden. Dabei liegt der Schwerpunkt in der bedarfsgerechten Information, Schulung und Anleitung von Familien.		
	Bildungsziel 1./2. AD Kindheit und Jugend bedürfen entsprechend der „Konventionen über die Rechte des Kindes“ des besonderen Schutzes. Die gesellschaftlichen Bedingungen sowie die Kontextbedingungen in der pädiatrischen Versorgung sind den Konventionen zwar verpflichtet, werden diesem Anspruch aber nicht immer gerecht. Auszubildende sollen sich mit diesem Spannungsverhältnis auseinandersetzen und dazu eine begründete und reflektierte Position einnehmen.		
	Didaktischer Kommentar Verluste (Fehlgeburt), Schwangerschaftsabbruch und unerfüllter Kinderwunsch werden ergänzend in Modulen der Lernfelder 9 und 16 thematisiert.		
Modul	**Modultitel**	**UE**	**UW**
12-A	**Werdende Eltern während der Schwangerschaft und bei der Geburt begleiten und unterstützen**	12	19-20
	Die Auszubildenden verstehen den Verlauf einer physiologischen Schwangerschaft und Geburt und beachten die damit zusammenhängenden hygienischen Anforderungen. Verstehen die Schwangerschaft und Geburt als emotionale und soziale Herausforderung.		
12-B	**Junge Familien stärken**	8	25-26
	Die Auszubildenden erfassen Wissensbedarfe junger Eltern und leiten bedarfsgerechte Anleitungs- und Informationsangebote ab und führen diese durch.		

Kompetenzen 1./2. AD (Anlage 1 PflAPrV)															
KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**
	b			**a**			**a**			**a**				**c**	
Bezug RLP: CE 10															

LF 12	**Bildungsziel 3. AD** Häufig zeichnen sich die Bezugspersonen von kranken Säuglingen durch eine hohe Expertise bezüglich des Gesundheitszustandes und der sozialen, emotionalen und kognitiven Kompetenzen ihrer Kinder aus. Dennoch bedarf es der Gestaltung von Informations- und Beratungsgesprächen. Die Auszubildenden erkennen damit verbundene Rollenkonflikte und entwickeln dazu eine berufsethisch reflektierte Haltung.		
Modul	**Modultitel**	**UE**	**UW**
12-C	**Familien in Ausnahmesituationen begleiten, unterstützen und emotional stärken**	10	45-46
	Die Auszubildenden nehmen die emotionale Ausnahmesituation von Familien wahr und führen entsprechend dieser situations- und bedarfsgerechte Schulungs-, Informations- und Unterstützungsangeboten durch.		

Kompetenzen 3. AD (Anlage 2 PflAPrV)															
KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**
	e						**b**	**a**							
Bezug RLP: CE 10															

LF 13	**Menschen aller Altersstufen mit chronischen Erkrankungen in der Entwicklung einer individuellen Gesundheitskompetenz unterstützen**	**140 UE**
	Intention und Relevanz In 22 Modulen werden über den gesamten Ausbildungsverlauf Lernsituationen kreiert, anhand derer die bedarfsgerechte Unterstützung chronisch erkrankter Menschen unter salutogenetischen Aspekten entwickelt werden soll. Dabei sind die Module an Module anderer Lernfelder gekoppelt, um neben kurativen oder rehabilitativen Ansätzen vor allem Ansatzpunkte für Empowermentprozesse zu beleuchten. Unter der Annahme von Gesundheit als subjektive Konstruktion und der Anwendung des biopsychosozialen Modells sollen die Auszubildenden in der Entwicklung bedarfsgerechter und evidenzbasierter Interventionen gefördert werden.	
	Bildungsziel 1./2. AD Die Auszubildenden reflektieren Widersprüche zwischen der Fürsorge für zu pflegende Menschen und gesundheitsbezogener Selbstbestimmung, z. B. Widersprüche zwischen Pflege- und Therapieempfehlungen und biografisch/sozialisatorisch bedingten Gewohnheiten und Bewältigungsstrategien. Sie reflektieren Widersprüche, die sich aus dem Erleben von Leid und Schmerz und möglichen (Selbst- und Fremd-)Erwartungen an das Verhalten ergeben. Sie finden Ansatzpunkte für salutogenetische Maßnahmen zur Förderung physischer, psychischer und vor allem auch sozialer Gesundheit von chronisch erkrankten Menschen.	
	Didaktischer Kommentar Im Kontext der Pflege von chronisch erkrankten Menschen sollen Empowerment-Prozesse im Fokus stehen. Die Vermittlung rein edukativer Ansätze in der Unterstützung chronisch Erkrankter birgt das Risiko einer Advokat:innenhaltung, die sich nachweislich wenig profitabel auf die Gesundheitssituation bzw. die Lebensqualität auswirkt. Vielmehr soll ein Bewusstsein für subjektive Einstellungen zur individuellen Vorstellung von Gesundheit und Lebensqualität entwickelt werden, welches menschzentrierte Interventionen und Angebote ermöglicht. Diese sollten stets multiprofessionelle Ansätze berücksichtigen und auf die Lebenswelt der zu pflegenden Personen abgestimmt sein. Hier kann auf Erfahrungen und Gelerntes aus den Lernfeldern 3 und 7 rekurriert werden. Es eignen sich didaktische Ansätze, die vielfältige Lösungen und kreative Ideen hervorbringen. Die Lehrkraft sollte daher ergebnisoffenen Unterricht gestalten können.	

Modul	Modultitel	UE	UW
13-A	**Verschiedene Dimensionen von Gesundheit bei chronisch erkrankten Menschen erkennen**	4	6
	Die Auszubildenden ordnen die Gesundheitsförderung in Pflegeprozess ein, um in der Entwicklung der Gesundheitskompetenz zu unterstützen.		
13-B	**Selbstfürsorge und Gesundheitskompetenz betrachten**	8	7
	Die Auszubildenden verstehen Empowerment-Prozesse als Teil um die Gesundheitskompetenz zu stärken und beschreiben die Bereiche von Gesundheitskompetenz.		
13-C	**Gesundheitsförderung phasengerecht gestalten I**	8	12
	Die Auszubildenden können Maßnahmen der Gesundheitsförderung bei chronisch erkrankten Menschen planen und durchführen.		
13-D	**Menschen mit Hauterkrankungen gesundheitsfördernd unterstützen**	8	13-15
	Die Auszubildenden schätzen Pflegebedarfe bei Hauterkrankungen ein und finden Maßnahmen zur individualisierten Gesundheitsförderung.		
13-E	**Mangelnde Gesundheitskompetenz im Umgang mit Diabetes und dem Risiko der unwirksamen Therapie präventiv entgegenwirke**	8	18-19
	Die Auszubildenden identifizieren Unterstützungsbedarfe bei Menschen mit gesundheitsschädigendem Verhalten.		
13-F	**Die Entwicklung von Gesundheitskompetenz bei Menschen mit Stoffwechselerkrankungen stärken**	4	21
	Die Auszubildenden erfassen Maßnahmen um Sekundärschäden bei Hyperlipidämie vorzubeugen und zu pflegende Menschen zu beraten.		
13-G	**Menschen mit Schilddrüsenfunktionsstörung in der Gesundheitskompetenz unterstützen**	4	22
	Die Auszubildenden erkennen Selbstpflegedefizite und können zu pflegende Menschen in der Durchführung von Maßnahmen zur Steigerung der Gesundheitskompetenz anleiten.		

13-H	**Bezugspersonen von Menschen mit Demenz stärken und unterstützen**	4	24
	Die Auszubildenden stärken und fördern pflegende Angehörige in ihrer Gesundheitskompetenz.		
13-I	**Menschen mit Dysphagie bedarfsgerecht unterstützen I**	4	30
	Die Auszubildenden identifizieren Verbessserungspotenziale im individuellen Pflegeprozess um die Gesundheitskompetenz bei zu pflegenden Menschen und ihren Bezugspersonen zu unterstützen		
13-J	**Menschen mit Herz-Kreislaufstörungen in der Entwicklung ihrer Gesundheitskompetenz unterstützen.**	8	31
	Die Auszubildenden identifizieren gesundheitsschädliches Verhalten und unterstützen bei Lebensstiländerungen.		
13-K	**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in der Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeit unterstützen**.	4	36
	Die Auszubildenden erkennen Selbst- und Fremdgefährdung, nehmen Überforderungssituationen der zu pflegenden Menschen wahr, stimmen Therapie- und Aktivitätsangebote mit zu pflegenden Menschen und Bezugspersonen ab.		
13-L	**Menschen mit dem Risiko von Komplikationen in ihrer Gesundheitskompetenz stärken**	8	37
	Die Auszubildenden agieren professionell in Konfliktsituationen und nutzen medizinisch und pflegerisches Fachwissen, um den zu pflegenden Menschen im gesundheitsförderlichen Verhalten zu unterstützen		
13-M	**Empowerment und Partizipation im pflegerischen Handeln umsetzen**	4	41
	Die Auszubildenden anerkennen von Empowermentprozessen und Partizipation um Gesundheitskompetenz zu stärken		
13-N	**Lebensqualität bei schwerstkranken Menschen fördern**	4	42
	Die Auszubildenden nutzen Möglichkeiten der Förderung der Lebensqualität im Rahmen von Palliativ Care. Fördern die Lebensqualität von schwerstkranken Menschen und deren Bezugspersonen.		

Kompetenzen 1./2. AD (Anlage 1 PflAPrV)															
KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**
a-i	**a-g**	**a-d**			**a,d**	**a, b, d**	**a-c**	**a, c**	**a-c**	**a, d**	**c, e**	**b**	**b, e**	**b-c**	**b-c**
Bezug RLP: CE 04, CE 08															
LF 13	**Bildungsziel 3. AD** Die Lernenden reflektieren den gesellschaftlich-kollektiven, institutionellen und individuellen Umgang mit Erkrankung, Verlust und Tod in unterschiedlichen Altersstufen und Lebensphasen. Sie finden im Spannungsfeld von Leiderfahrung und institutionellen Rahmenbedingungen eine professionelle und salutogenetische Haltung.														

Modul	Modultitel	UE	UW
13-O	**Gesundheitskompetenz der zu pflegenden Menschen in den Fokus nehmen**	8	43
	Die Auszubildenden reflektieren widerstreitende gesundheitsbezogene Bedürfnisse wie unmittelbare Bedürfnisbefriedigung vs. langfristige Bedarfe wie Gesundheit oder Lebensqualität vs. Lebensdauer.		
13-P	**Zu pflegende Menschen mit dem Risiko von ernährungsbedingten Komplikationen unterstützen**	4	44
	Die Auszubildenden stellen die Energie- und Nährstoffzufuhr von Menschen mit Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes sicher, indem sie in Abstimmung mit Ernährungsberatung und Kooperation mit dem zu pflegendem Menschen einen bedarfsgerechten Maßnahmenplan (Ernährungsplan) erstellen.		
13-Q	**Die Entwicklung und den Erhalt von Gesundheit bei Menschen mit Störungen der Motorik fördern**	8	47-48
	Die Auszubildenden berücksichtigen das individuelle Gesundheitsverständnis von zu pflegenden Menschen, fördern die Eigenaktivität von Menschen mit Parkinson, leiten in neuen Fertigkeiten an um körperliche Einschränkungen zu kompensieren und identifizieren Selbstfürsorgekompetenzen.		
13-R	**Bei zu pflegenden Menschen mit Nierenfunktionsstörungen Empowermentprozesse gestalten**	9	49
	Die Auszubildenden entwickeln mit dem zu pflegenden Menschen und dessen sozialen Netz lebensweltorientierte Angebote zur Auseinandersetzung und Bewältigung von drohender Pflegebedürftigkeit und ihren Folgen.		
13-S	**Gesundheitsförderung in verschiedenen pflegerischen Handlungsfeldern umsetzen**	4	50
	Die Auszubildenden unterstützen den zu pflegenden Menschen in Phasen der Demotivierung und Mutlosigkeit, halten negative Gefühle aus, reflektieren das Spannungsfeld zwischen der Anerkennung der Autonomie des zu Pflegenden und der Verpflichtung zur Fürsorge, reflektieren kritische Lebenssituationen		
13-T	**Wundtherapie in der ambulanten Pflege evidenzbasiert gestalten**	12	51-56
	Die Auszubildenden setzen geeignete und evidenzbasierte pflegerische Interventionen in der kausalen Therapie chronischer Wunden um. Identifizieren spez.		

	Informations- u. Beratungsinhalte und verstehen, weshalb zu pflegende Menschen u./o. der Bezugspersonen zu gesundheitsschädlichen Versorgungsmaßnahmen greifen.		
13-U	**Gesundheitskompetenz von Menschen mit chronischen Wunden stärken**	7	57-58
	Die Auszubildenden setzen die Möglichkeiten der Gesundheitsförderung und Förderung der Lebensqualität in den Fokus.		
13-V	**Empowerment als Bestandteil salutogenetischer Pflege umsetzen**	8	59
	Die Auszubildenden finden auch in komplexen Pflegesituationen Ansatzpunkte für Empowerment und unterstützen somit salutogenetisch Menschen in ihrer Gesundheitskompetenz.		

Kompetenzen 3. AD (Anlage 2 PflAPrV)

KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**
a-i	**a, c, d, e**	**c**			**a, d**	**a, b, d**	**a-d**		**a, c, e**	**d**	**e**	**b, d**	**b, c, e**	**b, c**	

Bezug RLP: CE 04, CE 08

LF 14	**Menschen aller Altersstufen mit Selbstpflegedefizit im Alltag und der autonomen Lebensführung unterstützen**	**200 UE**
	Intention und Relevanz Lernfeld zwei widmet sich in 24 Modulen der Unterstützung von Menschen, die unabhängig von medizinischen Diagnosen Unterstützung bei der Bewältigung der Selbstpflege benötigen. Das Lernfeld wird mit Ende des zweiten Ausbildungsdrittels abgeschlossen und bietet daher vorwiegend unproblematische bzw. problemidentifizierende Pflegsituationen in verschiedenen Versorgungskontexten. Im Fokus stehen dabei die Bedarfe und Ressourcen des Individuums als Ansatzpunkte für aktivierendes Pflegehandeln. Zentral soll dabei die Kompetenz zur Förderung der Selbstbestimmung und Autonomie im Pflegeprozess entwickelt werden.	
	Bildungsziel 1./2. AD Pflegerische Handlungen zur Unterstützung bei der Selbstversorgung, die von Anfang an in der beruflichen Praxis gefordert werden, erfordern körpernahe Interaktionen mit meist fremden zu pflegenden Menschen. Die Auszubildenden erfahren dabei sich selbst wie auch andere Menschen in ihrer Leibkörperlichkeit. Sie erleben und reflektieren eigene Grenzen und widersprüchliche Emotionen und Bedürfnisse, auch in Bezug auf ihre eigene Unsicherheit und Verantwortung. Sie sollen sehr körpernahe und intime pflegerische Handlungen einfühlsam und fachgerecht durchführen und erleben dabei eigene wie auch fremde emotionale Reaktionsmuster, auf die sie unmittelbar in ihrer Kommunikation und Interaktion mit den zu pflegenden Menschen reagieren müssen. Reflexionsprozesse in diesem Spannungsfeld bilden ein zentrales Bildungsziel. Gleichzeitig sind die Auszubildenden herausgefordert, sich in einen fremden institutionellen Kontext mit seinen organisatorischen, ökonomischen und rollenspezifischen Anforderungen einzufinden und beginnende Handlungssicherheit aufzubauen. Im Spannungsfeld der beschriebenen Anforderungen lernen die Auszubildenden, ihre Emotionen und Handlungsmuster zu reflektieren und systemische Grenzen wahrzunehmen. In einer ersten Annäherung begegnen sie dem Spannungsfeld zwischen idealen Ansprüchen an Pflege und der Wirklichkeit der eigenen persönlich und institutionell begrenzten Handlungsmöglichkeiten und sind gefordert, in diesem Feld situativ nach Lösungen zu suchen.	

	Didaktischer Kommentar Das praktische Üben pflegerischer Handlungen bildet einen zentralen Aspekt der theoretischen Ausbildung. Möglichkeiten der Selbsterfahrung bieten Raum für Reflexion und Entwicklung einer professionellen Haltung. Fachpraktischer Unterricht sollte dabei immer der Herstellung von Handlungssicherheit dienen und Möglichkeiten zum Erproben von Feedback beinhalten. Skills-Lab-Szenarien können basierend auf den Fallgeschichten der Lernsituationen oder ergänzend dazu kreiert werden. Von zentraler Bedeutung für den Kompetenzerwerb ist eine konsequente Anleitung und Reflexion von Theorie-Praxis-Transfers.

Modul	Modultitel	UE	UW
14-A	**Menschen in der Bewegung unterstützen**	8	1
	Die Auszubildenden verstehen die Relevanz pflegdiagnostischer Maßnahmen als Basis fachpflegerischen Handelns.		
14-B	**Menschen bei der Körperpflege unterstützen**	8	2
	Die Auszubildenden können Menschen verschiedener Altersstufen bei der Körperpflege unterstützen.		
14-C	**Kontinenz-Förderung als pflegerisches Handlungsfeld wahrnehmen**	8	3
	Die Auszubildenden erfassen Kontinenzfördernde Maßnahmen. Kennen Strategien für den Umgang mit Ekel- und Schamgefühlen.		
14-D	**Menschen bei der Alltagsgestaltung unterstützen**	8	4
	Die Auszubildenden erfassen die Alltagsgestaltung als zentralen Bestandteil des Lebens und finden Möglichkeiten, diese zu unterstützen.		
14-E	**Wissensbedarfe wahrnehmen und Unterstützung anbieten**	4	5
	Die Auszubildenden erkennen Wissensbedarfe als Handlungsfeld beruflichen Pflegender an.		

14-F	**Menschen mit Hautdefekten bedarfsgerecht unterstützen**	8	8
	Die Auszubildenden evaluieren einfache Pflegemaßnahmen hinsichtlich Wirksamkeit und finden Ansatzpunkte zur Verbesserung.		
14-G	**Atemunterstützende Maßnahmen bedarfsgerecht planen und durchführe**	10	9
	Die Auszubildenden können die Atmung von Menschen verschiedener Altersgruppen einschätzen und finden Möglichkeiten zur bedarfsgerechten Gesunderhaltung bzw. -förderung.		
14-H	**Menschen mit beeinträchtigter Kreislauffunktion unterstützen**	8	11-12
	Die Auszubildenden können die Atmung von Menschen verschiedener Altersgruppen einschätzen und finden Möglichkeiten zur bedarfsgerechten Gesunderhaltung bzw. -förderung.		
14-I	**Menschen mit Angst professionell begegnen**	8	14-15
	Die Auszubildenden wenden Pflegewissenschaftliche Erkenntnisse an, um ihr pflegerisches Handeln im Umgang mit Menschen mit Sturzangst zu begründen.		
14-J	**Schlafförderndes Verhalten unterstützen**	6	16
	Die Auszubildenden finden Möglichkeiten zur Unterstützung von Menschen mit Schlafmangel bzw. verminderter Schlafqualität.		
14-K	**Menschen mit Beeinträchtigung der Konzentration unterstützen**	6	17
	Die Auszubildenden verstehen Aspekte der persönlichen Entwicklung als relevante Pflegephänomene und finden Unterstützungsmöglichkeiten.		
14-L	**Aufbau und Funktion des Gastrointestinaltraktes verstehen**	6	18
	Die Auszubildenden kennen anatomische Strukturen und physiologische Grundlagen gastrointestinaler Organe.		
14-M	**Menschen bei der Nahrungsaufnahme bedarfsgerecht unterstützen**	6	20

	Die Auszubildenden können personenzentriert Nahrung anreichen und eine Aspirationsprophylaxe durchführen.		
14-N	**Menschen mit Risiko für Stoffwechselentgleisung unterstützen**	6	21
	Die Auszubildenden können Risiken für Hypo- und Hyperglykämie bei Menschen mit Diabetes mellitus einschätzen und finden bedarfsgerechte Maßnahmen zur Risikominimierung.		
14-O	**Sexuelle Selbstbestimmung in der Einrichtung ermöglichen**	8	22
	Die Auszubildenden erkennen die sexuelle Selbstbestimmung als Menschenrecht an und akzeptieren unterschiedliche Vorstellungen von Sexualität, Gender und Partner:innenschaft.		
14-P	**Menschen mit Pyrexie (Fieber) unterstützen**	8	23
	Die Auszubildenden erfassen kommunikative Herausforderungen in der Versorgung von Menschen aller Altersstufen und finden Ansatzpunkte zur Bewältigung.		
14-Q	**Menschen mit Risiko für Stoffwechselentgleisung unterstützen**	16	24-25
	Die Auszubildenden schätzen Vitalfunktionen von Menschen mit Stoffwechselentgleisung ein und verfügen über Strategien zum Umgang mit akuten Pflegesituationen.		
14-R	**Menschen mit beeinträchtigter Kommunikation professionell begegnen**	16	30-31
	Die Auszubildenden nutzen pflegediagnostische Maßnahmen zur Erstellung bedarfsgerechter Maßnahmenpläne für Menschen mit beeinträchtigter Kommunikation.		
14-S	**Menschen mit beeinträchtigter Mobilität lebensweltorientiert unterstützen**	8	33
	Die Auszubildenden beurteilen gesundheitliche Risken und wenden fachliche Standards in der Pflegeprozessplanung und -steuerung für Menschen mit beeinträchtigter Mobilität an.		

14-T	**Menschen mit Dysphagie bedarfsgerecht unterstützen II**	12	34-35
	Die Auszubildenden evaluieren die Wirksamkeit von prophylaktischen Pflegemaßnahmen bei Menschen mit Dysphagie und identifizieren Verbesserungspotenziale im individuellen Pflegeprozess.		
14-U	**Menschen mit riskantem Gesundheitsverhalten professionell begegnen**	12	36-38
	Die Auszubildenden agieren professionell in Konfliktsituationen und nutzen medizinisch und pflegerisches Fachwissen, um den zu pflegenden Menschen zu schulen und sich selbst abzusichern.		
14-V	**Menschen mit affektiver Störung lebensweltorientiert unterstützen**	8	39
	Die Auszubildenden erkennen die Bedeutung von sozialen Netzwerken und familiären Systemen für die individuelle Gesundheit von Menschen aller Altersstufen an und berücksichtigen dies in der Pflegeprozessplanung.		
14-W	**Menschen nach operativen Eingriffen betreuen**	8	41
	Die Auszubildenden wählen bedarfs- und situationsgerechte, evidenzbasierte Maßnahmen in akuten Pflegesituationen aus und agieren kompetent im multiprofessionellen Team.		
14-X	**Menschen mit infektiösen Erkrankungen in gemeinschaftlichen Wohnformen betreuen**	4	42
	Die Auszubildenden wenden Hygienestandards unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse der zu pflegenden Menschen in Einrichtungen der stationären Langzeitpflege an.		

Kompetenzen 1./2. AD (Anlage 1 PflAPrV)															
KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**
a-g	**a-b, f-g**			**a**	**a, d-e**	**a-c, e**	**a-c**	**a, c**	**a, d**	**a**		**b**	**a**	**a, c**	**b-c**
Bezug RLP: CE 02															

LF 15	**Menschen aller Altersstufen mit psychischen Erkrankungen bei der Beziehungsgestaltung und sozialen Teilhabe unterstützen**	**160 UE**
	Intention und Relevanz Lernfeld 15 widmet sich in 18 Modulen der Beziehungsgestaltung im Handlungsfeld der Pflege psychisch erkrankter Menschen. Dabei werden Kompetenzen der Pflegeprozessteuerung sowie der Kommunikation und Beratung in den Fokus gerückt. Verschiedene Versorgungskontexte innerhalb der Lernsituationen bieten Raum zur Betrachtung psychischer Gesundheit als relevante Dimension im hinsichtlich der Herstellung von Lebensqualität, physischer Gesundheit und sozialer Teilhabe. Die Entstigmatisierung psychisch erkrankter Menschen wird durch die Vermittlung fachlich fundierten Pflegehandelns gefördert.	
	Bildungsziel 1./2. AD Die Auszubildenden reflektieren im ersten Ausbildungsabschnitt das eigene innere Erleben in der Interaktion mit Menschen mit psychischen Erkrankungen und/oder kognitiven Beeinträchtigungen einschließlich widerstreitender Gefühle. Sie reflektieren mögliche Ängste oder Abwehrmechanismen. Sie werden sich zunehmend ihrer beruflichen Rollen in Abgrenzung zur eigenen Person klar und können diese in der Interaktion mit zu Pflegenden einschätzen. Sie erkennen, dass klinische Diagnosen das Ergebnis von sozialen Konstruktionsprozessen sind.	
	Didaktischer Kommentar Die Thematisierung psychischer Erkrankungen kann zu einer Auseinandersetzung mit stereotypen Vorstellungen und/oder Vorurteilen führen. Dieser kritische und reflexive Diskurs sollte von der Lehrkraft unbedingt gefördert werden, um den Lernenden die Entwicklung einer professionellen Haltung zu ermöglichen. Zusätzlich sollte Raum gegeben werden, mögliche Ängste zu thematisieren und in Hinblick auf den psychiatrischen Praxiseinsatz abzubauen. Die Wahrung professioneller Nähe und Distanz sowie die Selbstexploration bezüglich der eigenen psychischen Gesundheit als beruflich Pflegende:r bilden zusätzlich wichtige Felder für didaktische Konzeptionen. ACHTUNG: Für Psychiatrieerfahrene kann die Thematisierung psychiatrischer Therapie ggf. triggernd wirken. Hier sollten Rückzugsmöglichkeiten klar deklariert werden.	

Modul	Modultitel	UE	UW
15-A	**Neuroanatomische und physiologische Zusammenhänge verstehen**	4	14
	Kennen den Aufbau des ZNS und verstehen grundlegende Zusammenhänge zwischen Neurophysiologie und sensomotorischen Phänomenen.		
15-B	**Menschen bei psychischen Erkrankungen bei der Beziehungsgestaltung und sozialen Teilhabe unterstützen**	8	16-17
	Die Auszubildenden erfassen Depressionen als medizinische Diagnose und ermitteln beeinflussende Faktoren zur Manifestation einer Depression. Reflektieren Ihre Einstellung gegenüber Menschen mit Depressionen und erfassen die Säulen der Therapieansätze um ihr pflegerisches Handeln zu begründen.		
15-C	**Beziehung bei Menschen mit Demenz gestalten**	8	18-19
	Die Auszubildenden erfassen Beziehungsgestaltung als zentrale Bestandteile in der Pflege von Menschen mit psychischen Erkrankungen.		
15-D	**Mensch mit Demenz in der Beziehungsgestaltung und sozialen Teilhabe unterstützen**	16	26-27
	Die Auszubildenden erfassen den Expertenstandard. Sie erläutern den Diagnoseprozesses anhand des Corbin-Straus-Modell. Erläutern den Nutzen einer Erarbeitung von Krankheitsverlaufskurven.		
15-E	**Mensch mit herausfordernden Verhalten professionell begegnen**	8	28-29
	Die Auszubildenden erkennen Anzeichen von Aggressionen. Sie erfassen rechtliche Grundlagen bei freiheitsbeschränkenden Maßnahmen und die Grundlagen deeskalierender Maßnahmen.		
15-F	**Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen bei der Entwicklung von Verhaltensweisen unterstützen, die das Leben in der Gemeinschaft fördern**	16	35-36
	Die Auszubildenden erfassen psychotherapeutische Maßnahmen. Erkennen asymmetrische Kommunikation in pflegerischer Kommunikation und erkennen Grenzen ihres Handlungsspielraumes.		

15-G	**Menschen mit affektiven Störungen in der Beziehungsgestaltung und sozialen Teilhabe unterstützen**	8	40
	Die Auszubildenden berücksichtigen pflegerische Ziele, Prinzipien und Bedingungen bei Menschen mit Depressionen und Suizidgedanken.		
15-H	**Mensch mit Risiko der Selbstvernachlässigung unterstützen und bei der Diagnostik und Therapie mitwirken**	12	41-42
	Die Auszubildenden informieren und beraten über Medikamente, stellen Akzeptanz seitens der zu pflegenden Menschen her, bauen Ängste und Sorgen ab. Wirken bei Laborkontrollen mit, führen diagnostische Maßnahmen (Speichel-,Blut- Urinproben entnehmen) durch.		

Kompetenzen 1./2. AD (Anlage 1 PflAPrV)

KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV. 1**	**KS IV. 2**	**KS V.1**	**KS V.2**
a-h	**a, b, e, f**	**a-b**			**a**	**a-g**	**a**			**c-d**	**c**		**c**		**b-c**

Bezug RLP: CE 11

LF 15	**Bildungsziel 3. AD** Im 2. Ausbildungsabschnitt reflektieren die Auszubildenden die Asymmetrie der Beziehung zwischen psychisch kranken Menschen und professionell Pflegenden und die damit verbundenen Machtpotenziale. Sie können sich im Spannungsfeld von Schutz und Grenzen bewegen und finden Ansatzpunkte für Gewaltprävention. Sie stellen professionelle Beziehungen her und nehmen die Verantwortung für den Pflegeprozess von psychisch erkrankten und/oder kognitiv beeinträchtigten Menschen wahr. Vor dem Hintergrund der Ungewissheit in der Deutung des Verhaltens von zu pflegenden Menschen mit psychischen Erkrankungen und/oder kognitiven Beeinträchtigungen können Auszubildende die Einsicht gewinnen, dass sie ihre vorläufigen Deutungen im situativen Handeln immer wieder überprüfen müssen.

Modul	Modultitel	UE	UW
15-I	**Menschen mit beeinträchtigten Körperschema/-bild unterstützen**	4	43
	Die Auszubildenden identifizieren die ethischen Problemstellungen in der Fallsituation und reflektieren sie nach dem Muster einer strukturierten ethischen Falldiskussion und leiten aus dieser Gesamtbeurteilung Konsequenzen für den Pflegeprozess und ggf. die Überleitung in einen anderen Versorgungskontext ab		
15-J	**Pflegeprozessverantwortung in psychiatrischen Einrichtungen umsetzen I**	10	45-46
	Die Auszubildenden kennen pflegerische Aufgaben und Arbeitsablaufstrukturen in der psychiatrischen Versorgung. Erkennen Pflegesystem der Bezugspflege/Primary Nursing. Sie integrieren Prinzipien der Partizipation, des Empowerment- und des Recovery-Konzepts in die pflegerische Interaktion.		
15-K	**Pflegeprozessverantwortung in psychiatrischen Einrichtungen umsetzen II**	12	47-49
	Die Auszubildenden bestimmen pflegerische Prozesse in psychiatrischen Versorgungseinrichtungen. Sie prüfen zentrale verhaltenstherapeutische Pflegeinterventionen. Dokumentieren und interpretieren in Hinblick auf (kurzfristige) pharmakotherapeutiche Maßnahmen.		
15-L	**Pflegeprozess mittels Casemanagement steuern**	10	50-51
	Die Auszubildenden gestalten die Überleitung zwischen den verschiedenen Sektoren und übernehmen Aufgaben im Case- und Caremanagement. Sie kennen Varianten der Teilhabeplanung im deutschen Versorgungssystem.		
15-M	**Pflegeprozessverantwortung in ambulant psychiatrischen Pflegediensten umsetzen**	12	52-53
	Die Auszubildenden gestalten Erstkontakt zur Beziehungsaufnahme. Nutzen Assessments. Identifizieren Machtmissbrauch von Bezugspersonen. Erläutern die Verordnung amb. psychiatrischer Pflege. Begründen die eigene pflegerische Sichtweise in interdisziplinären Fallbesprechungen.		
15-N	**Psychische Krisen identifizieren**	12	55-56
	Die Auszubildenden schätzen Anzeichen für psychische Krisen ein und leiten adäquate Maßnahmen ein. Stellen den Umgang mit herausfordernden Situationen in psychischen Krisensituationen dar.		

15-O	**Sozialpsychiatrischen Dienst in Anspruch nehmen**	4	58
	Die Auszubildenden kennen die Möglichkeiten des sozialpsychiatrischen Dienstes ihrer Stadt. Erklären die Voraussetzungen für amb. psych. Pflege. Sind über gefährdete Arbeitsbereiche aufgeklärt.		
15-P	**Mensch mit posttraumatischen Syndrom pflegerisch unterstützen und sekundärer Traumatisierung des Pflegepersonals präventiv begegnen**	8	61
	Die Auszubildenden erklären die Traumamerkmale u. einer posttraumatischen Belastungsstörung. Erklären eine sekundäre Traumatisierung, reflektieren Übertragungsmomente u. stellen Präventionsmaßnahmen dar. Ordnen Maßnahmen zur Bewältigung der sekundären Traumatisierung ein.		
15-Q	**Menschen mit inadäquaten Verhalten bei Therapie- und Behandlungskonzepten unterstützen**	8	62
	Die Auszubildenden erkennen inadäquates Verhalten bei Menschen aller Altersklassen und können individuelle Maßnahmen einleiten, um zu Pflegende bei der Implementierung gesundheitsförderlicher Verhaltensweisen in den Alltag zu unterstützen.		

Kompetenzen 3. AD (Anlage 2 PflAPrV)

KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**
a-i	**a-b**	**a**			**a, d**	**a-g**	**a-b**	**c**		**f**	**b-d**	**c**	**b**	**d**	**c-d**

Bezug RLP: CE 11

LF 16	**Menschen aller Altersstufen in Krisen und akuten Belastungssituationen begleiten**	**130 UE**
	Intention und Relevanz 15 Module bieten Raum zur Entwicklung pflegefachlicher Kompetenzen in krisenhaften bzw. akut belastenden Situationen. Dabei werden verschiedene Arten von Ausnahmesituationen beleuchtet, mit denen beruflich Pflegende in verschiedenen Rollen konfrontiert werden können. Das Lernfeld bietet Möglichkeiten, krisenhafte Situationen im geschützten Raum zu thematisieren und Handlungsmöglichkeiten zu erproben.	
	Bildungsziel 1./2. AD Die Auszubildenden reflektieren Widersprüche, die sich aus dem Erleben von Angst, Leid und Schmerz und möglichen (Selbst- und Fremd-)Erwartungen an das Verhalten ergeben. Sie erkunden berufliche Handlungsfelder im Bereich der Notfall- und Erstversorgung. Sie reflektieren das Spannungsverhältnis zwischen systemischen Zwängen versus Personenzentrierung im Kontext von Notfallinterventionen. Sie setzen sich außerdem mit dem Spannungsverhältnis von Anspruch und Wirklichkeit in der pädiatrischen Versorgung auseinander und finden Ansatzpunkte zur Bewältigung akuter Belastungssituationen.	
	Didaktischer Kommentar Neben der Thematisierung von Notfall- und Kriseninterventionen sowie rechtlichen Anforderungen steht die Entwicklung von Handlungssicherheit im Fokus. Rollenspiele, Trainings und Skills-Lab-Einheiten zu verschiedenen Modulen eignen sich dafür. Das Training im geschützten Raum bildet die Basis für performative Kompetenz. Zu Beginn der Ausbildung sollen Szenarien nahe an der Realität der Lernenden gestaltet werden, etwa durch Bearbeitung konkreter Erlebnisse aus der Praxis. Im dritten Ausbildungsjahr (3. AD) werden die Lernenden mit potenziell herausfordernden Situationen konfrontiert, um ihre bisher entwickelte Kompetenz auf komplexe Situationen anzuwenden. **Achtung:** Die Auseinandersetzung mit Themen wie Notfällen, Gewalt oder Verlust bei bestehendem Trauma oder aktueller Belastung triggernd wirken. Die Lehrkraft muss unbedingt sensibel für die Erfahrungen und das Sicherheitserleben der Lernenden sein. Triggerwarnungen müssen vor Beginn entsprechender Unterrichtseinheiten klar und ggf. wiederholend gegeben werden. Lernende müssen das Unterrichtsgeschehen bei Bedarf verlassen dürfen und sollten einen sicheren Raum zum Zurückziehen bzw. Ansprechpersonen haben. Zudem sollten im Bedarfsfall (auf Wunsch der betreffenden Person) entsprechende Beratungs- und Unterstützungsangebote gegeben werden. Dazu ist die Vernetzung der Pflegeschule mit entsprechenden Fachstellen sinnvoll.	

Modul	Modultitel	UE	UW
16-A	**Als Ersthelfer:in agieren können**	14	2-3
	Die Auszubildenden kennen Leitlinien im Rahmen der ersten Hilfe sowie relevante Gesetze. Fühlen sich in der Lage, als Ersthelfer:in zu agieren.		
16-B	**Risiken identifizieren und Komplikationen vorbeugen**	14	6-7
	Die Auszubildenden unterstützen den zu pflegenden Menschen beim Vorbeugen von Gesundheitsrisiken unter Berücksichtigung des Selbstbestimmungsrechtes der pflegebedürftigen Person.		
16-C	**Prävention bei Menschen mit Risiko für einen anaphylaktischen Schock in pflegerisches Handeln integrieren**	4	8
	Die Auszubildenden können einfache ärztliche Verordnungen durchführen.		
16-D	**Menschen mit akut veränderter Wahrnehmung unterstützen**	14	13-15
	Die Auszubildenden erlernen Pflegeziele zu generieren und diese zu evaluieren, um das eigene pflegerische Handeln zu begründen.		
16-E	**Menschen mit akut neurologischen Defizit nach Unfällen pflegen**	8	28
	Die Auszubildenden können einfache ärztliche Verordnungen durchführen und fachgerecht dokumentieren. Sind in der Lage, dabei Maßnahmen der Qualitätssicherung zu berücksichtigen		
16-F	**Menschen in Ausnahmesituationen und nach Verlusten begleiten**	8	29
	Die Auszubildenden gehen professionell mit Menschen mit Verlusterfahrungen und Trauer um. Sie erkennen eigene Überforderung und finden entsprechende Unterstützung.		
16-G	**Menschen mit instabilen Herz-Kreislauffunktionen versorgen und Sekundärschäden präventiv begegnen**	8	32
	Die Auszubildenden begründen ihr pflegerisches Handeln auf Basis evidenzbasierter Leitlinien. Kennen die rechtlichen Rahmenbedingungen im Kontext medizinischer Notfallinterventionen.		
16-H	**Bei Anzeichen für Kindesmissbrauch adäquate Maßnahmen einleiten**	8	33-34
	Die Auszubildenden erkennen drohende Überforderungen und sind sich der Notwendigkeit von kollegialer Abstimmung und Koordination bewusst.		

16-I	**Menschen mit thermischen Verletzungen betreuen und Sekundärschäden präventiv begegnen**	12	37-39
	Die Auszubildenden berücksichtigen auch in kritischen Lebenssituationen präventive Ansätze sowie kulturelle Bedarfe zu pflegender Menschen und nehmen diese in die Pflegeprozessgestaltung auf.		

Kompetenzen 1./2. AD (Anlage 1 PflAPrV)

KB I						KB II			KB III			KB IV		KB V	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**
d-f, i	**a, b, d, f, g**	**b-d**		**a**	**a, d**	**a, b, d**		**a, c**	**a-b**	**b, d**		**b**		**a, c**	**b-c**

Bezug RLP: CE 08, CE 10

LF 16	**Bildungsziel 3. AD** Die Auszubildenden reflektieren den gesellschaftlich-kollektiven, institutionellen und individuellen Umgang mit Krisen, Tod und Sterben in unterschiedlichen Altersstufen und Lebensphasen. Häufig zeichnen sich die Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen durch eine hohe Expertise bezüglich des Gesundheitszustandes und der sozialen, emotionalen und kognitiven Kompetenzen ihrer Kinder aus. Dennoch bedarf es der Gestaltung von Informations- und Beratungsgesprächen. Es gilt, die damit verbundenen Rollenkonflikte zu erkennen und dazu eine ethisch reflektierte Position zu entwickeln.		
Modul	**Modultitel**	**UE**	**UW**
16-J	**Eltern in Phasen akuter Sorge und Belastung unterstützen**	4	48
	Die Auszubildenden finden Ansatzpunkte zur Unterstützung hochbelasteter Eltern und tragen so zur Stabilisierung des familiären Systems bei.		
16-K	**In der Akutversorgung polytraumatisierter Menschen sicher agieren**	12	52-54
	Die Auszubildenden können in Notfallsituationen sicher agieren, setzen evidenzbasierte Leitlinien um. Können unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben die Pflegedokumentation, auch in digitaler Form, durchführen.		

16-L	**Eltern und Geschwister sterbender Kinder begleiten**	8	57-58
	Die Auszubildenden agieren auch in belastenden Pflegesituationen sicher im interprofessionellen Team und erkennen die Expertise von Eltern im Kontext palliativer Pflege an.		
16-M	**Strategien zur Bewältigung berufsbezogener Belastungen verinnerlichen (Prüfungsvorbereitung)**	4	61
	Die Auszubildenden evaluieren die eigenen Bewältigungsstrategien für berufsbezogene Belastungen und passen diese ggf. an.		
16-N	**Im Team konstruktiv mit Belastungen umgehen (Prüfungsvorbereitung)**	8	62
	Die Auszubildenden können Belastungen im interprofessionellen Team kommunizieren und finden Möglichkeiten der Konfliktlösung.		
16-O	**Das eigene Berufsverständnis aufgrund persönlicher und beruflicher ethischer Überzeugungen reflektieren (Prüfungsvorbereitung)**	4	63
	Die Auszubildenden sind in der Lage, das eigene Handeln kritisch zu reflektieren und entwickeln so ein professionelles und qualitätsorientiertes berufliches Selbstverständnis.		

Kompetenzen 3. AD (Anlage 2 PflAPrV)

KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**
b-f, i	**a, e**	**b-f**				**f**				**b, f**	**b**	**b, d**			**a-d**

Bezug RLP: CE 08, CE 10

LF 17	**Menschen aller Altersstufen mit lebenslimitierenden Erkrankungen palliativ unterstützen**	**90 UE**	
	Intention und Relevanz Lernfeld 17 widmet sich der Pflege von Menschen im palliativer Versorgungssituation. Dabei werden verschiedene Settings und Altersstufen sowie Lebensphasen thematisiert. Zentral wird hier das Handlungsfeld im Bereich Palliative Care beleuchtet und in Abgrenzung zu Kuration, Prävention und Rehabilitation gebracht; Schnittstellen werden beleuchtet und Handlungsmöglichkeiten beruflich Pflegender aufgezeigt. Eine persönliche Auseinandersetzung mit den Themen Leid, Verlust, Tod und Sterben soll ermöglicht werden, um eine reflektierte Haltung entwickeln zu können.		
	Bildungsziel 1./2. AD Die Auszubildenden reflektieren den Widerstreit zwischen Mitleiden und bewusster innerer und äußerer Abgrenzung und finden zu einer begründeten Haltung. Für palliative Handlungsfelder reflektieren die Auszubildenden das Spannungsverhältnis zwischen systemischen Zwängen versus Personenzentrierung, auch in der Pflege von sterbenden Kindern und Jugendlichen.		
	Didaktischer Kommentar Die Auseinandersetzung mit den Themen Tod, Sterben, Trauer und Verlust kann für die Lernenden unterschiedlich belastend sein. Hier sollte die Lehrkraft stets sensibel für Momente der Überforderung und/oder Ablehnung sein. Lernende sollen zur Selbstfürsorge befähigt werden und selbst ergründen können, welche Formen von Bewältigung sie als hilfreich erleben. Exemplarisch sind kreative Angebote für den Ausdruck eigener Emotionen und/oder Erfahrungen zu nennen. Der Einbezug entsprechender Fachstellen (z.B. Hospiz(dienste), SAPV-Team, Trauergruppen, Bestattungsinstitute, etc.) kann wertvolle Perspektiven für Unterstützung und interprofessionelle Zusammenarbeit bieten.		
Modul	**Modultitel**	**UE**	**UW**
17-A	**Palliative Pflege in Abgrenzung zu Rehabilitation, Kuration u. Prävention verstehen**	4	9
	Die Auszubildenden können den Begriff der Palliativpflege abgrenzen von denen der Rehabilitation, Kuration und Prävention.		

17-B	**Herausforderungen im Umgang mit sterbenden Menschen spüren und formulieren**	8	11-14
	Die Auszubildenden erkennen Herausforderungen im Umgang mit sterbenden Menschen. Können damit verbundenen Gefühle identifizieren und äußern.		
17-C	**Menschen mit Aphasie in der Selbstbestimmung fördern**	6	15
	Die Auszubildenden verstehen die Relevanz von Autonomie und Selbstbestimmung, um eine respektvolle und bedürfnisorientierte Pflege für kognitiv beeinträchtigte Menschen zu gewährleisten.		
17-D	**Früherkennung eigener Überforderungen bei der Pflege von Menschen mit Enterostoma**	8	19-20
	Die Auszubildenden können Situationen von Über -oder Unterforderung im Pflegealltag frühzeitig einschätzen und finden Ansätze, dem entgegenwirken.		
17-E	**Menschen mit onkologischen Erkrankungen sekundär- und tertiärpräventiv unterstützen**	4	21
	Die Auszubildenden verstehen die Unterschiede präventiver Ansätze. Kennen gesundheitsfördernde Maßnahmen und können Sie auch bei Menschen mit progredienten Erkrankungen anwenden.		
Wahlmodule		20	23-27
17-F-W1	**Ambulante palliative Pflege symptombezogen gestalten**		
	Die Auszubildenden verstehen die Bedeutung vom Bezugssystem Familie, besonders im ambulanten Bereich, und nutzen diese Ressource zur individuellen Planung, Durchführung und Evaluation des Pflegeprozesses, für Menschen aller Altersstufen.		
17-F-W2	**Palliative Pflege im Krankenhaus symptombezogen gestalten**		
	Die Auszubildenden verstehen die Bedeutung vom Bezugssystem Familie, besonders im Bereich der Akutversorgung, und nutzen diese Ressource zur individuellen Planung, Durchführung und Evaluation des Pflegeprozesses, für Menschen aller Altersstufen.		

17-F-W3	**Palliative Pflege in der stationären Langzeitpflege symptombezogen gestalten**
	Die Auszubildenden verstehen die Bedeutung vom Bezugssystem Familie, besonders in der stationären Langzeitpflege, und nutzen diese Ressource zur individuellen Planung, Durchführung und Evaluation des Pflegeprozesses, für Menschen aller Altersstufen.

Kompetenzen 1./2. AD (Anlage 1 PflAPrV)

KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**		**KB V**	
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**
a-i	**a-d, f, g**	**a-d**		**a**	**a, d**	**a, b, d**		**a, c**	**a-b**	**b, d**	**e**	**b**	**b, e**	**a-c**	**b-c**

Bezug RLP: CE 08, CE 10

LF 17	**Bildungsziel 3. AD** Die Auszubildenden reflektieren den gesellschaftlich-kollektiven, institutionellen und individuellen Umgang mit Tod und Sterben in unterschiedlichen Altersstufen und Lebensphasen im Spannungsfeld von Entfremdung und Leiderfahrung. Sie nehmen die Gesellschaft und die Institutionen als Rahmung für die persönliche Auseinandersetzung mit dem Sterben sowie für die Gestaltung des Pflegeprozesses wahr. Eltern werden als Expert:innen für die sozialen, emotionalen und kognitiven Bedarfe ihrer Kinder anerkannt und entsprechend einbezogen.		
Modul	**Modultitel**	**UE**	**UW**
17-G	**Arbeitswelt Hospiz kennenlernen**	8	43-44
	Die Auszubildenden nutzen Wissen über kulturelle Hintergründe des zu pflegenden Menschen und fordern bei Unsicherheiten kollegiale Beratung ein.		
17-H	**Menschen mit onkologischen Erkrankungen in der letzten Lebensphase begleiten**	9	43-48
	Die Auszubildenden können die Pflege eines sterbenden Menschen unter Berücksichtigung kulturellen Bedarfe planen, durchführen und evaluieren.		
17-I	**Kinder und Jugendliche mit malignen Erkrankungen palliativ pflegen**	15	51-56
	Die Auszubildenden unterstützen den zu pflegenden Menschen und seine Bezugspersonen altersentsprechend. Nutzen neuste Erkenntnisse und digitale Assistenzsysteme zur Bewältigung möglicher Problemlagen. Beteiligen sich an der Entscheidungsfindung im interprofessionellen Team.		
17-J	**Palliative Pflege im ambulanten Setting steuern**	8	60-61
	Die Auszubildenden können eigenständig Wissenslücken schließen und auch im ambulanten Setting eine palliative Versorgung, für Menschen aller Altersstufen, planen, durchführen und evaluieren.		

Kompetenzen 3. AD (Anlage 2 PflAPrV)															
KB I						**KB II**			**KB III**			**KB IV**	**KB V**		
KS I.1	**KS I.2**	**KS I.3**	**KS I.4**	**KS I.5**	**KS I.6**	**KS II.1**	**KS II.2**	**KS II.3**	**KS III.1**	**KS III.2**	**KS III.3**	**KS IV.1**	**KS IV.2**	**KS V.1**	**KS V.2**
b-g, i	**e-f**	**a-f**			**a**	**a**		**a, c**		**b**		**b**	**b, e**	**d**	**b-c**
Bezug RLP: CE 08, CE 10															

Gesamt UE	SOLL 1900 UE	**IST 1900**
Verfügungsstunden	SOLL 200 UE	**IST 305**
Gesamt	SOLL 2100 UE	**IST 2205**
CE-Curriculare Einheit KB-Kompetenzbereich; KS-Kompetenzschwerpunkt LF-Lernfeld RLP-Rahmenlehrplan der Fachkommission nach § 53 PflBG UE-Unterrichtseinheit UW-Unterrichtswoche		

7.2 Modulbeschreibungen: Inhalte/Situationsmerkmale/Inhaltliche Ausrichtung

Um die Ausbildungsziele anzubahnen resp. die Kompetenzen zu entwickeln, dienen im Curriculum 17 Lernfelder. Die Lernfelder gliedern sich in insgesamt 212 Module. Zur Umsetzung der Module sind sogenannte Modulbeschreibungen hinterlegt. An dieser Stelle werden die Konstruktionskriterien, Situationsmerkmale und die Ausrichtung der Modulbeschreibungen erläutert.

<table>
<tr><td>Lernfeld:</td><td rowspan="2">Im Abschnitt Intention und Relevanz wird das Thema der curricularen Einheit aus professioneller Sicht begründet. Mit der Darlegung der zugrundeliegenden zentralen Gedanken gibt dieser Abschnitt eine Interpretationshilfe zum besseren Verständnis der Ausrichtung dieser curricularen Einheit.</td><td>Modul</td><td>Fortlaufende Nummer</td></tr>
<tr><td></td><td>UE:</td><td>Zeitrichtwert</td></tr>
<tr><td>Berufstypische Situation:</td><td colspan="3">Im Abschnitt Intention und Relevanz wird das Thema der curricularen Einheit aus professioneller Sicht begründet. Mit der Darlegung der zugrundeliegenden zentralen Gedanken gibt dieser Abschnitt eine Interpretationshilfe zum besseren Verständnis der Ausrichtung dieser curricularen Einheit.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CE im Rahmenlehrplan:</td><td rowspan="2">Hier wird der Verweis zur curricularen Einheit des Rahmenlehrplan abgebildet.</td><td>AD</td><td>Ausbildungsdrittel</td></tr>
<tr><td>UW</td><td>Unterrichtswoche</td></tr>
<tr><td>Voraussetzungen:</td><td colspan="3">Ggf. Voraussetzung zur Bearbeitung aus diversen Modulen</td></tr>
<tr><td>Verknüpfungen:</td><td colspan="3">Verknüpfungen zu anderen Modulen/Perspektivverschränkungen</td></tr>
<tr><td>Situationstyp nach Kirkevold:</td><td colspan="2"><ul><li>akute Situation</li><li>problematische Situation</li><li>nicht problematische Situation</li><li>problemidentifizierende Situation</li></ul></td><td>Setting
Hier wird das Setting abgebildet, in welchem sich die berufstypische Situation widerspiegelt.</td></tr>
<tr><td>Titel der LS:</td><td colspan="3">An dieser Stelle ist der Titel oder das Motto der berufstypischen Situation abgebildet.</td></tr>
<tr><td>Lernziele:</td><td colspan="3">Im Abschnitt Lernziel wird das Potenzial des Moduls hervorgehoben, mit dem Auszubildende zum Denken in Widersprüchen und zur kritischen</td></tr>
</table>

	Reflexion aufgefordert sind. Die Lernziele sind entsprechend der Lernzieltaxonomie nach Anderson und Krathwohl formuliert worden.
Operationalisierte Kompetenzen nach Anlage 1 bzw. 2 PflAPrV	Hier sind die (operationalisierten) anzubahnenden Kompetenzen für das jeweilige Modul und Ausbildungsdrittel hinterlegt.
Kompetenzentwicklungsstufe	In kritischer Auseinandersetzung mit Benners Stufenmodell entwickelte Christa Olbrich (1999) auf Basis empirischer Untersuchungen ein erweitertes Pflegekompetenzmodell. Sie unterscheidet vier Dimensionen pflegerischen Handelns, denen spezifische Kompetenzen zugeordnet sind. Die einzelnen Modulen sind jeweils eine der folgenden vier Dimensionen zugeordnet um die jeweiligen Kompetenzen anzubahnen. **Regelgeleitetes Handeln** basiert auf Fachwissen und der Anwendung standardisierter Methoden. Es erfolgt routinemäßig nach geltenden Normen und entlastet die Pflegenden, wodurch effizientes Arbeiten ermöglicht wird. **Situativ-beurteilendes** Handeln erfordert die Fähigkeit, individuelle Lebenssituationen wahrzunehmen, zu bewerten und angemessen zu reagieren – etwa in der Pflegeplanung oder Prozessgestaltung. **Reflektierendes Handeln** umfasst sowohl die Analyse von Pflegesituationen als auch die Selbstreflexion. Empathie und Kommunikationsfähigkeit spielen dabei eine zentrale Rolle. **Aktiv-ethisches** Handeln gründet auf persönlicher Ich-Stärke und Werteorientierung. Pflegende handeln engagiert und verantwortungsvoll, insbesondere in ethisch herausfordernden Situationen. Diese vier Dimensionen entwickeln sich laut Olbrich hierarchisch: Auf der Basis regelgeleiteten Handelns kann sich – mit wachsender Erfahrung und Weiterbildung – aktiv-ethisches Handeln als höchste Kompetenzstufe entfalten.
Pflegephänomen/ Handlungsanlass	Die Handlungsanlässe sind so formuliert, dass das Erfordernis pflegerischen Handelns deutlich wird. Die beteiligten Personen (Auszubildende, Praxisanleitungen, zu pflegende Menschen und deren Bezugspersonen) sind immer wieder in den Handlungsanlässen präsent, die sich aus pflegerischen Herausforderungen ergeben.

	Handlungsanlässe beschreiben den Aufforderungsgehalt von Situationen. Sie begründen und rechtfertigen die Zuständigkeit der Pflegefachpersonen und die Notwendigkeit des Handelns. Sie werden als Pflegeanlässe durch pflegespezifische Begriffssysteme wie Pflegediagnosen oder Pflegephänomene beschrieben. Zudem werden relevante Pflegediagnosen aus dem ENP (European Nursing Pathways), berücksichtigt. Der Lernprozess verläuft spiralförmig und steigert sich in seiner Komplexität. In den unterschiedlichen Ausbildungsdritteln nehmen sowohl die Anzahl der beteiligten Personen als auch die Komplexität der Handlungsanlässe zu. Im 1. AD sind 1–3 Personen beteiligt (Auszubildende:r, zu pflegender Mensch, Praxisanleitung). Die Handlungsanlässe beziehen sich auf 1–3 Pflegediagnosen und einfache Pflegephänomene bei stabilen Gesundheitszuständen und einem niedrigen bis mittleren Pflegebedarf. Im 2. AD treten mehr als 3 Personen auf (zusätzlich Bezugspersonen und intradisziplinäre Kolleg:innen). Die Handlungsanlässe umfassen 3–5 Pflegediagnosen und einfache bis komplexe Pflegephänomene in zeitweisen instabilen Gesundheitszuständen bei mittlerem Pflegebedarf. Im 3. AD erweitert sich das Umfeld um intra- und interdisziplinäre Kolleg:innen. Die Handlungsanlässe umfassen mehrere Pflegediagnosen und komplexe Pflegephänomene bei Menschen mit instabilen Gesundheitszuständen und hohem Pflegebedarf.
Medizinische Diagnosen	Medizinische Diagnosen in der berufstypischen Situation werden aufgezeigt.
Pflegediagnosen (ENP)	Insbesondere werden zu den Handlungsanlässen Pflegediagnosen angegeben. Die ENP-Klasse ermöglicht die genaue Recherche über den ENP-Browser

Beteiligte Personen

In diesem Abschnitt der Situationsmerkmale einer berufstypischen Situation/Meinem Modul werden ausgewählte Akteure angegeben, die für die Handlungssituation relevant sind.

Im Curriculum sind Menschen aller Altersgruppen vertreten. Nicht nur die zu pflegenden Personen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene und alte Menschen), sondern auch die Auszubildenden bringen vielfältige Altersgruppen, soziale Hintergründe und unterschiedliche Lernbiografien mit. Die beteiligten Personen hinterlassen Spuren. Sie sind nicht statisch, sondern entwickeln sich weiter, verändern ihre Perspektiven und treten in unterschiedlichen berufstypischen Situationen bzw. Modulen auf.

Im 1. AD sind 1–3 Personen beteiligt (Auszubildende:r, zu pflegender Mensch, Praxisanleitung), die weitgehend übereinstimmenden Vorstellungen haben. Im 2. AD erweitern sich die Module auf mehr als 3 Personen (zusätzlich Bezugspersonen und intradisziplinäre Kolleg:innen), wodurch unterschiedliche oder sogar gegensätzliche Perspektiven entstehen.

Im 3. AD steigt die Komplexität weiter, indem intra- und interdisziplinäre Kolleg:innen hinzukommen. Hier stehen divergierende Vorstellungen im Mittelpunkt, die eine tiefere Auseinandersetzung erfordern.

Der Gesetzgeber differenziert nicht aus, ab welchem kalendarischen Alter die jeweilige Altersstufe beginnt und endet. Für das vorliegende Curriculum einigte man sich auf folgende Systematisierung:

Altersstufe	**Altersspanne**
Frühgeborene	Gestationsalter unter 259 Tagen
Neugeborene	Gestationsalter ab259 Tagen bis zum vollendeten 28. Lebenstag
Säugling	29. Lebenstag bis zum vollendeten 12. Lebensmonat
Kleinkind	2. bis zum vollendeten 3. Lebensjahr
Kind	4. bis zum vollendeten 12. Lebensjahr
Jugendliche	13. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
Erwachsene	Ab Beginn 19. Lebensjahr
Alter Mensch	Junger Alte: Ab Beginn des 65. Lebensjahres Hochaltrige: Ab Beginn des 85. Lebensjahres

Zu pflegende Menschen sind nicht ausschließlich anhand der systematisierten Altersstufen zu betrachten, sondern vor allem im Hinblick auf ihren individuellen

Entwicklungsstand und Pflegebedarf. Die folgende Darstellung gibt einen Einblick von drei zu pflegenden Menschen/beteiligten Personen und deren Erscheinen in diversen Modulen.

Emre Tastan, 8 Jahre alt					
Modul	**13-B**	**9-A**	**16-C**	**14-G**	**...**
Berufstypische Situation	Selbstfürsorge und Gesundheitskompetenz betrachten	Ein Bewusstsein für kulturelle Vielfalt entwickeln	Prävention bei Menschen mit Risiko für einen anaphylaktischen Schock in pflegerisches Handeln integrieren	Atemunterstützende Maßnahmen bedarfsgerecht planen und durchführen	
Titel	„Atempausen im Schulalltag: Emre und die Herausforderung des Asthmas“	“Pflege, Glaube und Familie: Herausforderung der in Zeiten der Krankheit”	„Emre betreibt Vorsorge“	"Blöder Schleim! – Ich will doch einfach nur Luft bekommen“	
Handlungsanlass	Emre (8) hat Asthma und vergisst häufig Dosieraerosol, fühlt sich als Außenseiter wegen Erkrankung, kennt keine Atemtechniken, hustet	Emre geht bald zur Kommunion. Seine Mutter möchte gerne in den Gottesdienst gehen trotz COVID	Emre zeigt eine allergische Reaktion, es besteht das Risiko eines anaphylaktischen Schocks, hat das Risiko einer allergischen Reaktion	Emre hat Bronchitis, Pneumonierisiko durch bestehendes Asthma	

Alessandro Tano, 42 Jahre alt				
Modul	**16-B**	**14-H**	**7-B**	**...**
Berufstypische Situation	Risiken identifizieren und Komplikationen vorbeugen	Menschen mit beeinträchtigter Kreislauffunktion unterstützen	Pflegediagnosen im Pflegeprozess mit dem Fokus von Gesundheitsförderung und Prävention formulieren	
Titel	„Das Ganze ist ja mehr als nur ein kaputtes Bein“	„Ist doch alles halb so wild!“	„Wenn der Druck höher ist, als die Zuversicht“	

Handlungsanlass	darf aufgrund einer operativ versorgten Tibiafraktur das betroffene Bein nicht belasten, es besteht das Risiko von Komplikationen, Ruhigstellung eines Gelenks, Mit Hilfe von Assessmentinstrumenten festgestellte Risiken, ist in der Fähigkeit, selbstständig einen Positionswechsel im Bett durchzuführen, beeinträchtigt, hat einen Wissensbedarf über gesundheitsförderliches Verhalten, Schmerz		Herr Tano liegt wegen erstmalig aufgetretener hypertensiven Krise stationär, Azubi misst zu hohen Blutdruck	Herr Tano weiß nicht, wie er sich mit der neu diagnostizierten Hypertonie verhalten soll	
Heidi Berg, 82 Jahre alt					
Modul	**14-A**	**14-B**	**14-C**	**07-A**	**...**
Berufstypische Situation	Menschen in der Bewegung unterstützen	Menschen bei der Körperpflege unterstützen	Kontinenzförderung als pflegerisches Handlungsfeld wahrnehmen	Gesundheitsförderung und Prävention als Anspruch und Ziel des Pflegeberufs erfassen	
Titel	Heidi Berg sagt nichts, aber ihr Körper spricht Bände	"Ich habe heute schon zu Hause geduscht"	"Klett statt Knopf!?	“Das Essen kann ich nicht bezahlen!”	
Handlungsanlass	Heidi Berg hat Sturzrisiko, Angst, zieht sich zurück, Bewegungsarmut	ist bei der selbstständigen Körperwaschung beeinträchtigt; kann aufgrund von Desorientierung die Körperwaschung nicht selbstständig gestalten	hat aufgrund einer Dranginkontinenz ein Selbstversorgungsdefizit, hNeigung zu Intertrigo, hat ein Informationsdefizit/fehlende Fähigkeiten im Umgang mit der Inkontinenz	Demenzbedingte Ängste, sich das Essen nicht leisten zu können, Risiko Mangelernährung,	

Erleben, Deuten, Verarbeiten:	Das Erleben/Deuten/Verarbeiten wird aus den verschiedenen Perspektiven der relevanten Akteure beschrieben. Ihr individuelles Erleben ist geprägt durch persönliche Erfahrungen, Sichtweisen und Präferenzen, die zu einer subjektiven Deutung der Situation führen. Dabei spielen auch persönliche Deutungsmuster, entwickelte Bewältigungsstrategien sowie erlebte Ressourcen eine zentrale Rolle. Durch die Einbindung dieser Aspekte wird der Lernprozess vertieft und die professionelle Handlungskompetenz gefördert, indem Auszubildende lernen, unterschiedliche Perspektiven wahrzunehmen und darauf angemessen zu reagieren.
Gesellschaftlicher Kontext	Die Kontextbedingungen sind institutionelle Bedingungen auf der Mesoebene und gesellschaftliche Bedingungen auf der Makroebene, unter denen Handlungssituationen auftreten. In den Modulen werden diese Kontextbedingungen in der jeweiligen berufstypischen Situationen berücksichtigt. Diese umfassen strukturelle, organisatorische, rechtliche und soziale Rahmenbedingungen, die das pflegerische Handeln beeinflussen. Die Kontextbedingungen wirken sich sowohl auf die Handlungsanlässe, das Erleben, Deuten und Verarbeiten der beteiligten Personen und die Anwendung des Pflegeprozesses aus. Durch die Verknüpfung dieser Elemente, individuelle Wahrnehmungen, pflegerische Handlungsmuster und situative Gegebenheiten wird die Kompetenzentwicklung ermöglicht. Die Auszubildenden lernen, pflegerische Entscheidungen nicht nur fachlich fundiert, sondern auch im Einklang mit den jeweiligen Kontextbedingungen und den subjektiven Erlebnissen der beteiligten Personen zu treffen. Damit wird eine zunehmende Komplexitätssteigerung im Lernprozess sichergestellt, die eine realitätsnahe Vorbereitung auf die berufliche Praxis ermöglicht.
Handlungsmuster	Die Handlungsmuster leiten sich aus den Zielen der Ausbildung (§ 5 PflBG) und insbesondere aus den vorbehaltenen Tätigkeiten (§ 4 PflBG) ab. Pflegehandlungen sind analog zum Pflegeprozess beschrieben. In den Handlungsmustern und berufstypischen Situationen werden die Kompetenzen aus den Anlagen 1 bis 2 der PflAPrV situationsspezifisch weiter konkretisiert und auf die jeweiligen Module der Lernfelder ausgerichtet. Der Pflegeprozess als zentrale berufsspezifische Arbeitsmethode bildet dabei die strukturelle Grundlage und spiegelt sich konsequent in den Handlungsmustern wider. In Verbindung mit den Handlungsanlässen und dem Erleben, Deuten und Verarbeiten der beteiligten Personen ermöglicht dies eine ganzheitliche Betrachtung pflegerischer Situationen. So wird neben der Kompetenzorientierung, auch die Fähigkeit entwickelt, individuelle Perspektiven zu erkennen, zu verstehen und in den professionellen Handlungsprozess zu integrieren.

Inhaltliche Bezugspunkte	Die Bezugspunkte sind als mögliche Inhalte zu verstehen, wobei Inhalte im Rahmen exemplarischen Lernens stets sekundär zu betrachten sind. Im Mittelpunkt des Unterrichts stehen nicht die Inhalte selbst, sondern primär die zu erwerbenden Kompetenzen und Lernziele. Die Inhaltlichen Bezugspunkte resultieren aus den fachdidaktischen Analysen.
Methodische Anregungen	Die Anregungen für das Lernen in simulativen Lernumgebungen sind als methodische Empfehlungen für Übungen im Rahmen der theoretischen Ausbildung zu verstehen. Die Anregungen für Lern- und Arbeitsaufgaben für die Pflegepraxis sind als methodische Empfehlungen für eine gelingende Verknüpfung theoretischer und praktischer Ausbildungsanteile zu verstehen.
Didaktischer Kommentar	Im Didaktischen Kommentar werden Empfehlungen für Lernsituationen gegeben, die im Rahmen dieser curricularen Einheit bearbeitet werden können und die die o.a. Handlungsmuster konkretisieren. Außerdem wird hier die Grenze der curricularen Einheit zu weiterführenden Lernangeboten während und ggf. nach der Ausbildung aufgezeigt.
Theorie-Praxis-Transfer	Der Theorie-Praxis-Transfer verdeutlicht, wie Übungen im SkillsLab oder Demonstrationsraum sowie Maßnahmen zur Ergebnissicherung gezielt zur Förderung der angestrebten Kompetenzen eingesetzt werden können
Literatur	Hier wird die u.a. die verwendete Literatur zur fachdidaktischen Analyse angegeben, Literaturempfehlungen zur Unterrichtsvorbereitung. Alternativ werden auch Links zur Unterrichtsgestaltung zu Videos und Podcasts aufgeführt. Die Steuerungsgruppe ist bemüht die Links auf dem aktuellen Stand/Verfügbarkeit zu halten. Die Steuerungsgruppe nimmt Hinweise gern entgegen.
Weiterführende Informationen	Weitere Inhalte/Wissensgrundlagen sind solche, die nicht unmittelbar aus der Handlungssituationen hervorgehen, für die umfassende Bewältigung der berufstypischen aber relevant bzw. hilfreich sind.
Material	Hier wird aufgeführt welches Material (neben Moderationsmaterial und sonstigen) für das jeweilige Modul benötigt wird. Auch Materialien für Lernsituationen im SkillsLab oder anderweitiges Material.
Fall	

8 Literaturverzeichnis

Beyer, S., Bielefeldt, B., Freese, C., Hundenborn, G., Junggeburth-Preuß, A., Kaiser, B., Kleine, A., Lützler, A., Machleit, U., Steguweit, S., Sutschkow, T., Wiederhold, P. (2024). Curriculare Qualität weiterentwickeln – Ein Evaluationskonzept für schulinterne Curricula und trägerspezifische Ausbildungspläne im Kontext der Pflegeberufereform. Zugriff am 30.06.2025. Verfügbar unter: Curriculare Qualität weiterentwickeln – Ein Evaluationskonzept für schulinterne Curricula und trägerspezifische Ausbildungspläne im Kontext der Pflegeberufereform

Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.) (2020). Begleitmaterialien zu den Rahmenplänen der Fachkommission nach § 53 PflBG: 1. Auflage. Bonn: BIBB - Direktvertrieb

Erpenbeck, J. & von Rosenstiehl, L. (Hrsg.) (2003). Handbuch Kompetenzmessung : Erkennen, verstehen und bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und psychologischen Praxis. Stuttgart : Schäffer-Poeschel.

Kirkevold, M. (2002): Pflegewissenschaft als Praxisdisziplin. Bern: Huber.

Laußer, Angela M., 2023. Pflegekompetenz [online]. socialnet Lexikon. Bonn: socialnet, 10.08.2023 [Zugriff am: 02.05.2024]. Verfügbar unter: https://www.socialnet.de/lexikon/28134

Olbrich, C. (2023): Kompetenzbasiertes Lehren und Lernen – Neue Wege in der Pflegeausbildung. 1. Auflage. München: Elsevier.

Saul, S. & Jürgensen, A. (2021): Handreichung für die Pflegeausbildung am Lernort Pflegeschule. Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.). 1. Auflage. Bonn.

Weyland, U., Wittmann, E., Kaufhold, M. (2022). Herausforderungen in Bezug auf Konstrukt und Erfassbarkeit von beruflicher Handlungskompetenz im Gesundheitsbereich. In: Darmann-Finck, I., Sahmel, KH. (eds) Pädagogik im Gesundheitswesen. Springer Reference Pflege – Therapie – Gesundheit . Springer, Berlin,

Wieteck, P. (Hrsg.) (2023): ENP-Praxisleitlinien. 4. Auflage.

9 Anlagen

9.1 Abgleich curriculare Einheiten (CE) nach Rahmenlehrplan der Fachkommission §53PflBG und Lernfelder im Curriculum

		CE – curriculare Einheit nach Rahmenlehrplan										
Lernfelder		**CE 01**	**CE 02**	**CE 03**	**CE 04**	**CE 05**	**CE 06**	**CE 07**	**CE 08**	**CE 09**	**CE 10**	**CE 11**
LF 01	Ausbildungsstart	40										
LF 02	Lernen	20								60 / 20		
LF 03	Eigene Gesundheit			40	20 / 20							
LF 04	Berufsverständnis			40				40				
LF 05	Pflegesysteme					40 / 20						
LF 06	Digital	10							20	30		
LF 07	Prävention				40 / 20							
LF 08	Sicherheit					40	60 / 60					
LF 09	Diversity									60 / 30		
LF 10	Kuration					120 / 120					20 / 10	
LF 11	Disability							80 / 40			20 / 10	
LF 12	Schwangerschaft										20 / 10	
LF 13	Chronisch				20 / 40				60 / 20			
LF 14	Selbstpflege		180								20	
LF 15	Psych.											80 / 80
LF 16	Krisen								70 / 20		20 / 20	
LF 17	Palliativ								30 / 30		20 / 10	
Summe 1/ 2. AD (Anl.1 PflAPrV)		70 /70	180/180	80/80	80/80	200/200	60/60	80/80	160/160	150/150	120/120	80/80
Summe 3. AD (Anl. 2 PflAPrV)					80/80	140/140	60/60	80/80	90/90	50/50	60/60	80/80
Gesamtstunden /Vorgaben RLP		70/70	180/180	80/80	160/160	340/340	120/120	160/160	250/250	200/200	180/180	160/160

9.2 Abgleich Lernfelder und Kompetenzbereiche I-V nach Anlage 6 PflAPrV im 1. und 2. AD

	KB I - Pflegeprozess																																
	680																																
	KS I.1									KS I.2							KS I.3					KS I.4			KS I.5				KS I.6				
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	a	b	c	d	e	f	g	a	b	c	d	e	a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	e
LF 01 Ausbildungsstart								x																					x				
LF 02 Lernprozess																																	
LF 03 Eigene Gesundheit																																	
LF 04 Berufsverständnis								x																									
LF 05 Pflegesysteme	x	x	x	x	x	x	x	x	x																								
LF 06 Digitales							x		x																x	x	x		x			x	
LF 07 Prävention	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													x			x	
LF 08 Sicherheit			x	x		x			x						x	x						x	x	x									
LF 09 Vielfalt							x																		x	x	x	x	x			x	
LF 10 Akute Gesundheitsprobleme	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x									x							x	
LF 11 Disability		x	x	x	x					x	x	x													x				x	x	x	x	x
LF 12 Schwangerschaft											x														x								
LF 13 Chronische	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									x			x	
LF 14 Selbstpflegedefizit	x	x	x	x	x	x	x			x	x				x	x									x				x			x	x
LF 15 Psych	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x											x				
LF 16 Krisen & akute Belastung				x	x	x			x	x	x		x		x	x		x	x	x					x				x			x	
LF 17 Palliativ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x				x				x			x	

	KB II - Kommunikation													KB III - Zusammenarbeit																
	200													200																
	KS II.1							KS II.2			KS II.3			KS III.1					KS III.2					KS III.3					
	a	b	c	d	e	f	g	a	b	c	a	b	c	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f
LF 01 Ausbildungsstart				x								x						x											
LF 02 Lernprozess											x	x					x												
LF 03 Eigene Gesundheit	x	x		x											x														
LF 04 Berufsverständnis		x	x	x	x		x								x														
LF 05 Pflegesysteme				x	x																						x		x
LF 06 Digitales					x																			x					
LF 07 Prävention				x				x	x	x						x													
LF 08 Sicherheit		x	x	x	x								x						x	x	x	x	x						
LF 09 Vielfalt		x			x																								
LF 10 Akute Gesundheitsprobleme	x	x		x	x				x										x	x	x	x					x		
LF 11 Disability	x	x						x	x			x		x	x				x	x				x	x	x	x		x
LF 12 Schwangerschaft								x											x										
LF 13 Chronische	x	x		x				x	x	x	x		x	x	x	x				x		x				x		x	
LF 14 Selbstpflegedefizit	x	x	x		x			x			x			x			x		x										
LF 15 Psych	x	x	x	x	x	x	x	x													x	x				x			
LF 16 Krisen & akute Belastung	x	x		x							x		x	x	x					x		x							
LF 17 Palliativ	x	x		x							x		x	x	x					x		x						x	

	KB IV - Recht							KB V - Pflegewissenschaft									
	80							100									
	KS IV.1		KS IV.2					KB V.1			KB V.2						
	a	b	a	b	c	d	e	a	b	c	a	b	c	d	e	f	g
LF 01 Ausbildungsstart			x											x	x		
LF 02 Lernprozess										x	x		x				
LF 03 Eigene Gesundheit									x		x	x	x	x	x		
LF 04 Berufsverständnis														x			
LF 05 Pflegesysteme																	
LF 06 Digitales						x										x	x
LF 07 Prävention				x	x		x		x	x							
LF 08 Sicherheit	x	x										x	x				
LF 09 Vielfalt																x	
LF 10 Akute Gesundheitsprobleme	x	x					x	x	x	x							
LF 11 Disability		x						x	x	x							
LF 12 Schwangerschaft										x							
LF 13 Chronische		x		x			x		x	x		x	x				
LF 14 Selbstpflegedefizit		x	x					x		x		x	x				
LF 15 Psych					x							x	x				
LF 16 Krisen & akute Belastung		x						x		x		x	x				
LF 17 Palliativ		x		x			x	x	x	x		x	x				

9.3 Abgleich Lernfelder und Kompetenzbereiche I-V nach Anlage 6 PflAPrV im 3. AD

	KB I - Pflegeprozess																																
	320																																
	KS I.1									KS I.2						KS I.3						KS I.4			KS I.5				KS I.6				
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f	a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	e
LF 02 Lernprozess																																	
LF 03 Eigene Gesundheit																																	
LF 04 Berufsverständnis													x		x																		
LF 05 Pflegesysteme																																	
LF 06 Digitales		x				x	x		x	x	x																						
LF 07 Gesundheit fördern		x	x		x	x			x		x			x	x														x				
LF 08 Sicherheit				x																		x	x	x					x				
LF 09 Vielfalt							x		x																x	x	x	x				x	x
LF 10 Akute Gesundheitsprobleme	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x				x															x
LF 11 Disability	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x							x	x				x	x	x	
LF 12 Schwangerschaft														x																			
LF 13 Chronische	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x				x											x			x	
LF 15 Psych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x													x			x	
LF 16 Krisen & akute Belastung		x	x	x	x	x			x	x				x			x	x	x	x	x												
LF 17 Palliativ		x	x	x	x	x	x		x					x	x	x	x	x	x	x	x								x				

	KB II - Kommunikation														KB III - Zusammenarbeit																	
	80														100																	
	KS II.1							KS II.2				KS II.3			KS III.1						KS III.2						KS III.3					
	a	b	c	d	e	f	g	a	b	c	d	a	b	c	a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f
LF 02 Lernprozess																x		x														
LF 03 Eigene Gesundheit																				x									x			
LF 04 Berufsverständnis												x																x	x			x
LF 05 Pflegesysteme																																
LF 06 Digitales																																
LF 07 Gesundheit fördern																																
LF 08 Sicherheit		x	x										x	x								x										
LF 09 Vielfalt		x			x								x		x		x		x								x					
LF 10 Akute Gesundheitsprobleme				x			x	x	x	x	x		x			x	x				x	x	x	x	x	x	x				x	x
LF 11 Disability			x		x		x	x		x	x	x														x	x	x	x	x	x	x
LF 12 Schwangerschaft									x			x																				
LF 13 Chronische	x	x		x				x	x	x	x				x		x		x					x							x	
LF 15 Psych	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x												x		x	x	x		
LF 16 Krisen & akute Belastung						x																x				x		x				
LF 17 Palliativ	x											x		x	x							x										

	KB IV - Recht									KB V - Pflegewissenschaft										
	160									160										
	KS IV.1				KS IV.2					KB V.1				KB V.2						
	a	b	c	d	a	b	c	d	e	a	b	c	d	a	b	c	d	e	f	g
LF 02 Lernprozess			x									x		x						
LF 03 Eigene Gesundheit									x						x	x				
LF 04 Berufsverständnis	x					x		x		x							x	x		x
LF 05 Pflegesysteme	x	x		x	x				x			x								
LF 06 Digitales		x		x																
LF 07 Gesundheit fördern						x	x							x				x	x	
LF 08 Sicherheit															x	x				
LF 09 Vielfalt																				
LF 10 Akute Gesundheitsprobleme		x		x	x					x	x	x						x		
LF 11 Disability	x	x		x		x		x												
LF 12 Schwangerschaft																				
LF 13 Chronische		x		x		x	x		x		x	x								
LF 15 Psych			x			x							x			x	x			
LF 16 Krisen & akute Belastung		x		x										x	x	x	x			
LF 17 Palliativ		x				x			x				x		x	x				

Abb. A: Pflegediagnose „Ängste/Sorgen/Schuldgefühle in Verbindung mit einer eingeschränkten Religions-/Glaubensausübung“

9.4 Exemplarische Darstellung der spiralförmigen curricularen Konstruktion

Abb. A: Pflegediagnose „Ängste/Sorgen/Schuldgefühle in Verbindung mit einer eingeschränkten Religions-/Glaubensausübung"

09-A in Bewusstsein für kulturelle Vielfalt entwickeln (1. AD)

- **Kompetenzentwicklungsstufe (Olbrich):** Regelgeleitetes Handeln
- **Situationstyp (Kirkevold):** unproblematische Pflegesituation
- **Lernziel:** Entwickeln ein erstes pflegerisches Verständnis für die Bedeutung von kultureller Vielfalt im Rahmen der Pflegeprozessgestaltung.
- **Situation:** Akut erkrankte Mutter möchte an der Erstkommunion ihres Sohnes teilnehmen.
- **Handlungsanlässe (Pflegediagnose):**
  - Nermina Tastan hat Ängste/Sorgen/Schuldgefühle in Verbindung mit einer eingeschränkten Religions-/Glaubensausübung.

09-F Kulturelle Gewohnheiten bei Menschen mit eingeschränkter Selbstbestimmung ermöglichen (2. AD)

- **Kompetenzentwicklungsstufe (Olbrich):** Situativ-Beurteilendes Handeln
- **Situationstyp (Kirkevold):** problemidentifizierende Pflegesituation
- **Lernziel:** Nutzen ihr Wissen über die Bedeutung von kulturellen Gewohnheiten im Rahmen der Pflegeprozessgestaltung bei Menschen mit eingeschränkter Selbstbestimmung.
- **Situation:** 8 jähriges Kind mit Hämophilie wird aufgrund von tradierten Glaubensgrundsätzen mit Talisman und Kräutern behandelt. Hat wiederholt schmerzhafte Einblutungen nach leichten Stößen oder Stürzen. Möchte gerne Sport treiben.
- **Handlungsanlässe (Pflegediagnosen):**
  - Lászlo Sarközi hat das Risiko eines hämorrhagischen Schocks aufgrund einer unbehandelten Hämophilie.
  - Lászlo Sarközi hat das Risiko der unwirksamen Therapie aufrgund mangelnder Entscheidungsfähigkeit.
  - Lászlo Sarközi hat Ängste/Sorgen/Schuldgefühle in Verbindung mit einer eingeschränkten Glaubensausübung.
  - Dorina Sarközi (Mutter) kann aufgrund fehlender Informationen/Fertigkeiten die Dependenzpflege nicht selbstständig durchführen.

09-J Kultursensible Pflege verantwortlich und umfassend gestalten (3. AD)

- **Kompetenzentwicklungsstufe (Olbrich):** Reflektierendes Handeln
- **Situationstyp (Kirkevold):** problematische Pflegesituation
- **Lernziel:** Gestalten den Pflegeprozess von Menschen mit Kommunikationsbarrieren kultursensibel und stimmen die Pflegeprozessgestaltung in qualifikationsheterogenen Pflegeteams ab.
- **Situation:** Migriertes Kind mit schwerer Maserinfektion bei fehlendem Impfschutz aufgrund tradierter Glaubensmuster. Kind spricht nur L1 und kann seine Bedürfnisse nicht mitteilen. Mutter nur selten anwesend und hoch belastet, da die Großmutter lebenslimitierend erkrankt ist und sich in palliativer Versorgung am Lebensende befindet.
- **Handlungsanlässe (Pflegediagnosen):** Lászlo Sarközi...
  - hat Pyrexie (Fieber), es besteht das Risiko von Komplikationen.
  - hat aufgrund eines Venenkatheters /einer Infusionstherapie das Risiko von Komplikationen.
  - hat aufgrund von Pruritus (Juckreiz) ein beeinträchtigtes Wohlbefinden.
  - empfindet die eigene Freizeitgestaltung als unbefriedigend.
  - kann eigene Wünsche/ Belange/Interessen nicht zum Ausdruck bringen, es besteht das Risiko unerfüllter Bedürfnisse.
  - lehnt die Nahrungsaufnahme ab , es besteht das Risiko einer Mangelernährung.
  - Dorina Sarközi (Mutter) hat Schuldgefühle in Verbindung mit einer eingeschränkten Glaubensausübung.

Abb. B: Pflegediagnose „Risiko der Keimübertragung“

10 B Menschen mit Pflegebedarf bei Beeinträchtigung der Atmung kurativ unterstützen (1. AD)

- **Kompetenzentwicklungsstufe (Olbrich):** Regelgeleitetes Handeln
- **Situationstyp (Kirkevold):** unproblematische Pflegesituation
- **Lernziel:** Kennen Grundlagen der Infektionsprävention und deren Anwendungsgebiete. Können entsprechend relevante pflegebezogene Daten erheben.
- **Situation:** Junge Frau hat COVID-19, ihr Sohn möchte sie besuchen, hat aber ein besonderes Risiko wegen Grunderkrankung Asthma bronchiale. Beide benötigen Anleitung im Umgang mit Schtzkleidung.
- **Handlungsanlässe (Pflegediagnose):**
  - **Nermina Tastan** hat eine Infektionskrankheit , es besteht das Risiko der Keimübertragung.

10 G Menschen mit Pflegebedarf aufgrund von Infektionen kurativ unterstützen (2. AD)

- **Kompetenzentwicklungsstufe (Olbrich):** Regelgeleitetes Handeln
- **Situationstyp (Kirkevold):** problemidentifizierende Pflegesituation
- **Lernziel:** Erkennen Infektionerkrankungen und können Grundregeln der Infektionsprävention für Wohneinrichtungen anwenden. Kennen Pflichten zur Dokumentation und Informationsweitergabe.
- **Situation:** Älterer Mann und weitere Bewohner*innen einer Wohneinrichtung sind von einer Skabies-Infektion betroffen. Es müssen umfassende Maßnahmen zum Infektionsschutz getroffen werden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.
- **Handlungsanlässe (Pflegediagnosen):**
  - **Karl-Heinz Schäfer**
    - hat eine Infektionskrankheit , es besteht das Risiko der Parasitenübertragung.
    - hat aufgrund von Pruritus (Juckreiz) ein beeinträchtigtes Wohlbefinden.
    - ist in der Selbstpflegefähigkeit beeinträchtigt , es besteht ein Informationsdefizit/fehlende Fähigkeiten

14 X Menschen mit infektiösen Erkrankungen in gemeinschaftlichen Wohnformen betreuen (2. AD)

- **Kompetenzentwicklungsstufe (Olbrich):** Situativ-Beurteilendes Handeln
- **Situationstyp (Kirkevold):** problematische Pflegesituation
- **Lernziel:** Wenden Hygienestandards unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse der zu pflegenden Menschen in Einrichtungen der stationären Langzeitpflege an.
- **Situation:** Dementiell veränderte älötere Frau hat (stark infektiöse) Konjunktivitis epidemica und kann Infektionsschutzmaßnahmen für das Umfeld nicht umsetzen.
- **Handlungsanlässe (Pflegediagnosen):**
- **Bärbel Fuchs**
  - hat eine Infektionskrankheit , es besteht das Risiko der Keimübertragung.
  - hat akute Schmerzen.
  - ist in der Selbstpflegefähigkeit beeinträchtigt , es besteht ein Informationsdefizit/fehlende Fähigkeiten.
  - hat aufgrund einer Orientierungsstörung das Risiko der Selbst-/Fremdgefährdung.

10-O Menschen mit akut neurologischem Defizit in ihrer Autonomie unterstützen (3. AD)

- **Kompetenzentwicklungsstufe (Olbrich):** Situativ-Beurteilendes Handeln
- **Situationstyp (Kirkevold):** akute Pflegesituation
- **Lernziel:** Können Pflegeprozesse unter Einbezug von Bezugspersonen auf den individuellen Entwicklungsstand anpassen. Finden dabei Ansatzpunkte für gemeinsame Entscheidungsprozesse. Agieren selbstsicher im interprofessionelle Team, um die Qualität der Versorgung kontinuierlich zu verbessern.
- **Situation:** Jugendlicher mit bakterieller Meningitis und Orientierungsstörung verhält sich fremdaggressiv.
- **Handlungsanlässe (Pflegediagnosen):**
- **Henrik Kirschmann**
  - hat eine Infektionskrankheit , es besteht das Risiko der Keimübertragung.
  - hat akute Schmerzen.
  - hat Pyrexie (Fieber), es besteht das Risiko von Komplikationen.
  - hat aufgrund eines Venenkatheters /einer Infusionstherapie das Risiko von Komplikationen.
  - hat aufgrund einer Überempfindlichkeit gegenüber äußeren Reizen das Risiko von unerwünschten/unangenehmen Empfindungen/Reaktionen
  - hat aufgrund einer Orientierungsstörung das Risiko der Selbst-/Fremdgefährdung.

Abb. C: Pflegediagnose „Risiko der Mangelernährung“

07-A Gesundheitsförderung und Prävention als Anspruch und Ziel des Pflegeberufs erfassen (1. AD)

- **Kompetenzentwicklungsstufe (Olbrich):** Regelgeleitetes Handeln
- **Situationstyp (Kirkevold):** unproblematische Pflegesituation
- **Lernziel:** Kennen adäquate Möglichkeiten, um das Risiko einer Mangelernährung zu identifizieren und Maßnahmen zur Sicherstellung der oralen Ernährung.
- **Situation:** Dementiell veränderte, hochbetagte Frau lehnt wiederholt die Nahrungsaufnahme aus Angst ab, diese nicht bezahlen zu können (interpretiert Speiseraum in Wohneinrichtung als Restaurant).
- **Handlungsanlässe (Pflegediagnosen):**
  - **Heidi Berg** hat ein Risiko der Mangelernährung.

14-M Menschen bei der Nahrungsaufnahme bedarfsgerecht unterstützen (2. AD)

- **Kompetenzentwicklungsstufe (Olbrich):** Situativ-Beurteilendes Handeln
- **Situationstyp (Kirkevold):** problemidentifizierende Pflegesituation
- **Lernziel:** Können personenzentriert Nahrung anreichen und eine Aspirationsprophalyxe durchführen.
- **Situation:** Jugendlicher mit Muskeldystrophie benötigt Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme, lehnt diese aber konsequent ab (will nicht pflegeabhängig sein).
- **Handlungsanlässe (Pflegediagnosen):**
  - **Samuel Goldstein**
    - hat ein Risiko der Mangelernährung.
    - ist in der Fähigkeit beeinträchtigt, sich veränderten Lebensumständen anzupassen.

10-S Menschen mit eingeschränkter Kommunikation, Atmung und Dysphagie bei Diagnostik und Therapie unterstützen (3. AD)

- **Kompetenzentwicklungsstufe (Olbrich):** Reflektierendes Handeln
- **Situationstyp (Kirkevold):** problematische Pflegesituation
- **Lernziel:** Können Menschen mit Dysphagie fachgerecht, ganzheitlich und unter Einbindung aller Beteiligten versorgen sowie die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen organisieren. Reflektieren, wie sie zur kontinuierlichen Verbesserung des Versorgungsprozesses beitragen können.
- **Situation:** Erwachsener Mann (politoxikoman) wird wegen Husten, Schluckbeschwerden und Dyspnoe ins Klinikum gebracht. Dort Diagnose: Larynx-Ca. Es folgen Laryngektomie und Tracheostoma-Anlage.
- **Handlungsanlässe (Pflegediagnosen):**
  - **Stefan Bolte**
    - hat ein Risiko der Mangelernährung.
    - ist in der Fähigkeit beeinträchtigt, sich an den veränderten Gesundheitszustand anzupassen.
    - hat das Risiko einer Aspiration.
    - hat aufgrund einer liegenden Trachealkanüle/eines Tubus das Risiko der Pneumonie.
    - hat aufgrund einer liegenden Trachealkanüle/ eines Tubus das Risiko einer Komplikation (Manipulation).
    - hat aufgrund eines angelegten Tracheostomas das Risiko einer Hautschädigung.
    - hat aufgrund des Verlanges, Substanzen mit Abhängigkeitspotenzial zu konsumieren, das Risiko eines Rückfalls.